

Buku Ajar
**KEPERAWATAN
PSIKIATRI**

Muhammad Khoirul Amin • Tsuwaibatul Islamiyah • Safra Ria Kurniati
Indana Lazulfa • Mamnuah • Abdul Ghofur
Susana Nurtanti



BUKU AJAR: KEPERAWATAN PSIKIATRI

Penulis:

Ns. Muhammad Khoirul Amin, M.Kep., Sp.Kep.J.

Tsuwaibatul Islamiyah, S.Kep., Ns., M.S.

Ns. Safra Ria Kurniati, M.Kep.

Ns. Indana Lazulfa, S.Kep., M.Kep.

Dr. Ns. Mamnuah, M.Kep. Sp.Kep.J.

Dr. Abdul Ghofur, SKp., M.Kes.

Susana Nurtanti, S.Kep., Ns., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Ajar: Keperawatan Psikiatri

Penulis: Ns. Muhammad Khoirul Amin, M.Kep., Sp.Kep.J.

Tsuwaibatul Islamiyah, S.Kep., Ns., M.S.

Ns. Safra Ria Kurniati, M.Kep.

Ns. Indana Lazulfa, S.Kep., M.Kep.

Dr. Ns. Mamnuah, M.Kep. Sp.Kep.J.

Dr. Abdul Ghofur, SKp., M.Kes.

Susana Nurtanti, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syauckani, S.Pd.

ISBN: 978-623-89972-0-6

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Keperawatan Psikiatri" ini dapat disusun dengan baik dan lancas. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan referensi yang komprehensif dan aplikatif bagi mahasiswa, dosen, praktisi keperawatan jiwa, serta profesional kesehatan lainnya yang tertarik untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan psikiatri.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai pembahasan esensial tentang keperawatan jiwa yang disusun secara sistematis. Diawali dengan pembahasan tentang asuhan keperawatan untuk klien dengan masalah harga diri rendah dan isolasi sosial, hingga klien yang mengalami waham dan halusinasi, serta mereka yang mengalami defisit perawatan diri. Setiap topik disajikan dengan pendekatan yang mudah dipahami serta didukung dengan teori-teori terkini dan implementasi praktis yang berbasis bukti.

Tidak hanya terbatas pada aspek klinis, buku ini juga memperkenalkan konsep recovery yang menekankan karakteristik pemulihan klien secara holistik, disertai penjelasan tentang model dan pentingnya lingkungan yang suportif. Selanjutnya, pembaca juga diajak memahami lebih dalam mengenai berbagai terapi modalitas yang dapat diaplikasikan kepada pasien gangguan jiwa, yang mencakup pendekatan-pendekatan terapeutik inovatif dan terbukti efektif.

Melengkapi semua itu, buku ini juga membahas manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional di klinik maupun komunitas, dengan tujuan memberikan panduan yang komprehensif dalam mengelola layanan kesehatan mental secara efisien dan efektif, serta mampu merespons tantangan-tantangan yang ada di lapangan.

Harapan kami, kehadiran buku ini mampu menjadi pedoman berharga dalam meningkatkan kompetensi profesional, memperkaya wawasan, serta menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Mei, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI HARGA DIRI

RENDAH DAN ISOLASI SOSIAL	1
A. Harga Diri Rendah	3
B. Isolasi Sosial	12
C. Latihan	18
D. Kunci Jawaban	19
E. Rangkuman Materi	20
F. Glosarium	20
G. Daftar Pustaka	20

BAB 2 ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI WAHAM

DAN HALUSINASI	23
A. Pengertian Waham.....	25
B. Proses/Tahapan Terjadinya Waham	25
C. Jenis-jenis Waham	25
D. Tanda dan Gejala Waham.....	27
E. Rentang Respon Waham	27
F. Faktor Predisposisi dan Faktor Presipitasi Munculnya Waham.....	28
G. Penatalaksanaan Waham.....	29
H. Asuhan Keperawatan Klien Dengan Waham	30
I. Pengertian Halunisasi	35
J. Proses Terjadinya Halusinasi	35
K. Jenis-jenis Halusinasi beserta tanda gejalanya	37
L. Rentang Respons Neurobiologi.....	38
M. Penatalaksanaan Halusinasi	39
N. Asuhan Keperawatan Klien Dengan Halusinasi	39
O. Latihan Soal	46
P. Latihan Kasus	47
Q. Kunci Jawaban	48
R. Rangkuman.....	50
S. Glosarium	51
T. Daftar Pustaka	52

BAB 3 ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI DEFISIT

PERAWATAN DIRI.....	55
A. Pengertian Defisit Perawatan Diri.....	57
B. Teori Self-care Deficit Orem	58
C. Penyebab Defisit Perawatan Diri dalam Konteks Gangguan Jiwa.....	60
D. Tanda dan Gejala Defisit Perawatan Diri	61
E. Kondisi Klinis Defisit Perawatan Diri.....	61
F. Asuhan Keperawatan Defisit Perawatan Diri.....	62
G. Latihan	66
H. Kunci Jawaban.....	68
I. Rangkuman Materi	68
J. Glosarium	69
K. Daftar Pustaka	69

BAB 4 ASUHAN KEPERAWATAN JIWA KLIEN DAN KELUARGA AKIBAT

COVID 19 DAN PENYAKIT KRONIS HIV AIDS.....	71
A. Asuhan Keperawatan Jiwa Klien dan Keluarga Akibat Covid 19.....	73
B. Asuhan Keperawatan Jiwa Klien dan Keluarga Akibat penyakit kronis HIV AIDS	84
C. Latihan Soal	94
D. Kunci Jawaban.....	95
E. Rangkuman Materi.....	96
F. Daftar Pustaka	97

BAB 5 KONSEP RECOVERY: KARAKTERISTIK RECOVERY, MODEL DAN

SUPPOTIVE ENVIRONMENT	100
A. Konsep <i>Recovery</i>	102
B. Karakteristik <i>Recovery</i>	102
C. Model dan <i>Supportive Environment</i>	103
D. Penutup.....	106
E. Latihan	106
F. Kunci Jawaban.....	107
G. Rangkuman Materi	108
H. Glosarium	108
I. Daftar Pustaka	108

BAB 6 TERAPI MODALITAS PASIEN GANGGUAN JIWA

A. Permasalahan yang terjadi dalam Penerapan Terapi Modalitas.....	113
B. Bentuk dan Peran Terapi Modalitas dalam Membantu Adaptasi Pasien	114
C. Terapi Modalitas Psikofarmaka	116
D. Hubungan Terapi Psikofarmaka dengan Adaptasi Pasien	118

E. Jenis Psikofarmaka untuk Skizofrenia	118
F. Terapi Psikofarmaka dalam Pengelolaan Skizofrenia	120
G. Peran perawat dalam pengobatan psikofarmaka	121
H. Terapi Individu pada Pasien Gangguan Jiwa	121
I. Terapi Kelompok	124
J. Electroconvulsive <i>Therapy</i>	131
K. Psychotherapy (<i>Talk Therapy</i>)	132
L. Latihan	133
M. Kunci Jawaban	136
N. Rangkuman Materi	136
O. Glosarium	136
P. Daftar Pustaka	138

BAB 7 MANAJEMEN PELAYANAN KEPERAWATAN JiWA PROFESIONAL

DI KLINIK DAN KOMUNITAS 142

A. Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa	144
B. Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa di Klinik	145
C. Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa di Komunitas	147
D. Keterampilan Manajerial dalam Keperawatan Jiwa	148
E. Evaluasi Efektivitas Pelayanan Keperawatan Jiwa	149
F. Kolaborasi Interprofesional dan Komunitas	151
G. Tantangan dan Solusi dalam Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa	153
H. Tugas	154
I. Latihan Soal	156
J. Rangkuman materi	158
K. Glosarium	160
L. Daftar pustaka	162

PROFIL PENULIS 165

BAB 1

ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI HARGA DIRI RENDAH DAN ISOLASI SOSIAL

Pendahuluan:

Harga diri merupakan aspek penting dalam kesehatan mental dan emosional seseorang. Ketika harga diri seseorang rendah, perasaan tidak berharga, cemas, dan tidak mampu sering kali muncul, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup mereka. Salah satu dampak dari harga diri yang rendah adalah isolasi sosial, di mana individu merasa terasing dari orang lain dan enggan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya.

Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, perawat memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pasien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial. Dalam kapasitasnya, perawat bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan, termasuk memberikan dukungan emosional dan psikososial yang dibutuhkan pasien. Perawat dapat menjadi figur yang memberi rasa aman, mendengarkan dengan empati, serta menawarkan intervensi yang membantu pasien mengatasi perasaan terisolasi dan meningkatkan harga diri mereka.

Pada BAB ini akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial yang meliputi definisi, rentang respon, penyebab, penatalaksanaan dan asuhan keperawatannya. Pada kesempatan ini antara harga diri rendah dan isolasi sosial akan kami pisahkan menjadi 2 topik utama dan dari masing-masing topik utama tersebut akan kami turunkan menjadi sub-bab sesuai topik.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan konsep tentang Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial
- Menjelaskan rentang respon Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial
- Menjelaskan penyebab Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial

- Menjelaskan tanda dan gejala Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial
- Menjelaskan penatalaksanaan pada pasien Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial
- Menjelaskan Asuhan Keperawatan pada pasien Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial

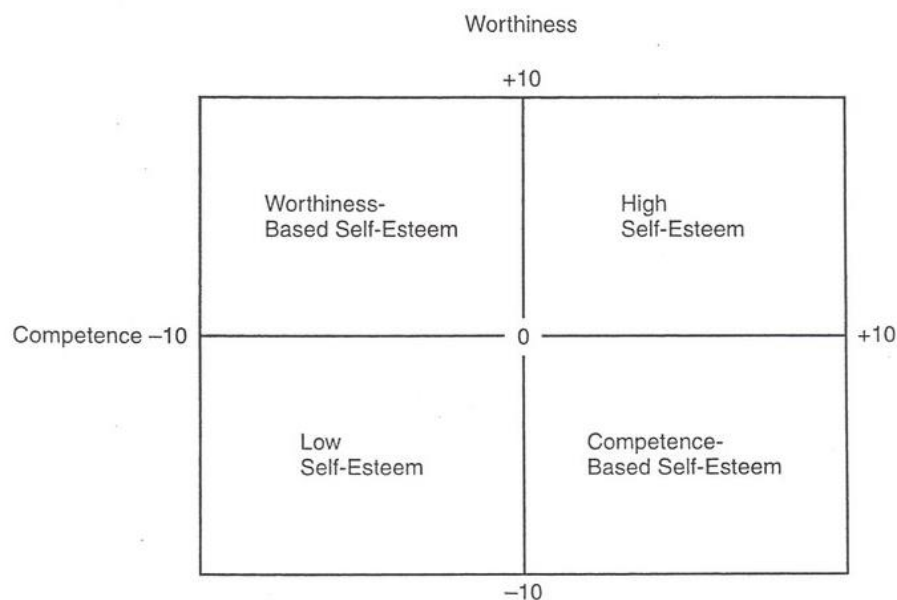
Uraian Materi

A. Harga Diri Rendah

1. Definisi

Harga diri merupakan penilaian subjektif individu terhadap harga dirinya. Harga diri mencakup keyakinan tentang diri sendiri serta keadaan emosional, seperti kemenangan, keputusan, kebanggaan, dan rasa malu. Harga diri sendiri melibatkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan citra diri. Di sisi lain, harga diri juga membentuk cara berpikir, yang menyebabkan perubahan sikap seseorang apakah akan berdampak positif atau negatif, bahkan dapat menjadi standar kegagalan dan keberhasilan.

Menurut (Mruk, 2006) ada beberapa tipe dasar harga diri dan terdapat matrik untuk memahami tipe-tipe tersebut. Matrik tersebut yaitu:



Gambar 1.1 Matrik Harga diri

a. High Self-Esteem

Berdasarkan matriks di atas, mereka yang memiliki harga diri tinggi biasanya menunjukkan tingkat kompetensi dan harga diri yang positif. Dalam hal ini, orang yang merasa memiliki harga diri yang tinggi akan merasa baik tentang diri mereka sendiri secara umum, terbuka terhadap pengalaman baru, merasa diterima dan dapat diterima, merasa senang berada di sekitar dan sebagainya. Orang yang memiliki kompetensi tinggi cenderung memiliki keterampilan dan melakukan aktivitas yang akan mengarah pada keberhasilan.

b. Competence-Based Self-Esteem

Seorang individu dengan harga diri berbasis kompetensi cenderung berfokus pada hal-hal di luar daripada di dalam karena kompetensi melibatkan

manifestasi kemampuan atau keberhasilan yang sebenarnya. Pada kelompok ini menggambarkan tingkat kompetensi yang tinggi, tetapi tidak memiliki rasa harga diri. Seseorang dengan tipe ini akan berusaha keras untuk menyeimbangkan kurangnya rasa harga diri dengan berfokus pada kompetensi mereka. Baik harga diri berdasarkan harga diri maupun kompetensi tidaklah stabil karena keduanya kekurangan salah satu dari dua faktor. Meskipun orang dengan kedua tipe harga diri ini tampaknya memiliki harga diri yang tinggi, kekurangan satu faktor dapat menciptakan keadaan ketidakseimbangan.

c. Low Self-Esteem

Harga diri yang rendah adalah tentang menjalani hidup dengan kurangnya kompetensi dan kurangnya harga diri. Dalam harga diri yang rendah, orang tidak akan memiliki banyak perlindungan dari perisai dan mereka tidak akan siap untuk melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mendapatkan jenis keberhasilan yang mengarah pada rasa kompetensi. Kemudian, harga diri yang rendah dikaitkan dengan hal-hal seperti kehati-hatian, rasa malu, kurangnya inisiatif, konflik, penghindaran, rasa tidak aman, kecemasan, depresi, dan sebagainya.

d. Worthiness-based Self-Esteem

Harga diri berbasis kelayakan merujuk kepada orang-orang yang memiliki harga diri tinggi tanpa perilaku kompeten yang sesuai. Orang-orang dengan harga diri seperti ini melakukan hal-hal seperti meminimalkan kegagalan, menyangkal kekurangan, mengelilingi diri dengan menerima orang lain, atau percaya bahwa seseorang pantas memiliki harga diri tinggi hanya karena merasa baik tentang dirinya sendiri sebagai pribadi. Orang-orang dengan jenis harga diri ini terkadang bertindak seolah-olah mereka memiliki harga diri yang tinggi, padahal sebenarnya mereka kekurangan harga diri.

Harga diri rendah adalah evaluasi diri negatif yang berhubungan dengan perasaan yang lemah, tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh, tidak berharga, dan tidak memadai (G. W. Stuart, 2023). Harga diri rendah merupakan keadaan dimana klien merasa tidak berharga dan tidak mampu melakukan sesuatu dan berlangsung lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan gejala dan peningkatan kemampuan klien harga diri rendah kronis secara signifikan setelah diberikan tindakan keperawatan (Pardede et al., 2020).

Tim Pokja SDKI membagi 2 (dua) harga diri rendah yaitu harga diri rendah situasional dan harga diri rendah kronis. Harga diri rendah situasional merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau ketidakmampuan klien sebagai respon terhadap situasi

saat ini, sedangkan Harga diri rendah kronis merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau ketidakmampuan klien seperti tidak berarti, tidak berharga, tidak berdaya, yang berlangsung dalam waktu lama dan terus menerus (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2019)

Berdasarkan sumber-sumber tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa harga diri rendah adalah suatu perasaan negatif terhadap diri sendiri.

2. Rentang respon



Gambar 1.2 Rentang Respon Harga Diri

(G. W. Stuart, 2023) menentukan harga diri dalam beberapa rentang respon, yaitu:

a. Aktualisasi diri

Aktualisasi diri adalah pemahaman potensi diri untuk mengoptimalkan diri sendiri (D'Souza, 2018).

b. Konsep diri positif

Penilaian positif terhadap diri sendiri dalam berbagai aspek (Burns et al., 2020).

c. Harga diri rendah

Harga diri rendah adalah evaluasi diri negatif yang berhubungan dengan perasaan yang lemah, tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh, tidak berharga, dan tidak memadai (G. W. Stuart, 2023)

d. Kerancuan identitas

Kebingunan identitas berawal dari teori perkembangan Erikson pada usia remaja dimana individu belum mengetahui identitas atau jati dirinya. Kerancuan atau kebingunan identitas yaitu individu yang tidak tahu atau ragu terhadap identitas dirinya (Keiser, 2024)

e. Depersonalisasi

Perubahan dalam persepsi atau pengalaman diri seseorang dimana merasa terlepas atau asing terhadap diri sendiri (Medford et al., 2005).

3. Penyebab

(G. W. Stuart, 2023) menyebutkan permasalahan Kesehatan jiwa disebabkan oleh berbagai faktor. Terdapat 2 faktor utama yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi:

a. Faktor predisposisi:

1) Faktor biologi:

Faktor genetik merupakan faktor dari biologi yang memiliki peran terjadinya masalah Kesehatan jiwa. Seseorang beresiko 10% jika salah satu orang tua menderita gangguan dan jika kedua orang tua memiliki riwayat gangguan maka resiko akan lebih besar, yaitu menjadi 40% (Sadock & Sadock, 2014). Selain genetik, riwayat putus obat menjadikan faktor terbanyak pasien dengan harga diri rendah kembali mengunjungi poli klinik RSJ propinsi Jawa Barat (Wulan, 2015).

2) Faktor psikologi:

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dkk menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel yang terkait dengan kejadian harga diri rendah adalah riwayat penganiayaan fisik, hilangnya penolakan keluarga di dekatnya, dan kegagalan berulang (Wijayati et al., 2020). Faktor lain yang mempengaruhi harga diri rendah yaitu pengalaman tidak menyenangkan (pengucilan, kehilangan) (G. W. Stuart, 2023), dan trauma (Varcarolis, 2013).

3) Faktor sosiokultural:

Faktor sosial budaya yang dapat menimbulkan harga diri rendah adalah adanya evaluasi lingkungan yang kurang baik terhadap klien, status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah serta adanya riwayat penolakan lingkungan pada tahap tumbuh kembang anak (G. W. Stuart, 2023)

b. Faktor presipitasi:

Faktor pencetus atau presipitasi dari harga diri rendah antara lain kehilangan tubuh (baik bagian, bentuk maupun fungsi dari tubuh), kegagalan atau produktifitas yang menurun, kecelakaan, kasus pemerkosaan, atau juga karena menjadi narapidana, termasuk juga karena penyakit fisik atau adanya alat bantu tubuh (Yosep & sutini, 2018).

Sementara menurut (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2019), faktor penyebab dari harga diri rendah adalah:

- 1) Terpapar situasi traumatis
- 2) Kegagalan berulang
- 3) Kurangnya pengakuan dari orang lain
- 4) Ketidakefektifan mengatasi masalah kehilangan

- 5) Gangguan psikiatri
- 6) Penguatan negatif berulang
- 7) Ketidaksesuaian budaya

4. Tanda Gejala

Untuk dapat menegakkan diagnosa harga diri rendah kronis, Perawat harus memastikan minimal 80% dari tanda dan gejala dibawah ini muncul pada pasien (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2019), yaitu:

a. Data subjektif

- 1) Menilai diri negatif (mis: tidak berguna, tidak tertolong)
- 2) Merasa malu/bersalah
- 3) Merasa tidak mampu melakukan apapun
- 4) Meremehkan kemampuan mengatasi masalah kehilangan
- 5) Merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan positif
- 6) Melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri
- 7) Menolak menilai positif tentang diri sendiri

b. Data subjektif

- 1) Enggan mencoba hal baru
- 2) Berjalan menunduk
- 3) Postur tubuh menunduk

(Saptina, 2020) juga menyebutkan tanda gejala harga diri rendah terdiri dari 2 yaitu:

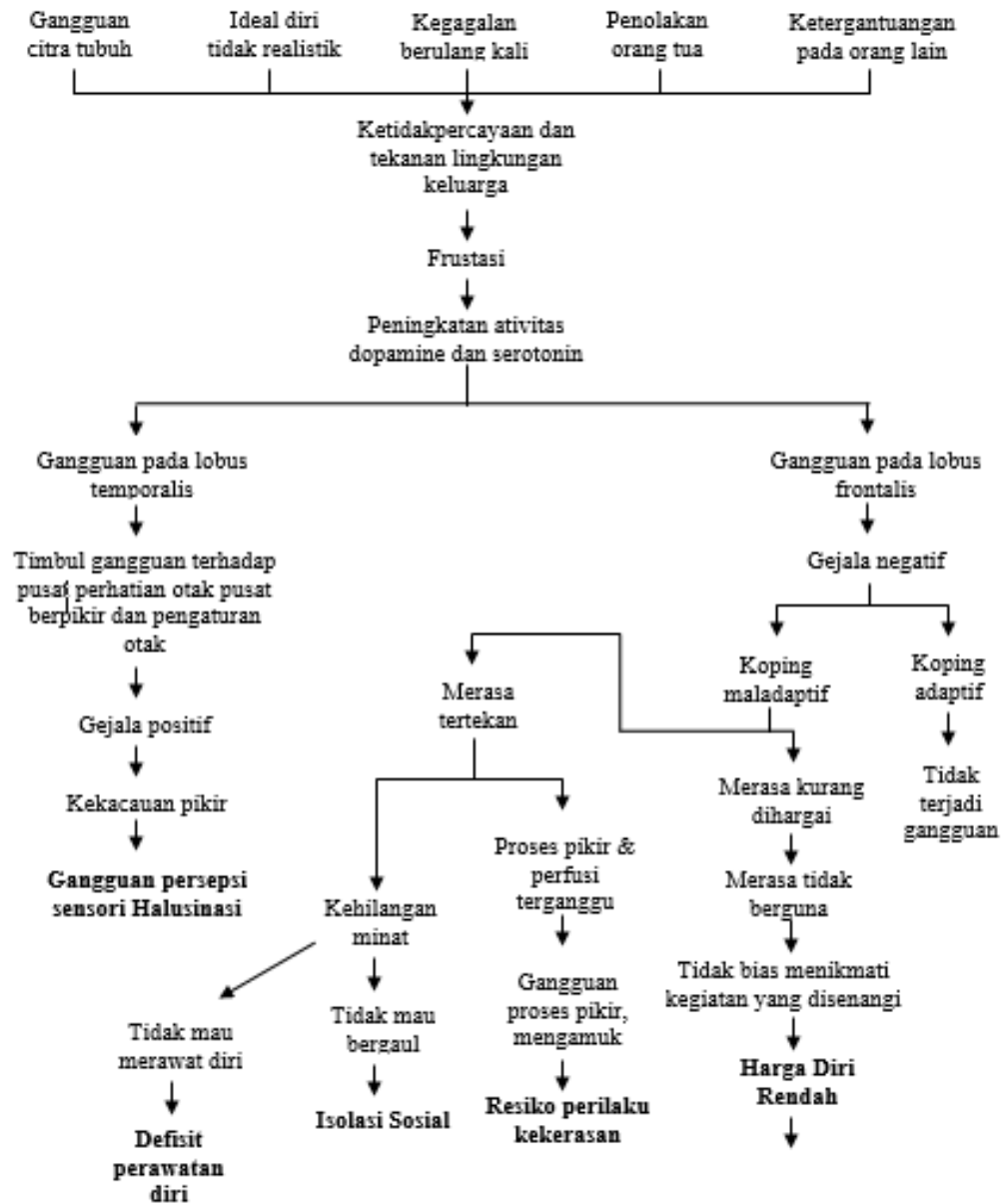
a. Gejala subjektif

- 1) Perasaan tidak sanggup dalam semua hal
- 2) Ungkapan malu dan merasa dirinya bersalah
- 3) Bersikap negatif dan pesimis terhadap diri sendiri.
- 4) Memiliki keluhan fisik.
- 5) Memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain
- 6) Merasa takut dan cemas
- 7) Tidak mampu mengambil keputusan

b. Gejala objektif

- 1) Pandangan mata tertunduk
- 2) Lebih sering menyendiri
- 3) Perilaku merugikan diri sendiri maupun orang lain
- 4) Produktivitas menjadi menurun.
- 5) Sukar tidur dan makan
- 6) Mudah marah

5. Patofisiologi harga diri rendah



Gambar 1.3 Patofisiologi Harga Diri Rendah

Gangguan jiwa disebabkan karena multicausal, tidak hanya satu (1) penyebab saja (G. W. Stuart, 2023). Faktor pendukung (predisposisi) memunculkan faktor risiko seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa. Pada mulanya individu dihadapkan pada stresor (krisis) dan sudah berusaha menyelesaikannya namun tidak tuntas. Hal ini menimbulkan pikiran bahwa pasien tidak mampu atau gagal dalam menjalankan fungsi dan perannya. Penilaian negatif atas kegagalannya ini merupakan berdampak pada individu untuk mengalami harga diri rendah (Sutejo, 2021).

6. Asuhan keperawatan

a. Pengkajian

Pengkajian jiwa merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mendokumentasikan status kesehatan penderita gangguan jiwa. Format dokumentasi jiwa harus disediakan berdasarkan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan harus memperhatikan pedoman aspek desain format dokumentasi baku (Adityas & Putra, 2022). Fokus dari pengkajian pasien dengan harga diri rendah yang merupakan konsep diri (G. W. Stuart, 2023) yaitu:

1) Gambaran diri (citra tubuh)

Gambaran diri merupakan persepsi pasien terhadap dirinya sendiri seperti persepsi tentang anggota tubuh yang disukainya atau tidak disukai

2) Identitas diri

Identitas diri merupakan status pasien sebelum dirawat di rumah sakit, kepuasan pasien terhadap statusnya, serta kepuasan pasien terhadap kegiatan yang disukainya

3) Peran

Peran merupakan peran pasien didalam keluarga dan masyarakat, ketidakmampuan pasien dalam menjalankan perannya, serta adanya kegagalan dalam menjalankan peran baru

4) Ideal

Ideal diri merupakan harapan pasien terhadap posisi, status, tubuh, maupun harapan terhadap lingkungan dan penyakit yang dialaminya

5) Harga diri

Harga diri merupakan penilaian pribadi terhadap hasil yang ingin dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri

b. Diagnosa

Diagnosa keperawatan adalah penilaian tentang respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentanan respon dari seorang individu, keluarga atau komunitas.

Diagnosa keperawatan pada pasien harga diri rendah (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2019) yaitu harga diri rendah situasional (D.0087) dan harga diri rendah kronis (D.0086). Dimana harga diri rendah situasional merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau ketidakmampuan klien sebagai respon terhadap situasi saat ini. Dan harga diri rendah kronis merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri

atau ketidakmampuan klien seperti tidak berarti, tidak berharga, tidak berdaya, yang berlangsung dalam waktu lama dan terus menerus.

c. Perencanaan

Perencanaan keperawatan adalah rangkaian tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai setiap tujuan. Perencanaan terdiri dari dua bagian yaitu rencana luaran (SLKI) dan rencana tindakan (SIKI). Luaran dari harga diri rendah (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018) yaitu "Harga diri meningkat" (L.09069).

Kriteria hasil untuk membuktikan bahwa harga diri meningkat adalah:

- 1) Penilaian diri positif meningkat
- 2) Perasaan memiliki kelebihan atau kemampuan positif meningkat
- 3) Penerimaan penilaian positif terhadap diri sendiri meningkat
- 4) Minat mencoba hal baru meningkat
- 5) Berjalan menampakkan wajah meningkat
- 6) Postur tubuh menampakkan wajah meningkat
- 7) Perasaan malu menurun
- 8) Perasaan bersalah menurun
- 9) Perasaan tidak mampu melakukan apapun menurun
- 10) Meremehkan kemampuan mengatasi masalah menurun

Sedangkan rencana tindakan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) yaitu ada tiga:

- 1) Manajemen perilaku
- 2) Promosi harga diri
- 3) Promosi coping

Yang akan diambil untuk Tindakan utama yaitu Promosi Harga Diri (I.09308)

"Promosi harga diri adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan penilaian perasaan/persepsi terhadap diri sendiri atau kemampuan diri".

Tindakan yang dilakukan pada intervensi promosi harga diri berdasarkan SIKI, antara lain:

- 1) Observasi
 - a) Identifikasi budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terhadap harga diri
 - b) Monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri
 - c) Monitor tingkat harga diri setiap waktu, sesuai kebutuhan
- 2) Terapeutik
 - a) Motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri
 - b) Motivasi menerima tantangan atau hal baru
 - c) Diskusikan pernyataan tentang harga diri
 - d) Diskusikan kepercayaan terhadap penilaian diri

- e) Diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri
- f) Diskusikan persepsi negatif diri
- g) Diskusikan alasan mengkritik diri atau rasa bersalah
- h) Diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi
- i) Diskusikan Bersama keluarga untuk menetapkan harapan dan Batasan yang jelas
- j) Berikan umpan balik positif atas peningkatan mencapai tujuan
- k) Fasilitasi lingkungan dan aktivitas yang meningkatkan diri

3) Edukasi

- a) Jelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif diri pasien
- b) Anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki
- c) Anjurkan mempertahankan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain
- d) Anjurkan membuka diri terhadap kritik negatif
- e) Anjurkan mengevaluasi perilaku
- f) Ajarkan cara mengatasi bullying
- g) Latih peningkatan tanggung jawab untuk diri sendiri
- h) Latih pernyataan/kemampuan positif diri
- i) Latih cara berfikir dan berperilaku positif
- j) Latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi

d. Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapinya untuk meningkatkan status kesehatan menjadi lebih baik yang digambarkan sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan (Sutejo, 2021).

Tujuan implementasi keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah (Sutejo, 2021) yaitu:

- 1) Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien.
- 2) Membantu klien menilai kemampuan yang dapat digunakan.
- 3) Membantu klien memilih/menetapkan kemampuan yang akan dilatih
- 4) Melatih kemampuan yang dipilih klien

e. Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP diantaranya sebagai berikut:

Perumusan evaluasi formatif meliputi 4 komponen yang dikenal dengan SOAP yaitu:

- 1) S (subyektif), respon subyektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan
- 2) O (obyektif), respon obyektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan
- 3) A (assessment), analisa ulang atas dasar subyektif dan obyektif untuk menyimpulkan apakah masalah tetap atau muncul masalah baru
- 4) P (planning), perencanaan hasil dan analisa data

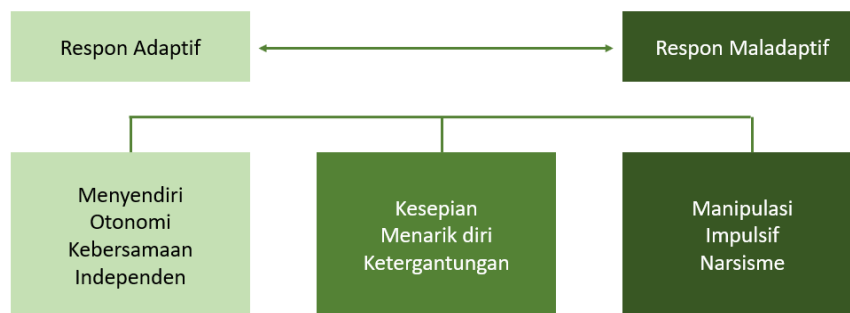
B. Isolasi Sosial

1. Definisi

Kemunduran fungsi sosial dialami seseorang di dalam diagnosa keperawatan jiwa disebut isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan keadaan dimana seseorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain disekitarnya (Yosep & sutini, 2018). Isolasi sosial merupakan salah suatu gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh kepribadian yang tidak fleksibel yang menimbulkan gangguan interaksi interpersonal dan menimbulkan perilaku maladaptif pada individu (G. W. Stuart, 2023).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa isolasi sosial merupakan keadaan seseorang mengalami gangguan interaksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya.

2. Rentang respon



Gambar 1.4 Rentang Respon Harga Diri

Rentang respon dari isolasi sosial (G. Stuart et al., 2022) yaitu: menyendiri, otonomi, bekerjasama, interdependen, menarik diri, ketergantungan, manipulasi, impulsif, narsisme.

3. Penyebab

(G. W. Stuart, 2023) menyebutkan permasalahan Kesehatan jiwa disebabkan oleh berbagai faktor. Terdapat 2 faktor utama yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi:

a. Faktor predisposisi:

1) Faktor biologi

Faktor genetik dapat menunjang terhadap respons sosial maladaptif. Ada bukti terdahulu tentang terlibatnya neurotransmitter dalam perkembangan gangguan ini, namun tetap masih diperlukan penelitian lebih lanjut (Sadock & Sadock, 2014).

2) Faktor psikologi

Pada setiap tahapan tumbuh kembang individu ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi gangguan dalam hubungan sosial. Apabila tugas-tugas dalam setiap perkembangan tidak terpenuhi maka akan menghambat fase perkembangan sosial selanjutnya. Faktor Perkembangan Tiap gangguan dalam pencapaian tugas perkembangan akan mencetuskan seseorang sehingga mempunyai masalah respon maladaptif. Sistem keluarga yang terganggu dapat menunjang perkembangan respons sosial maladaptif. Beberapa orang percaya bahwa individu yang mempunyai masalah ini adalah orang yang tidak berhasil memisahkan dirinya dari orang tua (Orenstein & Lewis, 2022).

3) Faktor sosiobudaya

Isolasi sosial merupakan faktor dalam gangguan berhubungan. Ini akibat dari norma yang tidak mendukung pendekatan terhadap orang lain, atau tidak menghargai anggota masyarakat yang tidak produktif, seperti lansia, orang cacat, dan berpenyakit kronik (G. Stuart et al., 2022)

b. Faktor presipitasi:

Stresor pencetus pada umumnya mencakup kejadian kehidupan yang penuh stres seperti kehilangan, yang mempengaruhi kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan menyebabkan ansietas. Stresor pencetus dapat dikelompokkan dalam kategori (G. Stuart et al., 2022):

- 1) Stresor sosiokultural, merupakan stres yang dapat ditimbulkan oleh menurunnya stabilitas unit keluarga dan berpisah dari orang yang berarti didalam kehidupannya.
- 2) Stresor psikologik, ansietas berat yang berkepanjangan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengatasinya
- 3) Stresor biologik, merupakan stresor karena adanya faktor genetik atau keturunan

4. Tanda dan Gejala

Menurut (Yosep & sutini, 2018) tanda dan gejala klien isolasi sosial bisa dilihat dari dua cara yaitu secara objektif dan subjektif. Berikut ini tanda dan gejala klien dengan isolasi sosial:

a. Gejala subjektif

- 1) Klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain.
- 2) Klien merasa tidak aman berada dengan orang lain.
- 3) Respons verbal kurang dan sangat singkat.
- 4) Klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain.
- 5) Klien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu.
- 6) Klien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan.
- 7) Klien merasa tidak berguna.

b. Gejala objektif

- 1) Klien banyak diam dan tidak mau bicara
- 2) Tidak mengikuti kegiatan.
- 3) Klien berdiam diri di kamar
- 4) Klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang terdekat.
- 5) Klien tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal.
- 6) Kontak mata kurang.
- 7) Kurang spontan.
- 8) Apatik
- 9) Ekspresi wajah kurang berseri.
- 10) Mengisolasi diri
- 11) Tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar.
- 12) Aktivitas menurun

Untuk dapat mengangkat diagnosis isolasi sosial, Perawat harus memastikan bahwa tanda dan gejala dibawah ini muncul pada pasien (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2019), yaitu:

a. Data subjektif

- 1) Merasa ingin sendirian
- 2) Merasa tidak aman di tempat umum

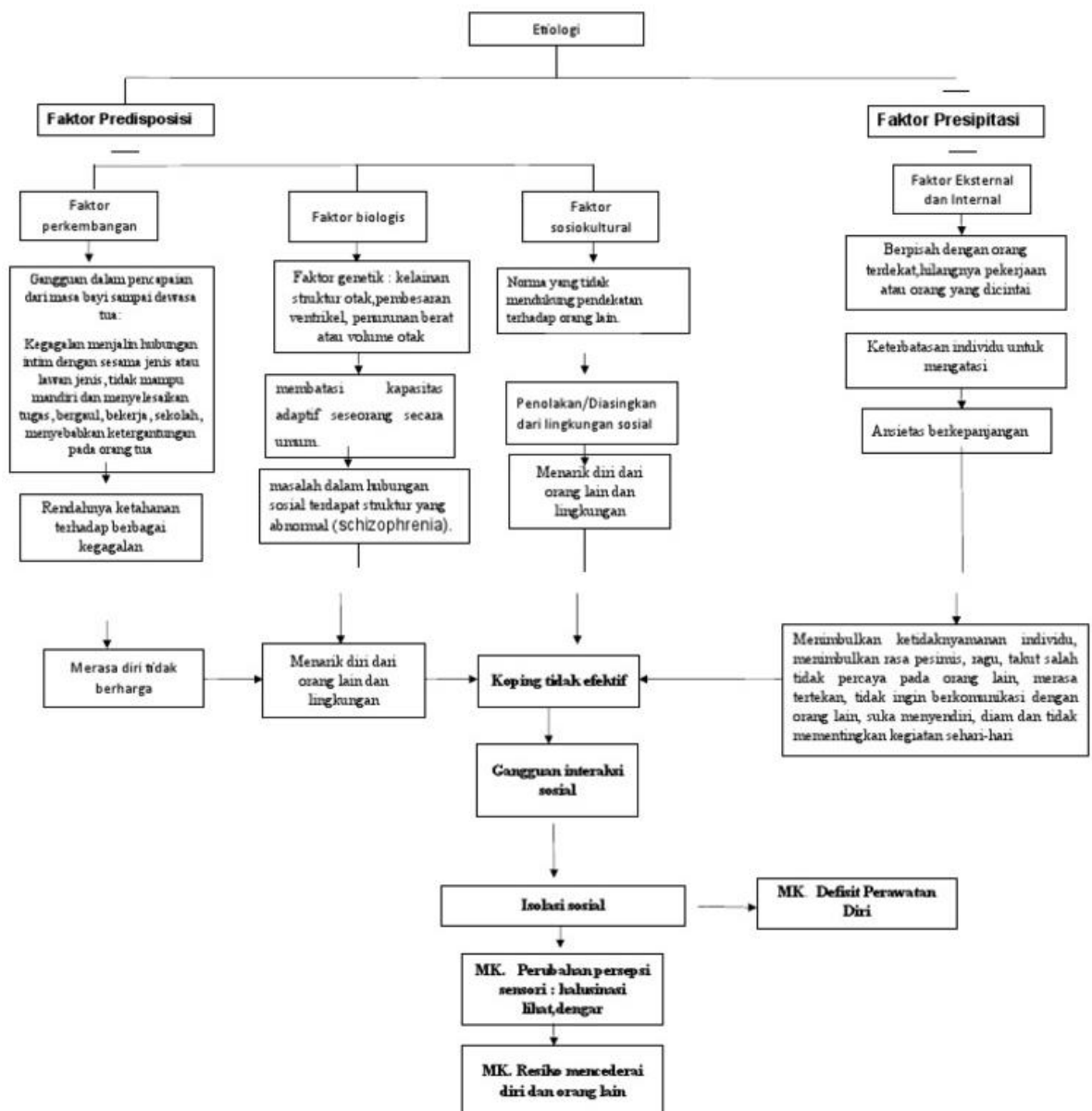
b. Data Objektif

- 1) Menarik diri
- 2) Tidak berminat/menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan

5. Patofisiologi isolasi sosial

Salah satu gangguan berhubungan sosial diantaranya perilaku menarik diri atau isolasi sosial yang disebabkan oleh perasaan tidak berharga, yang bisa dialami klien dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan,

ketegangan, kekecewaan, dan kecemasan (G. Stuart et al., 2022). Perasaan tidak berharga menyebabkan klien semakin sulit dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain. Akibatnya klien menjadi regresi atau mundur, mengalami penurunan dalam aktifitas dan kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri. Klien semakin tenggelam dalam perjalanan dan tingkah laku masa lalu serta tingkah laku primitive antara lain pembicaraan yang autistic dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga berakibat lanjut menjadi halusinasi (Dalami, 2009).



Gambar 1.5 Patways Isolasi Sosial

6. Asuhan keperawatan

a. Pengkajian

Isolasi sosial merupakan kondisi dimana seseorang menghadapi pengurangan ataupun sama sekali tidak sanggup dalam berhubungan dengan orang lain di sekitarnya. Isolasi sosial ialah upaya seseorang untuk menjauhi interaksi dengan orang lain dan menjauhi hubungan dengan orang lain maupun komunikasi dengan orang lain (Damaiyanti & Iskandar, 2014)

b. Diagnosa

Diagnosa keperawatan adalah penilaian tentang respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentanan respon dari seorang individu, keluarga atau komunitas.

Diagnosa keperawatan pada pasien isolasi sosial (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2019) yaitu isolasi sosial (D.0121) merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain.

c. Perencanaan

Perencanaan keperawatan adalah rangkaian tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai setiap tujuan. Perencanaan terdiri dari dua bagian yaitu rencana luaran (SLKI) dan rencana tindakan (SIKI). Luaran dari harga diri rendah (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018) yaitu "Keterlibatan sosial meningkat" (L.13116). Keterlibatan sosial meningkat berarti meningkatnya kemampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan independent dengan orang lain.

Kriteria hasil untuk membuktikan bahwa keterlibatan sosial meningkat adalah:

- 1) Minat interaksi meningkat
- 2) Verbalisasi isolasi menurun
- 3) Verbalisasi ketidakamanan ditempat umum menurun
- 4) Perilaku menarik diri menurun

Sedangkan rencana tindakan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) yaitu ada dua:

- 1) Promosi sosialisasi
- 2) Terapi aktivitas

Yang akan diambil untuk Tindakan utama yaitu Promosi Sosialisasi (I. 13498) "Promosi sosialisasi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan kemampuan pasien untuk berinteraksi dengan orang lain". Tindakan yang dilakukan pada intervensi promosi sosialiasi berdasarkan SIKI, antara lain:

- 1) Observasi
 - a) Identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain

- b) Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain
- 2) Terapeutik
 - a) Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan
 - b) Motivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan
 - c) Motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok
 - d) Motivasi berinteraksi di luar lingkungan (mis: jalan-jalan, ke toko buku)
 - e) Diskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain
 - f) Diskusikan perencanaan kegiatan di masa depan
 - g) Berikan umpan balik positif dalam perawatan diri
 - h) Berikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan
- 3) Edukasi
 - a) Anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap
 - b) Anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan
 - c) Anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain
 - d) Anjurkan meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain
 - e) Anjurkan penggunaan alat bantu (mis: kacamata dan alat bantu dengar)
 - f) Anjurkan membuat perencanaan kelompok kecil untuk kegiatan khusus
 - g) Latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi
 - h) Latih mengekspresikan marah dengan tepat
- d. Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapinya untuk meningkatkan status kesehatan menjadi lebih baik yang digambarkan sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan (Sutejo, 2021).
- e. Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP diantaranya sebagai berikut:

Perumusan evaluasi formatif meliputi 4 komponen yang dikenal dengan SOAP yaitu:

 - 1) S (subyektif), respon subyektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan
 - 2) O (obyektif), respon obyektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan
 - 3) A (assessment), analisa ulang atas dasar subyektif dan obyektif untuk menyimpulkan apakah masalah tetap atau muncul masalah baru
 - 4) P (planning), perencanaan hasil dan analisa data

C. Latihan

Pilihan Ganda

1. Seorang perempuan berusia 15 tahun dibawa ke RSJ oleh keluarganya dengan alasan setelah kecelakaan klien mengurung diri di kamar, tidak mau pergi ke sekolah, dan tidak mau mandi. Saat dilakukan pengkajian klien mengatakan lebih suka menyendiri, malu bergaul dengan orang lain karena fisiknya berbeda, postur tubuh tampak menunduk, kontak mata kurang.
Apakah diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas?
A. Isolasi sosial
B. Harga diri rendah kronik
C. Harga diri rendah situasional
D. Menarik diri
E. Koping individu tidak efektif
2. Seorang perawat sedang melakukan komunikasi terapeutik dengan seorang pasien perempuan yang mengalami harga diri rendah. Setiap teman-temannya melakukan suatu kegiatan, pasien tampak sesekali memperhatikan teman-temannya. Dan ketika ditanya mengapa tidak bergabung dengan yang lain, pasien diam saja.
Bagaimana sikap perawat terhadap pasien tersebut?
A. Meninggalkan pasien
B. Menghentikan komunikasi dengan pasien
C. Meminta pasien untuk gabung dengan mereka
D. Membiarkan pasien untuk mengamati teman-temannya
E. Menemani klien untuk bergabung dengan teman-temannya
3. Seorang pasien perempuan berumur 30 tahun tampak sering menyendiri di kamarnya, jarang ngobrol, mengatakan malas untuk berinteraksi dengan orang lain, kontak mata kurang. Klien mengatakan malas berinteraksi dengan orang lain karena malu mempunyai wajah yang jelek, badan hitam, pendek dan gemuk.
Apa data subjektif yang mendukung masalah harga diri rendah?
A. Mengatakan malas untuk berinteraksi dengan orang lain
B. Mengatakan malu mempunyai wajah jelek
C. Jarang ngobrol dengan orang lain
D. Menyendiri di kamar
E. Kontak mata kurang
4. Seorang pasien laki-laki dirawat di RSJ sejak 1 bulan yang lalu dengan diagnose medis Skizofrenia paranoid. Sehari-hari, pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan. Setiap hari, pasien sering terlihat

menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Pasien tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan, setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri.

Apa diagnosa utama dari kasus tersebut?

- A. Harga diri rendah
- B. Isolasi Sosial
- C. Halusinasi
- D. Defisit perawatan diri
- E. Waham

5. Seorang pasien laki-laki di rawat di RSJ dengan isolasi sosial. Pasien mengatakan dirinya tidak berguna, tampak mengurung diri dikamar, tidak berinteraksi dengan siapapun, tidak melakukan aktifitas harian. Saat ini klien mampu merespon perawat ketika berinteraksi dan berdiskusi tentang keuntungan berkenalan dengan pasien.

Apa tindakan yang dilakukan oleh perawat berikutnya?

- A. Memberikan informasi tentang keuntungan berkenalan dengan orang lain
- B. Mendiskusikan tentang cara berkenalan dengan orang lain
- C. Meminta pasien untuk mendemonstrasikan cara berkenalan
- D. Meminta pasien lain untuk berkenalan dengan pasien
- E. Mendiskusikan cara berkenalan dalam kelompok

Essay

1. Apa faktor predisposisi dari isolasi social?
2. Sebutkan rentang respon adaptif dari harga diri rendah?
3. Sebutkan faktor presipitasi dari harga diri rendah?
4. Apa tanda subjektif isolasi sosial dari SDKI?
5. Sebutkan fokus pengkajian dari konsep diri?

D. Kunci Jawaban

1. B
2. E
3. B
4. B
5. B

E. Rangkuman Materi

BAB ini berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial. Fokus utama dari sub bab ini yaitu meliputi definisi, rentang respon, penyebab, tanda gejala, patofisiologi dan asuhan keperawatan dari masing-masing masalah (harga diri rendah dan isolasi sosial).

F. Glosarium

Interdependen, saling ketergantungan merupakan suatu hubungan interpersonal yang saling ketergantungan antara seorang dengan yang Lain

Manipulasi, kondisi dimana individu cenderung berorientasi pada diri sendiri.

Impulsif merupakan respon sosial yang ditandai dengan individu sebagai subjek yang tidak dapat diduga, tidak dapat dipercaya dan tidak mampu melakukan penilaian secara objektif.

Narsisisme, kondisi dimana individu merasa harga diri rapuh, dan mudah marah.

G. Daftar Pustaka

- Adityas, I. P., & Putra, D. S. H. (2022). Pedoman Format Pengkajian Keperawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *J-REMI: Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 3(3), 243–250. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v3i3.2453>
- Burns, R. A., Crisp, D. A., & Burns, R. B. (2020). Re-examining the reciprocal effects model of self-concept, self-efficacy, and academic achievement in a comparison of the Cross-Lagged Panel and Random-Intercept Cross-Lagged Panel frameworks. *British Journal of Educational Psychology*, 90(1), 77–91. <https://doi.org/10.1111/bjep.12265>
- D'Souza, J. F. (2018). *The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development*. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4135%2F9781506307633.n714?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlQ29udGVudCJ9fQ
- Dalami, E. (2009). *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa*. Trans Info Media.
- Damaiyanti, & Iskandar. (2014). *Asuhan Keperawatan Jiwa*. Refika Aditama.
- Keiser, J. (2024). Reference and confusion. *Inquiry*, 67(8), 2783–2790. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2023.2234416>
- Medford, N., Sierra, M., Baker, D., & David, A. S. (2005). Understanding and treating depersonalisation disorder. *Advances in Psychiatric Treatment*, 11(2), 92–100. <https://doi.org/10.1192/apt.11.2.92>

- Mruk, C. J. (2006). *Self-esteem research, theory, and practice: toward a positive psychology of self-esteem 3rd edition*. Springer Publishing Company Inc.
- Orenstein, G. A., & Lewis, L. (2022). *Eriksons Stages of Psychosocial Development*. StatPearls Publishing LLC.
- Pardede, J. A., Keliat, B. A., & Wardani, I. Y. (2020). The Symptoms of Low Self-Esteem Decline after Being Given Acceptance and Commitment Therapy. *Advanced Practices in Nursing*, 5(2). <https://doi.org/10.37421/apn.2020.05.170>
- Sadock, B. J., & Sadock, V. . (2014). *Buku Ajar Psikiatri Klinis. Edisi 2*. EGC: Penerbiat Buku Kedokteran.
- Saptina, C. D. (2020). Asuhan Keperawatan Pada Klien Skizofrenia Dengan Masalah Harga Diri Rendah Kronik. *Eprint.Umpo.Ac.Id*.
- Stuart, G., Keliat, B. A., & Pasaribu, J. (2022). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*. Elsevier Singapore Pte Ltd.
- Stuart, G. W. (2023). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart* (B. A. Keliat (ed.); 2nd ed.). Elsevier.
- Sutejo. (2021). *Keperawatan Jiwa: Konsep dan Praktik Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa: Gangguan Jiwa dan Psikososial*. Pustaka Baru Press.
- TIM Pokja SDKI DPP PPNI. (2019). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik*. EGC.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*. PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)*. PPNI.
- Varcarolis, E. M. (2013). *Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing* (2nd ed.). Elsevier.
- Wijayati, F., Nasir, T., Hadi, I., & Akhmad, A. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Harga Diri Rendah Pasien Gangguan Jiwa. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 12(2), 224–235. <https://doi.org/10.36990/hijp.v12i2.234>
- Wulan, W. R. (2015). Terapi Spesialis Keperawatan Jiwa Terhadap Klien dan Keluarga. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 18(1).
- Yosep, I., & sutini, T. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa* (D. Wildani (ed.); 8th ed.). Refika Adittama.

BAB 2

ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI WAHAM DAN HALUSINASI

Pendahuluan

Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan global yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Di antara berbagai jenis gangguan jiwa, waham dan halusinasi menjadi gejala yang sering dijumpai, terutama pada pasien dengan gangguan psikotik seperti skizofrenia. Waham adalah keyakinan yang salah yang bertahan lama meskipun bertentangan dengan kenyataan, sementara halusinasi adalah persepsi sensori terhadap sesuatu yang tidak ada rangsangan eksternal. Kedua kondisi ini dapat mengganggu fungsi kognitif, emosional, dan perilaku individu, sehingga memerlukan pendekatan keperawatan yang komprehensif untuk mengelola gejala dan mendukung pemulihan.

Asuhan keperawatan pada klien dengan waham dan halusinasi bertujuan untuk membantu individu mengelola gejala yang dialami, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pemulihan fungsi sosial dan emosional mereka. Proses asuhan ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengkajian menyeluruh terhadap kondisi klien, perumusan diagnosis keperawatan yang tepat, perencanaan intervensi yang sesuai, pelaksanaan tindakan keperawatan, hingga evaluasi hasil asuhan. Intervensi keperawatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pengelolaan gejala, tetapi juga pada peningkatan kemampuan klien untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang asuhan keperawatan klien dengan waham dan halusinasi sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat. Pengetahuan ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan gejala, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mental klien secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang holistik dan dukungan keluarga yang efektif, diharapkan asuhan keperawatan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung proses pemulihan klien, mengurangi beban keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup individu dengan gangguan jiwa di masyarakat.

Tujuan Intruksional Umum:

Setelah melalui pembelajaran ini, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah waham dan halusinasi.

Tujuan Intruksional Khusus:

Setelah melalui pembelajaran ini, mahasiswa mampu

- Menjelaskan Pengertian Waham dan Halusinasi
- Menjelaskan Proses/Tahapan Terjadinya Waham dan Halusinasi
- Menjelaskan Jenis-jenis Waham dan Halusinasi
- Menjelaskan Tanda dan Gejala Waham dan Halusinasi
- Menjelaskan Rentang Respon Waham dan Halusinasi
- Menjelaskan Faktor Predisposisi dan Faktor Presipitasi Munculnya Waham dan Halusinasi
- Menjelaskan Penatalaksanaan Waham dan Halusinasi
- Memaparkan Asuhan Keperawatan Klien dengan Waham dan Halusinasi (pengkajian, pohon masalah, intervensi, implementasi, evaluasi)

Capaian Pembelajaran

Kognitif:

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan waham dan halusinasi.
2. Mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan pada klien yang mengalami waham dan halusinasi.

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan dan strategi pelaksanaan pada klien yang mengalami waham dan halusinasi.
2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami waham dan halusinasi.

Afektif:

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

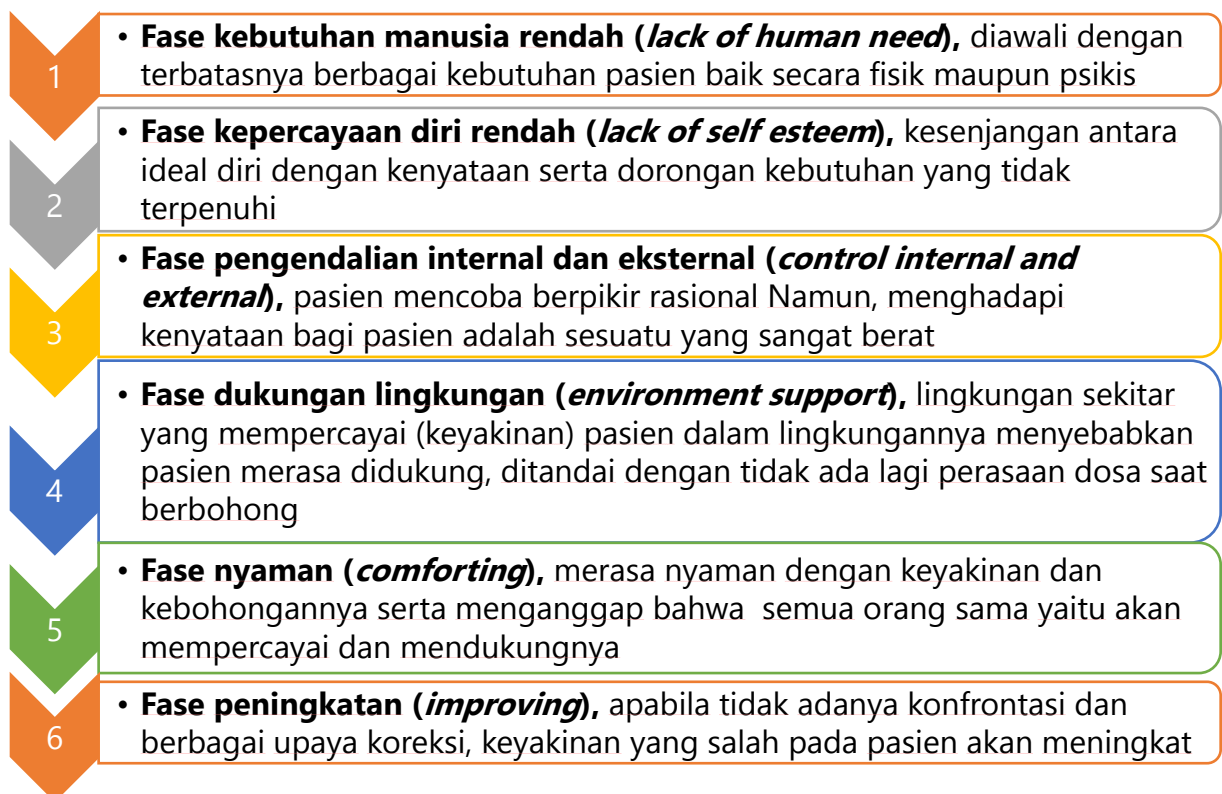
Uraian Materi

A. Pengertian Waham

Waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus, meskipun tidak sesuai dengan kenyataan (Stuart, 2002). Kelainan jiwa ini ditunjukkan melalui adanya ide-ide atau keyakinan yang tidak benar. Waham termasuk dalam kategori gangguan isi pikiran, di mana individu tetap mempertahankan pandangan yang tidak sesuai dengan realitas.

B. Proses/Tahapan Terjadinya Waham

Berikut ini tahapan terjadinya waham dimana dalam setiap fasenya terdapat ciri-ciri khusus yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan realitas:



C. Jenis-jenis Waham

Berikut ini beberapa jenis waham, antara lain:

1. Waham Kebesaran (Grandiosity): Meyakini bahwa ia memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan.
DS: Klien mengatakan bahwa ia adalah presiden, Nabi, Wali, artis dan lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan dirinya
DO:
 - a. Perilaku klien tampak seperti isi wahamnya
 - b. Inkoheren (gagasan satu dengan yang lain tidak logis, tidak berhubungan,

secara keseluruhan tidak dapat di mengerti)

- c. Klien mudah marah
 - d. Klien mudah tersinggung
2. Waham Curiga: Meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan/mencederai dirinya, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan.
- DS: Klien mengatakan merasa diintai dan akan membahayakan dirinya "Saya tahu..kalian semua memasukkan racun ke dalam makanan saya"
- DO:
- a. Klien tampak waspada
 - b. Klien tampak menarik diri
 - c. Perilaku klien tampak seperti isi wahamnya
 - d. Inkoheren (gagasan satu dengan yang lain tidak logis, tidak berhubungan, secara keseluruhan tidak dapat di mengerti)
3. Waham Agama (*Religious*): Memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan.
- DS: Klien mengatakan "Kalau saya mau masuk surga saya harus membagikan uang kepada semua orang."
- DO:
- a. Perilaku tampak seperti isi wahamnya
 - b. Nampak bingung karena harus melakukan isi wahamnya
 - c. Inkoheren (gagasan satu dengan yang lain tidak logis, tidak berhubungan, dan tidak dapat dimengerti)
4. Waham Somatik: Meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu/terserang penyakit, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan.
- DS: Mengatakan "Saya sakit menderita kanker", namun saat pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan tanda tanda kanker, tetapi pasien terus mengatakan bahwa ia terserang kanker.
- DO:
- a. Perilaku seperti isi wahamnya
 - b. Inkoheren
 - c. Tampak bingung
 - d. Mengalami perubahan pola tidur
 - e. Kehilangan selera makan
5. Waham Nihilistik: Meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia/meninggal, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan.
- DS: Mengatakan dirinya sudah meninggal, "Ini kan alam kubur ya, semua yang

ada disini adalah roh-roh”

DO:

- a. Perilaku seperti isi wahamnya
 - b. Inkoheren
 - c. Tampak bingung
 - d. Mengalami perubahan pola tidur
 - e. Kehilangan selera makan
6. Waham Bizarre, terdiri dari 3 macam yaitu:
- a. Waham sisip pikir adalah waham di mana klien meyakini bahwa ada pikiran orang lain yang disisipkan dipikrannya.
 - b. Waham siar pikir adalah waham di mana klien memiliki keyakinan yang tidak masuk akal bahwa orang lain dapat mendengar atau menyadari pikirannya.
 - c. Waham kontrol pikir adalah waham dimana pikirannya dikontrol oleh kekuatan yang ada diluar dirinya.

D. Tanda dan Gejala Waham

Untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik waham, penting untuk mengenali tanda dan gejala yang muncul pada individu yang mengalaminya. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan berbagai tanda dan gejala waham.

Tabel 2.1 Tanda dan Gejala Waham

Kognitif	Afektif	Perilaku dan hubungan sosial	Fisik
✓ Tidak mampu membedakan nyata dengan tidak nyata.	✓ Situasi tidak sesuai dengan kenyataan.	✓ Hipersensitif	✓ Kebersihan kurang
✓ Individu sangat percaya pada keyakinannya.	✓ Afek tumpul.	✓ Hubungan interpersonal dengan orang lain dangkal	✓ Muka pucat
✓ Sulit berpikir realita.		✓ Depresif	✓ Sering menguap
✓ Tidak mampu mengambil Keputusan.		✓ Ragu-ragu	✓ Berat badan menurun
		✓ Mengancam secara verbal	✓ Nafsu makan berkurang dan sulit tidur
		✓ Aktivitas tidak tepat	
		✓ Stereotif	
		✓ Impulsif	
		✓ Curiga	

E. Rentang Respon Waham

Rentang respons waham menggambarkan variasi reaksi individu terhadap keyakinan keliru yang mereka alami, mulai dari respons adaptif hingga maladaptif. Respons adaptif ditandai dengan kemampuan individu untuk mengenali dan

mengelola waham secara lebih realistis, meskipun masih mengalami distorsi pikiran.

Sebaliknya, respons maladaptif muncul ketika individu sepenuhnya tenggelam dalam keyakinan waham, yang berdampak negatif terhadap fungsi sosial, emosional, dan kognitif mereka. Rentang respons ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan waham, dukungan sosial, serta kondisi psikologis individu (Keliat, 2019; Stuart & Laraia, 2005).

Memahami rentang respons ini sangat penting dalam menentukan pendekatan intervensi yang tepat bagi individu dengan waham.

Berikut ini gambaran tentang rentang respon waham sebagai berikut :



Gambar 2.1 Respon Waham

F. Faktor Predisposisi dan Faktor Presipitasi Munculnya Waham

Dalam memahami terjadinya waham, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemunculannya. Secara umum, terdapat dua kategori utama yang memengaruhi perkembangan waham, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi merujuk pada kondisi atau karakteristik bawaan yang meningkatkan kerentanan individu terhadap waham, seperti faktor genetik, biologis, dan riwayat gangguan mental. Sementara itu, faktor presipitasi adalah pemicu eksternal atau situasi stres yang dapat memunculkan atau memperburuk gejala waham, seperti peristiwa traumatis, tekanan psikososial, atau perubahan lingkungan yang signifikan. Memahami kedua faktor ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan penatalaksanaan waham secara komprehensif.

1. Faktor Predisposisi

- a. Biologis : Individu dari anggota keluarga dimanifestasikan dengan ini memiliki resiko tinggi dibandingkan populasi pada umumnya (genetik diturunkan)
- b. Psikososial
 - 1) Sistem Keluarga : keluarga yang kurang baik sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak
 - 2) Interpersonal: seseorang yang memiliki psikosis (gangguan mental) akan menimbulkan bentuk hubungan orang tua dan anak yang penuh dengan sebuah konflik.
- c. Psikodinamika: Emosi yang tidak stabil diakibatkan dari tidak ada rangsangan atau perhatian dari orang tua, sehingga menimbulkan seorang anak mengalami gangguan rasa percaya diri, dan lain-lain.

2. Faktor Presipitasi

- a. Biologi: Stress biologi yang berhubungan dengan respon neurologi maladaptive.
- b. Stres lingkungan: Stressor lingkungan menimbulkan munculnya gangguan perilaku pasien.
- c. Pemicu gejala: Pemicu gejala terjadi pada respon neurobiologik yang maladaptive yang berhubungan dengan kesehatan, lingkungan dan perilaku individu.

G. Penatalaksanaan Waham

Penatalaksanaan waham merupakan langkah penting dalam upaya mengelola dan mengurangi gejala yang dialami oleh individu dengan gangguan ini. Pendekatan medis bertujuan untuk menstabilkan kondisi mental pasien, mengurangi intensitas keyakinan yang keliru, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Penatalaksanaan medis biasanya melibatkan kombinasi terapi farmakologis, seperti pemberian antipsikotik, dan intervensi non-farmakologis, termasuk psikoterapi dan rehabilitasi psikosial. Menurut Prastika (2014) penatalaksanaan medis waham antara lain:

1. Psikofarmalogi

- a. Litium Karbonat: Jenis litium yang paling sering digunakan untuk mengatasi gangguan bipolar, menyusul kemudian litium sitrat. Litium masih efektif dalam menstabilkan suasana hati pasien dengan gangguan bipolar.
- b. Haloperidol: efektif untuk pengobatan kelainan tingkah laku berat dan eksplosif.

- c. Karbamazepin: efektif dalam pengobatan kejang psikomotor, dan neuralgia trigeminal. Mengurangi dan menghentikan agitasi untuk pengamanan pasien sebagai obat anti psikotik untuk pasien waham.
- d. Antipsikosis atipikal (olanzapin, risperidone). Pilihan awal Risperidone tablet 1mg, 2mg, 3mg atau Clozapine tablet 25mg, 100mg.
- e. Tipikal (klorpromazin, haloperidol), klorpromazin 25-100mg. Efektif untuk menghilangkan gejala positif. Penarikan diri selama potensi tinggi seseorang mengalami waham.
- f. CT tipe katatonik Electro Convulsive Therapy (ECT) adalah sebuah prosedur dimana arus listrik melewati otak untuk pelatihan kejang singkat. Hal ini menyebabkan perubahan dalam kimiawi otak yang dapat mengurangi penyakit mental tertentu, seperti skizofrenia katatonik.

2. Psikoterapi

Walaupun obat-obatan penting untuk mengatasi pasien waham, namun psikoterapi juga penting. Psikoterapi mungkin tidak sesuai untuk semua orang, terutama jika gejala terlalu berat untuk terlibat dalam proses terapi yang memerlukan komunikasi dua arah. Yang termasuk dalam psikoterapi adalah terapi perilaku, terapi kelompok, terapi keluarga, terapi suportif.

H. Asuhan Keperawatan Klien Dengan Waham

1. Pengkajian

Menurut Kaplan dan Sadock (2015) beberapa hal yang harus dikaji antara lain sebagai berikut:

- a. Status mental
 - 1) Pada pemeriksaan status mental, menunjukkan hasil yang sangat normal, kecuali bila ada sistem waham abnormal yang jelas.
 - 2) Suasana hati (*mood*) pasien konsisten dengan isi wahamnya.
 - 3) Pada waham curiga didapatkannya perilaku pencuriga.
 - 4) Pada waham kebesaran, ditemukan pembicaraan tentang peningkatan identitas diri dan mempunyai hubungan khusus dengan orang yang terkenal.
 - 5) Adapun sistem wahamnya, pemeriksa kemungkinan merasakan adanya kualitas depresi ringan.
 - 6) Pasien dengan waham tidak memiliki halusinasi yang menonjol/menetap kecuali pada pasien dengan waham raba atau cium. Pada beberapa pasien kemungkinan ditemukan halusinasi dengar.

b. Sensorium dan kognisi

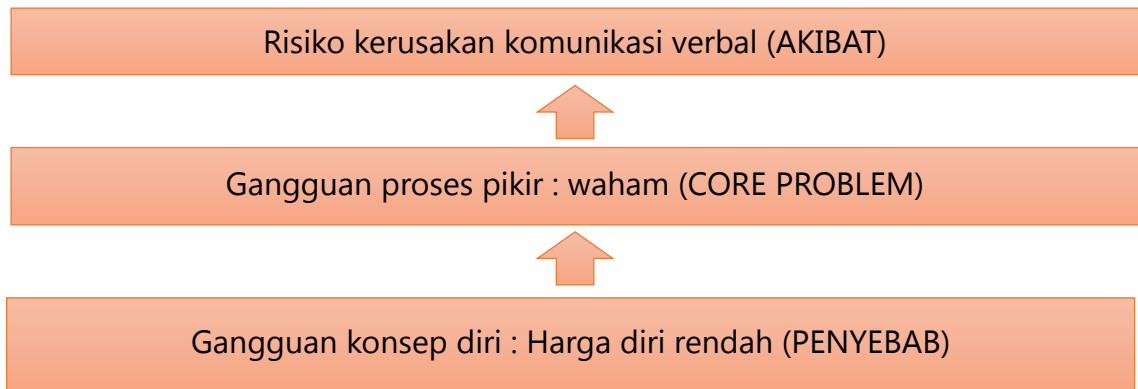
- 1) Pada waham, tidak ditemukan kelainan dalam orientasi, kecuali yang memiliki waham spesifik tentang waktu, tempat, dan situasi.
- 2) Daya ingat dan proses kognitif pasien dengan utuh (intact).
- 3) Pasien waham hampir seluruh memiliki daya tilik diri (insight) yang jelek.
- 4) Pasien dapat dipercaya informasinya, kecuali jika membahayakan dirinya, keputusan yang terbaik bagi pemeriksa dalam menentukan kondisi pasien adalah dengan menilai perilaku masa lalu, masa sekarang, dan yang direncanakan.

c. Pohon Masalah

Sebelum membuat diagnosa keperawatan terlebih dahulu membuat pohon masalah keperawatan untuk menganalisis masalah yang sedang dihadapi oleh klien saat ini. Dari pohon masalah akan diketahui akar masalah klien, masalah aktual, dan masalah resiko, sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Cara membuat pohon masalah :

- 1) Tentukan dahulu problem utama (core problem) atau masalah yang dialami klien saat ini sehingga klien datang ke RS
- 2) Cari penyebab dari masalah utama
- 3) Tentukan masalah resiko yang akan terjadi yang diakibatkan oleh masalah utama
- 4) Tentukan masalah lainnya yang akan terjadi yang diakibatkan oleh masalah utama
- 5) Cari peran serta keluarga yang mungkin menyebabkan terjadinya masalah utama yang berkaitan dengan proses terapi

Core problem atau masalah utama dalam hal ini akan berubah sesuai dengan perubahan atau perkembangan respons klien terhadap stimulus atau karena perkembangan dari suatu penatalaksanaan terapi atau tindakan keperawatan, demikian juga untuk masalah resiko. Masalah resiko dapat saja berubah menjadi masalah utama, demikian seterusnya.



Gambar 2.2

2. Diagnosis

- Risiko kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan waham.
- Gangguan proses pikir: waham berhubungan dengan harga diri rendah.

a. Rencana Intervensi

Dalam menangani individu dengan waham, perencanaan intervensi atau tindakan keperawatan menjadi langkah krusial. Intervensi ini dirancang secara holistik, mencakup pendekatan terapeutik, komunikasi efektif, serta pemberian dukungan psikososial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selain itu, peran perawat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung proses pemulihan. Berikut ini adalah rencana intervensi atau tindakan keperawatan yang dapat diterapkan pada individu dengan waham.

Tabel 2.2 Rencana Tindakan Keperawatan

	Tujuan	Tindakan Keperawatan
Pasien	1. Pasien dapat berorientasi kepada realitas secara bertahap. 2. Pasien dapat memenuhi kebutuhan dasar. 3. Pasien mampu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. 4. Pasien menggunakan obat dengan prinsip lima benar.	1. Bina hubungan saling percaya. hubungan saling percaya. a. Mengucapkan salam terapeutik. b. Berjabat tangan. c. Menjelaskan tujuan interaksi. d. Membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu pasien. 2. Bantu orientasi realitas. a. Tidak mendukung atau membantah waham pasien. b. Yakinkan pasien berada dalam keadaan aman. c. Observasi pengaruh waham terhadap aktivitas sehari-hari. d. Jika pasien terus-menerus membicarakan wahamnya, dengarkan tanpa memberikan dukungan atau menyangkal sampai pasien berhenti membicarakannya. e. Berikan pujian bila penampilan dan orientasi pasien sesuai dengan realitas. 3. Diskusikan kebutuhan psikologis atau emosional yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan marah. a. Tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasien. b. Berdiskusi tentang kemampuan positif yang dimiliki. c. Bantu melakukan kemampuan yang dimiliki. d. Berdiskusi tentang obat yang diminum. e. Melatih minum obat yang benar.

	Tujuan	Tindakan Keperawatan
Keluarga	1. Keluarga mampu mengidentifikasi waham pasien. 2. Keluarga mampu memfasilitasi pasien untuk memenuhi kebutuhan yang dipenuhi oleh wahamnya. 3. Keluarga mampu mempertahankan program pengobatan pasien secara optimal.	1. Diskusikan dengan keluarga tentang waham yang dialami pasien. 2. Diskusikan dengan keluarga tentang hal berikut: a. Cara merawat pasien waham di rumah. b. Follow up dan keteraturan pengobatan. c. Lingkungan yang tepat untuk pasien. 3. Diskusikan dengan keluarga tentang obat pasien (nama obat, dosis, frekuensi, efek). 4. Diskusikan dengan keluarga kondisi pasien yang memerlukan konsultasi segera.

Tabel 2.3 Kriteria Hasil Waham

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ...x24 jam diharapkan status orientasi membaik

Kriteria Hasil:

1. Verbalisasi waham menurun
2. Perilaku waham menurun
3. Perilaku sesuai realita membaik
4. Isi pikir sesuai realita membaik
5. Pembicaraan membaik

b. Implementasi

Implementasi dalam penanganan waham merujuk pada penerapan berbagai intervensi yang bertujuan untuk mengelola gejala, meningkatkan kualitas hidup individu, serta membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan secara lebih efektif. Proses ini melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek psikologis, medis, dan sosial untuk memastikan intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan individu.

Pada masalah gangguan proses pikir: waham terdapat 4 macam Strategi Pelaksanaan (SP) yaitu:

- 1) SP 1: Latihan orientasi realita : orientasi orang, tempat, dan waktu serta lingkungan sekitar.
- 2) SP 2: Mengajarkan cara minum obat secara teratur
- 3) SP 3: Melatih pemenuhan kebutuhan dasar
- 4) SP 4: Melatih kemampuan positif yang dimiliki

c. Evaluasi

Tabel 3.4 Evaluasi Waham

	Evaluasi
Pasien	Pasien mampu melakukan hal berikut: a. Mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan kenyataan. b. Berkomunikasi sesuai kenyataan. c. Menggunakan obat dengan benar dan patuh.
Keluarga	Keluarga mampu melakukan hal berikut: a. Membantu pasien untuk mengungkapkan keyakinannya sesuai kenyataan. b. Membantu pasien melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasien. c. Membantu pasien menggunakan obat dengan benar dan patuh.

I. Pengertian Halusinasi

Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori terhadap suatu objek tanpa adanya rangsangan dari luar. Gangguan persepsi sensori ini dapat meliputi seluruh pancaindra. Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa di mana pasien mengalami perubahan dalam sensori persepsi, sehingga merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penciuman. Pasien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada (Sutejo, 2019).

J. Proses Terjadinya Halusinasi

Memahami bagaimana halusinasi berkembang sangat penting untuk membantu dalam proses penanganan dan intervensi yang tepat. Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan dalam proses terjadinya halusinasi.

Tabel 3.5 Tahapan Halusinasi

Tahapan	Karakteristik Halusinasi	Perilaku Pasien
Tahap I - Comforting (Memberi rasa nyaman) Tingkat ansietas sedang. Secara umum halusinasi merupakan suatu kesenangan.	- Mengalami ansietas kesepian, rasa bersalah, dan ketakutan. - Mencoba berfokus pada pikiran yang dapat menghilangkan ansietas. - Pikiran dan pengalaman sensori masih ada dalam kontrol kesadaran (jika kecemasan dikontrol)	- Tersenyum/tertawa sendiri. - Menggerakkan bibir tanpa suara. - Penggerakan mata yang cepat. - Respons verbal yang lambat. - Diam dan berkonsentrasi.
TAHAP II - Condemning (Menyalahkan) Tingkat kecemasan berat secara umum halusinasi menyebabkan rasa antipati.	- Pengalaman sensori menakutkan. - Mulai merasa kehilangan kontrol. - Merasa dilecehkan oleh pengalaman sensori tersebut. - Menarik diri dari orang lain. - NON PSIKOTIK (masih bisa membedakan antara realita dan khayalan)	- Peningkatan sistem saraf otak, tanda-tanda ansietas, seperti peningkatan denyut jantung, pernapasan, dan tekanan darah. - Rentang perhatian menyempit. - Konsentrasi dengan pengalaman sensori. - Mulai kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dari realita.
TAHAP III - Controlling Mengontrol tingkat kecemasan berat pengalaman sensori tidak dapat ditolak lagi.	- Pasien menyerah dan menerima pengalaman sensorinya. - Isi halusinasi menjadi atraktif. - Kesepian bila pengalaman sensori berakhir. - PSIKOTIK	- Perintah halusinasi ditaati. - Sulit berhubungan dengan orang lain. - Rentang perhatian hanya beberapa detik atau menit. Gejala fisika ansietas berat berkeringat, tremor, dan tidak mampu mengikuti perintah.
TAHAP IV - Conquering Menguasai tingkat kecemasan panik secara umum diatur dan dipengaruhi oleh waham.	- Pengalaman sensori menjadi ancaman. - Halusinasi dapat berlangsung selama beberapa jam atau hari (jika tidak diintervensi). - PSIKOTIK	- Perilaku panik. - Potensial tinggi untuk bunuh diri atau membunuh. - Tindakan kekerasan agitasi, menarik diri, atau katatonía

		(ketidakmampuan untuk bergerak normal). • Tidak mampu berespons terhadap perintah yang kompleks. Tidak mampu berespons terhadap lebih dari satu orang.
--	--	--

K. Jenis-jenis Halusinasi beserta tanda gejalanya

Halusinasi dapat mempengaruhi berbagai indra dan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan indra yang terlibat. Memahami jenis-jenis halusinasi sangat penting untuk membantu dalam proses asesmen, diagnosis, dan penentuan intervensi yang tepat bagi individu yang mengalaminya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai jenis halusinasi yang umum terjadi:

Tabel 3.6 Jenis, Tanda dan Gejala Halusinasi

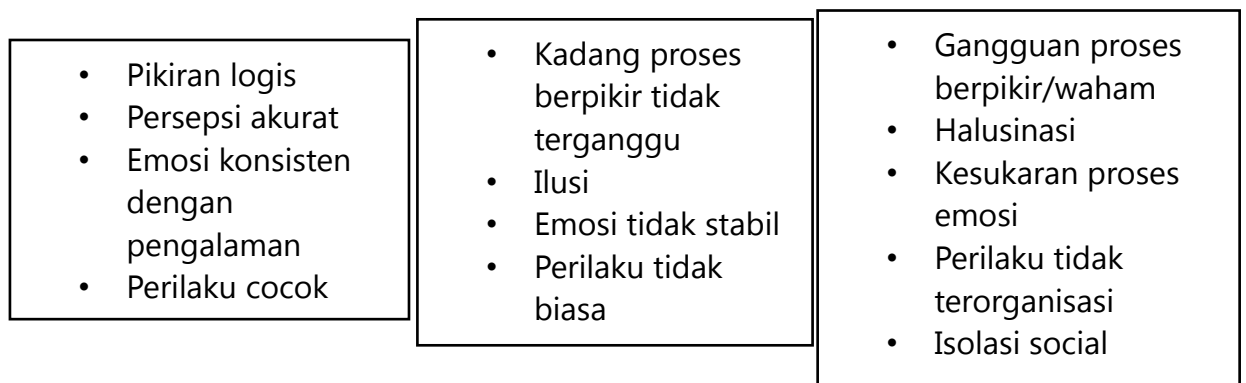
Jenis Halusinasi	Data Objektif	Data Subjektif
Pendengaran/ Suara/ Audotorik	• Bicara atau tertawa sendiri. • Marah-marah tanpa sebab. • Mengarahkan telinga ke arah tertentu. • Menutup telinga	• Mendengar suara-suara atau kegaduhan. • Mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap. • Mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya.
Penglihatan / Visual	• Menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. • Ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas.	• Melihat bayangan, sinar, bentuk geometris, bentuk kartun, melihat hantu, atau monster.
Penciuman / Olfaktori	• Mencium seperti sedang membaui bau-bauan tertentu. • Menutup hidung.	• Membau bau-bauan seperti bawarah, urine, feses, dan kadang kadang bau itu menyenangkan.
Pengecapan / Gustatorik	ering meludah Muntah	• Merasakan rasa seperti darah, urine, atau feses (merasakan sesuatu yang busuk, amis, dan menjijikan)
Perabaan / Taktil	Menggaruk-garuk permukaan kulit.	Mengatakan ada serangga lipermukaan kulit.

		Merasakan sensasi listrik datang dari tanah, benda mati atau orang lain.
Sinestetik		Merasakan fungsi tubuh seperti darah mengalir melalui vena atau arteri, makanan dicerna atau pembentukan urine

L. Rentang Respons Neurobiologi

Setiap individu dapat menunjukkan respons yang berbeda, mulai dari mampu mengenali halusinasi sebagai sesuatu yang tidak nyata (respons adaptif) hingga sepenuhnya mempercayai dan terpengaruh oleh halusinasi tersebut (respons maladaptif). Memahami rentang respons ini penting untuk menentukan pendekatan intervensi yang tepat dalam membantu individu mengelola pengalaman halusinasi secara efektif.

Halusinasi merupakan gangguan dari persepsi sensoris, waham merupakan gangguan pada isi pikiran. Keduanya merupakan gangguan dari respons neurobiologi.



M. Penatalaksanaan Halusinasi

Psikofarmakoterapi

Psikofarmakoterapi merupakan salah satu pendekatan utama dalam penanganan halusinasi, terutama yang berkaitan dengan gangguan psikotik seperti skizofrenia. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala halusinasi melalui penggunaan obat-obatan yang memengaruhi keseimbangan kimia di otak. Dengan pengelolaan yang tepat, psikofarmakoterapi dapat membantu individu meningkatkan fungsi kognitif, emosional, dan sosial mereka. Berikut contoh beberapa obat-obatan yang digunakan:

1. Antipsikotik:

- a. Chlorpromazine (Promactile, Largactile), membuat suasana hati, fase mania, masalah perilaku.
- b. Haloperidol (Haldol, Serenace, Lodomer), manfaat menjernihkan pikiran, mengatasi mania, suasana hati, perilaku, atau level energi.
- c. Stelazine, mengontrol perilaku dan kegelisahan/kecemasan.
- d. Clozapine (Clozaril), menyeimbangkan zat alami kimia otak (neurotransmitter), seperti dopamin, histamin, dan serotonin sehingga gejala mereda .
- e. Risperidone (Risperdal), menstabilkan emosi, menjernihkan pikiran.

2. Antiparkinson:

- a. Trihexyphenidile, meredakan gejala ekstrapiramidal meliputi kekakuan otot, gerak tubuh yang tidak terkendali, dan tremor.
- b. Arthan

N. Asuhan Keperawatan Klien Dengan Halusinasi

1. Pengkajian

- a. Faktor predisposisi adalah kondisi atau keadaan yang meningkatkan kerentanan seseorang untuk mengalami halusinasi. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - 1) Faktor Perkembangan: Gangguan perkembangan kognitif dan emosional pada masa kanak-kanak dapat meningkatkan risiko halusinasi di kemudian hari (Stuart & Laraia, 2005).
 - 2) Faktor Sosial Budaya: Isolasi sosial, norma budaya yang kaku, serta pengalaman trauma dalam lingkungan sosial dapat mempengaruhi munculnya halusinasi (Keliat, 2019).
 - 3) Faktor Psikologis: Kondisi seperti gangguan kecemasan, depresi berat, atau gangguan kepribadian dapat menjadi pemicu internal bagi timbulnya halusinasi.

- 4) Faktor Biologis: Ketidakseimbangan neurotransmitter, khususnya dopamin, berperan penting dalam patofisiologi halusinasi, terutama pada gangguan psikotik.
 - 5) Faktor Genetik: Riwayat keluarga dengan gangguan psikotik atau gangguan kejiwaan lainnya dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami halusinasi (Stuart & Laraia, 2005)
- b. Faktor presipitasi adalah pemicu langsung yang menyebabkan halusinasi muncul pada individu yang sudah rentan. Faktor-faktor tersebut meliputi:
- 1) Stresor Sosial Budaya: Tekanan dari lingkungan, seperti konflik keluarga, diskriminasi, atau peristiwa traumatis, dapat menjadi pemicu munculnya halusinasi (Keliat, 2019).
 - 2) Faktor Biokimia: Perubahan mendadak dalam keseimbangan kimia otak, misalnya akibat penggunaan obat-obatan psikoaktif atau gangguan metabolisme, dapat memicu halusinasi.
 - 3) Faktor Psikologis: Stres akut, kecemasan ekstrem, atau trauma psikologis dapat memicu respons psikotik sementara, termasuk halusinasi.
 - 4) Perilaku: Kebiasaan buruk seperti penyalahgunaan zat, kurang tidur, atau pola hidup tidak sehat juga dapat mempercepat munculnya gejala halusinasi.
- c. Pengkajian pada aspek perilaku, terkait:
- 1) Isi Halusinasi
 - 2) Waktu Terjadi
 - 3) Frekuensi
 - 4) Situasi Pencetus
 - 5) Respon Klien
- d. Pengkajian pada mekanisme koping, biasanya ditemukan berikut ini:
- 1) Regresi
Regresi adalah mekanisme pertahanan diri di mana individu kembali ke pola perilaku yang lebih primitif atau kekanak-kanakan sebagai respons terhadap stres atau konflik yang tidak dapat diatasi secara dewasa (Stuart & Laraia, 2005).
 - 2) Proyeksi
Proyeksi merupakan mekanisme pertahanan di mana individu mengalihkan perasaan, pikiran, atau dorongan yang tidak dapat diterima kepada orang lain, seolah-olah perasaan tersebut berasal dari luar dirinya (Kaplan & Sadock, 2017).

3) Menarik Diri

Menarik diri adalah kondisi di mana individu menghindari interaksi sosial dan memilih untuk mengisolasi diri sebagai bentuk respons terhadap kecemasan, depresi, atau stres psikologis (Keliat, 2019).

4) Keluarga Mengingkari

Keluarga mengingkari terjadi ketika anggota keluarga tidak mengakui atau menyangkal adanya masalah kesehatan mental pada salah satu anggotanya, sering kali karena stigma atau ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan tersebut (Maramis, 2010).

e. Pohon masalah



Gambar 2.3 Pohon Masalah

2. Diagnosis :

- a. Risiko kekerasan berhubungan dengan halusinasi.
- b. Gangguan persepsi sensori: halusinasi berhubungan dengan isolasi social

3. Rencana Intervensi

Tabel 2.7 Tindakan Keperawatan Halusinasi

	Tujuan	Tindakan Keperawatan
Pasien	1. Pasien mengenali halusinasi yang dialaminya. 2. Pasien dapat mengontrol halusinasinya. 3. Pasien mengikuti program pengobatan secara optimal.	1. Membantu pasien mengenali halusinasi dengan cara berdiskusi dengan pasien tentang isi halusinasi (apa yang didengar/dilihat), waktu terjadi halusinasi, frekuensi terjadinya halusinasi, situasi yang menyebabkan halusinasi muncul, dan respons pasien saat halusinasi muncul. 2. Melatih pasien mengontrol halusinasi. Untuk membantu pasien agar mampu mengontrol halusinasi, Anda dapat melatih pasien empat cara yang sudah terbukti dapat mengendalikan halusinasi, yaitu sebagai berikut. a. Menghardik halusinasi. b. Bercakap-cakap dengan orang lain. c. Melakukan aktivitas yang terjadwal. d. Menggunakan obat secara teratur. 3. TAK: Stimulasi persepsi – halusinasi
Keluarga	1. Keluarga dapat terlibat dalam perawatan pasien baik di rumah sakit maupun di rumah. 2. Keluarga dapat menjadi sistem pendukung yang efektif untuk pasien.	1. Diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. 2. Berikan pendidikan kesehatan tentang pengertian halusinasi, jenis halusinasi yang dialami pasien, tanda dan gejala halusinasi, proses terjadinya halusinasi, serta cara merawat pasien halusinasi. 3. Berikan kesempatan kepada keluarga untuk memperagakan cara merawat pasien dengan halusinasi langsung di hadapan pasien. 4. Buat perencanaan pulang dengan keluarga.

Secara umum, tindakan keperawatan halusinasi bertujuan untuk membantu individu mengelola dan mengurangi intensitas serta dampak dari pengalaman persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berikut ini beberapa tindakan keperawatannya :

a. Bina hubungan saling percaya dengan cara

- 1) Mengucap salam
- 2) Berkenalan dg klien
- 3) Buat kontrak asuhan yang jelas
- 4) Dengarkan ungkapan klien dg empati
- 5) Tidak menentang atau menyetujui ungkapan klien
- 6) Jujur dan tepati janji
- 7) Penuhi kebutuhan dasar klien

b. Identifikasi Halusinasi.

- 1) Kontak singkat dan sering
- 2) Jika klien sedang halusinasi:
- 3) Klarifikasi apa yg dialami
- 4) Katakan perawat percaya klien, namun tdk mengalami sensasi serupa.
- 5) Katakan ada klien yang mengalami hal yang sama
- 6) Katakan, perawat akan membantu klien.
- 7) Jika klien tdk sedang mengalami halusinasi:
- 8) Diskusikan isi, waktu, frekuensi
- 9) Diskusikan hal yg menimbulkan atau tdk menimbulkan halusinasi
- 10) Diskusikan apa yg dilakukan jika halusinasi timbul
- 11) Diskusikan dampak jika klien menikmati halusinasi
- 12) Diskusikan perasaan klien saat mengalami halusinasi

c. Latih klien mengendalikan halusinasi.

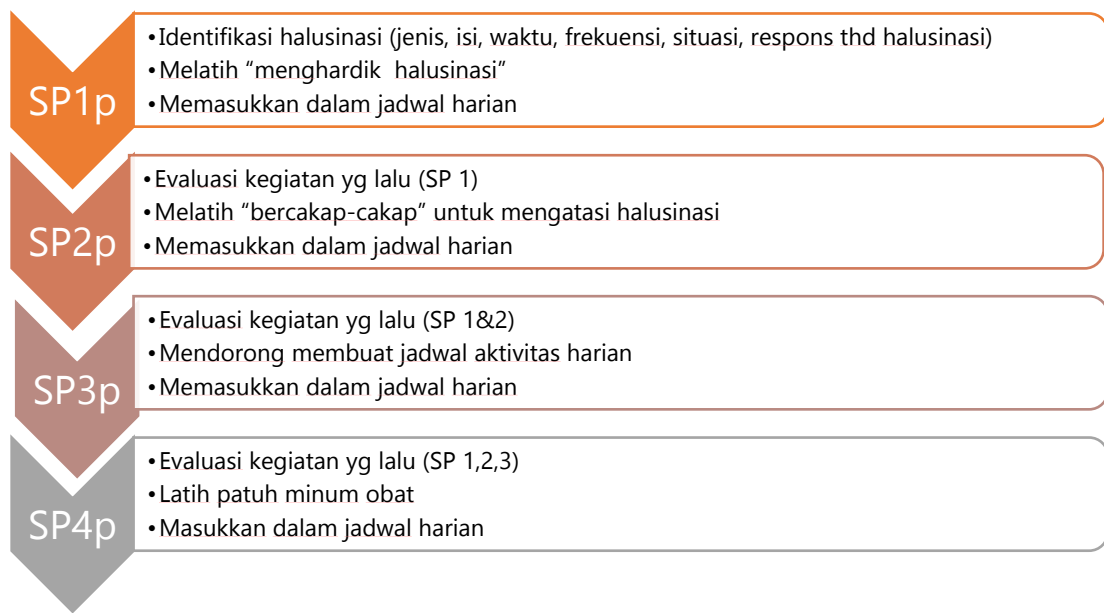
- 1) Identifikasi cara yg dilakukan klien untuk mengendalikan halusinasi
- 2) Diskusikan cara yg digunakan, bila adaptif berikan pujian
- 3) Diskusikan cara mengendalikan halusinasi
 - a) Menghardik halusinasi
 - Dilakukan saat sedang mengalami halusinasi.
 - Katakan pada diri "Saya tak mau dengar/ lihat kamu"
 - Untuk meningkatkan kendali diri; tidak mengikuti isi halusinasi
 - b) Berbincang dengan orang lain
 - Dilakukan menjelang halusinasi muncul (tanda-tanda awal halusinasi)
 - Berbicara dengan orang lain memaparkan pada stimulus eksternal.
 - Menurunkan fokus perhatian pada stimulus internal (halusinasi)

- c) Mengatur jadwal aktivitas
 - Halusinasi terjadi karena banyak waktu luang.
 - Mengatur jadwal aktivitas; meminimalisasi waktu luang
 - Membuat jadwal harian, menepati jadwal.
- d) Menggunakan obat secara teratur
 - Diskusikan manfaat obat, akibat jika tidak minum obat.
 - Jelaskan jenis obat, warna, dosis, cara minum, efek terapi, efek samping.
 - Pantau saat menggunakan obat
 - Diskusikan dampak putus obat
 - Anjurkan klien untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan
- d. Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)
 - 1) TAK Orientasi Realita
 - a) Mengenal orang
 - b) Mengenal tempat
 - c) Mengenal waktu
 - 2) TAK Stimulasi Persepsi: mengontrol halusinasi
 - a) Mengenal halusinasi
 - b) Menghardik halusinasi
 - c) Bercakap-cakap
 - d) Jadwal aktivitas
 - e) Menggunakan obat
- e. Pendidikan Kesehatan Keluarga untuk Merawat Klien Halusinasi
 - 1) Buat kontrak
 - 2) Jelaskan:
 - a) Definisi Halusinasi
 - b) Tanda dan gejala halusinasi
 - c) Proses terjadinya
 - d) Cara memutus halusinasi
 - e) Obat utk klien
 - f) Cara merawat di rumah
 - g) Waktu kontrol

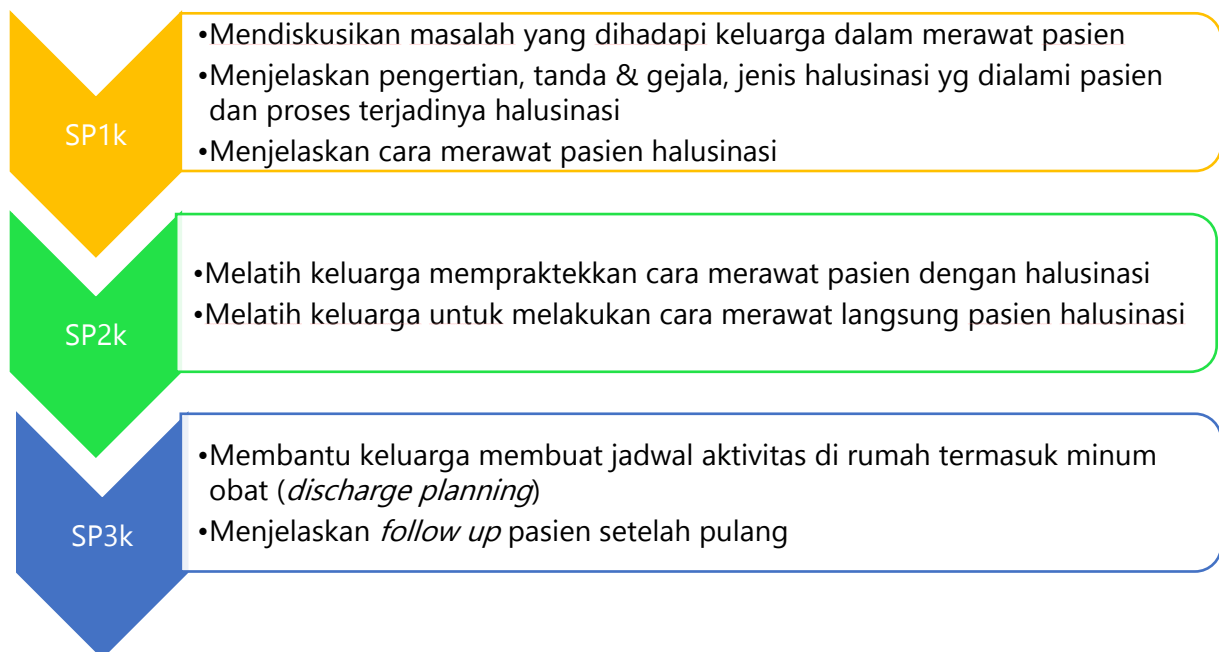
4. Implementasi

Implementasi strategi pelaksanaan standar prosedur (SP) pada pasien dengan halusinasi merupakan langkah penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan terarah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai strategi pelaksanaan SP untuk pasien dan keluarga dengan halusinasi.

a. Strategi Pelaksanaan SP Pasien Halusinasi



b. Strategi Pelaksanaan Sp Keluarga Pasien Halusinasi



5. Evaluasi

Tabel 2.8 Evaluasi Halusinasi

	Evaluasi
Pasien	1. Pasien mempercayai kepada perawat. 2. Pasien menyadari bahwa yang dialaminya tidak ada objeknya dan merupakan masalah yang harus diatasi. 3. Pasien dapat mengontrol halusinasi.
Keluarga	Keluarga mampu merawat pasien di rumah, ditandai dengan hal berikut. 1. Keluarga mampu menjelaskan masalah halusinasi yang dialami oleh pasien. 2. Keluarga mampu menjelaskan cara merawat pasien di rumah. 3. Keluarga mampu memperagakan cara bersikap terhadap pasien. 4. Keluarga mampu menjelaskan fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pasien. 5. Keluarga melaporkan keberhasilannya merawat pasien.

O. Latihan Soal

1. Seorang laki laki berusia 44 tahun dirawat di RS Jiwa. Hasil pengkajian di dapatkan data klien. Mengatakan, "Saya tahu..kalian semua memasukkan racun ke dalam makanan saya" dengan ekspresi waspada. Apakah jenis waham yang sesuai dengan kasus diatas ?
 - A. Waham curiga
 - B. Waham agama
 - C. Waham somatic
 - D. Waham nihilistic
 - E. Waham kebesaran
2. Yang termasuk tanda dan gejala waham dalam aspek afektif adalah....
 - A. Individu sangat percaya pada keyakinannya
 - B. Afek tumpul
 - C. Hipersensitif
 - D. Nafsu makan berkurang dan sulit tidur
 - E. Impulsif
3. Seorang pasien pria, 35 tahun, mengatakan bahwa ia melihat bayangan besar bergerak di dalam ruangan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Ketika ditanya lebih lanjut, pasien menyebutkan bahwa bayangan tersebut terlihat nyata dan membuatnya takut. Setelah perawat cek ternyata ruangan

dalam kondisi kosong. Pada proses pengkajian,, apakah jenis halusinasi yang dialami pasien ?

- A. Halusinasi visual
 - B. Halusinasi auditorik
 - C. Halusinasi taktil
 - D. Halusinasi olfaktori
 - E. Halusinasi gustatorik
4. Berikut ini merupakan faktor presipitasi dari halusinasi, kecuali....
- A. Stresor sosial budaya
 - B. Faktor biokimia
 - C. Faktor psikologis
 - D. Perilaku
 - E. Faktor genetik
5. Rencana Tindakan keperawatan untuk keluarga dengan pasien halusinasi yaitu:
- Diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien.
 - Berikan pendidikan kesehatan tentang pengertian halusinasi, jenis halusinasi yang dialami pasien, tanda dan gejala halusinasi, proses terjadinya halusinasi, serta cara merawat pasien halusinasi.
 - Berikan kesempatan kepada keluarga untuk memperagakan cara merawat pasien dengan halusinasi langsung di hadapan pasien.
 - Buat perencanaan pulang dengan keluarga.
- Manakah diantara pernyataan diatas yang benar?
- A. 1 dan 3
 - B. 2 dan 4
 - C. 1, 2, dan 3
 - D. 4 saja
 - E. Semua pernyataan benar

P. Latihan Kasus

Tn. H (40 tahun) dibawa ke RSJ SL setelah dua hari menghilang dari rumah dan ditemukan oleh keluarga di bawah jembatan layang dalam keadaan tidak memakai baju. Saat dilakukan pengkajian, Tn. H mengatakan kalau dia adalah orang bebas yang suci dari dosa. Tn. H banyak berbicara tetapi tidak bisa dipahami isi pembicaraannya, sering berganti topik, dan menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan perawat. Menurut keluarga, hal itu terjadi setelah Tn. H dipecat dari tempatnya bekerja satu tahun yang lalu karena dituduh menggelapkan uang proyek di perusahaannya. Setelah itu, Tn.H tidak mau bekerja lagi dan selalu di rumah.

Berdasarkan kasus di atas :

1. Identifikasi jenis halusinasi klien
2. Buat pohon masalah
3. Identifikasi diagnosa keperawatan
4. Susun tujuan, kriteria hasil, intervensi utama serta tindakan keperawatan
5. Buat evaluasi keperawatan

Q. Kunci Jawaban

1. A

Pembahasan:

Mari tinjau setiap pilihan jawaban beserta alasannya, jenis waham yang sesuai:

- A. Waham Curiga (Paranoid Delusion): Keyakinan bahwa orang lain berniat jahat, ingin mencelakai, meracuni, atau mengawasi dirinya. Ini sesuai dengan pernyataan pasien yang merasa makanannya diracuni.
- B. Waham Agama: Berkaitan dengan keyakinan atau pengalaman spiritual yang tidak realistis.
- C. Waham Somatik: Keyakinan salah tentang kondisi fisik atau tubuh, seperti merasa ada cacing di bawah kulit.
- D. Waham Nihilistik: Keyakinan bahwa dirinya, dunia, atau bagian tubuhnya tidak ada atau sudah hancur.
- E. Waham Kebesaran: Keyakinan berlebihan mengenai kekuasaan, kemampuan, atau identitas diri yang luar biasa

Jadi, jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah A.

2. B

Pembahasan:

Mari tinjau setiap pilihan jawaban beserta alasannya

Waham dapat memengaruhi berbagai aspek individu, termasuk aspek kognitif, afektif, dan perilaku.

- Aspek Afektif berkaitan dengan perasaan atau ekspresi emosi seseorang.
- Afek Tumpul (Blunted Affect) adalah kondisi di mana individu menunjukkan ekspresi emosi yang datar, kurang responsif, atau tidak sesuai dengan situasi. Ini sering terlihat pada individu dengan gangguan psikotik, termasuk mereka yang mengalami waham.

Pilihan Jawaban Lain:

- A. Individu sangat percaya pada keyakinannya → Ini termasuk aspek kognitif, karena berkaitan dengan pola pikir dan keyakinan.
- B. Hipersensitif → Lebih berkaitan dengan respons emosional berlebihan atau persepsi lingkungan, bukan langsung aspek afektif.

- C. Nafsu makan berkurang dan sulit tidur → Ini adalah gejala fisik atau somatik, bukan afektif.
- D. Impulsif → Berkaitan dengan kontrol perilaku, masuk ke aspek perilaku, bukan afektif.

Jadi, jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah B.

3. A

Pembahasan:

Mari tinjau setiap pilihan jawaban beserta alasannya

A. Halusinasi visual:

Halusinasi visual terjadi ketika seseorang melihat sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada di lingkungan.

B. Halusinasi taktil:

Halusinasi taktil melibatkan sensasi pada kulit atau tubuh, seperti merasakan ada sesuatu yang menyentuh, menekan, atau merayap di kulit. Dalam kasus ini, pasien tidak menyebutkan adanya sensasi fisik atau taktil. Opsi ini tidak relevan.

C. Halusinasi auditorik:

Halusinasi auditorik melibatkan persepsi suara yang tidak nyata, seperti mendengar suara-suara, bisikan, atau musik yang tidak berasal dari sumber eksternal. Dalam kasus ini, pasien tidak melaporkan mendengar suara apapun. Oleh karena itu, opsi ini salah.

D. Halusinasi olfaktori:

Halusinasi olfaktori melibatkan persepsi bau yang tidak nyata, seperti mencium bau busuk atau wangi tanpa adanya sumber bau tersebut. Dalam kasus ini, pasien tidak melaporkan adanya bau tertentu. Oleh karena itu, opsi ini salah.

E. Halusinasi gustatorik:

Halusinasi gustatorik melibatkan persepsi rasa (gustasi) yang tidak nyata, seperti merasa mencicipi sesuatu yang aneh atau tidak ada sumbernya. Dalam kasus ini, pasien tidak melaporkan sensasi rasa. Opsi ini tidak sesuai

Jadi, jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah A.

4. E

Pembahasan:

Faktor presipitasi adalah faktor yang memicu atau mempercepat timbulnya suatu gangguan, dalam hal ini halusinasi. Faktor presipitasi biasanya bersifat situasional atau lingkungan, yang menyebabkan munculnya gejala pada individu yang rentan.

Faktor-faktor presipitasi halusinasi meliputi:

A. Stresor Sosial Budaya: Seperti tekanan hidup, isolasi sosial, konflik keluarga, atau perubahan lingkungan yang ekstrem.

- B. Faktor Biokimia: Ketidakseimbangan neurotransmitter (misalnya, dopamin berlebih dalam skizofrenia) bisa memicu halusinasi.
- C. Faktor Psikologis: Trauma, stres berat, atau gangguan emosi yang mendalam dapat menjadi pemicu.
- D. Perilaku: Pola tidur yang buruk, penyalahgunaan zat (narkoba, alkohol), atau kebiasaan yang meningkatkan risiko stres mental.

Mengapa Bukan E?

- E. Faktor Genetik adalah faktor predisposisi atau faktor risiko jangka panjang yang membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan psikotik, termasuk halusinasi. Namun, faktor ini bukan faktor presipitasi, karena tidak secara langsung memicu munculnya gejala dalam waktu singkat.

Jadi, jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah E.

5. E

Pembahasan:

Rencana tindakan keperawatan untuk keluarga dengan pasien halusinasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan merawat, dan kesiapan keluarga dalam menghadapi kondisi pasien. Semua pernyataan yang diberikan sesuai dengan pendekatan yang benar dalam keperawatan jiwa.

Jadi, jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah E

R. Rangkuman

1. Waham adalah keyakinan yang salah dan bertahan lama meskipun bertentangan dengan realitas.
2. Jenis waham meliputi waham kebesaran, curiga, agama, somatik, nihilistik, dan bizarre.
3. Tanda dan gejala waham melibatkan gangguan kognitif, afektif, perilaku, dan fisik.
4. Faktor predisposisi waham meliputi faktor genetik, biologis, psikologis, dan lingkungan, sedangkan faktor presipitasi mencakup stresor lingkungan dan kondisi psikososial.
5. Penatalaksanaan waham melibatkan psikofarmakologi, seperti antipsikotik dan litium, serta intervensi non-farmakologis seperti psikoterapi dan rehabilitasi psikososial.
6. Asuhan keperawatan mencakup pengkajian status mental, pohon masalah, diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Intervensi meliputi membina hubungan saling percaya, orientasi realita, dan dukungan keluarga. Evaluasi keberhasilan asuhan diukur dari penurunan gejala waham, peningkatan orientasi realita, serta kepatuhan terhadap pengobatan.

7. Halusinasi adalah persepsi sensori tanpa rangsangan eksternal yang nyata.
8. Jenis halusinasi dibagi menjadi auditori, visual, olfaktori, gustatorik, dan taktil. Gejala halusinasi bergantung pada jenis indra yang terlibat, seperti mendengar suara tanpa sumber atau melihat objek yang tidak ada.
9. Faktor predisposisi meliputi faktor genetik, biologis, psikologis, dan sosial budaya, sedangkan faktor presipitasi mencakup stresor lingkungan dan kondisi psikososial.
10. Penatalaksanaan halusinasi melibatkan penggunaan antipsikotik dan intervensi non-farmakologis, seperti terapi perilaku dan dukungan psikososial.
11. Asuhan keperawatan meliputi pengkajian status mental, identifikasi isi halusinasi, diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Intervensi berfokus pada membantu pasien mengenali dan mengontrol halusinasi, penggunaan obat secara teratur, serta melibatkan keluarga dalam perawatan.
12. Evaluasi keberhasilan asuhan diukur dari penurunan frekuensi dan intensitas halusinasi, peningkatan kontrol diri, serta kepatuhan terhadap pengobatan.

S. Glosarium

Antipsikotik: Obat yang digunakan untuk mengelola gejala psikotik seperti waham dan halusinasi.

Diagnosis Keperawatan: Penilaian klinis mengenai respons individu terhadap masalah kesehatan.

Dukungan Keluarga: Keterlibatan keluarga dalam proses perawatan untuk mendukung pemulihan pasien.

Evaluasi: Proses untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan dan hasil yang dicapai.

Faktor Predisposisi: Faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan mental.

Faktor Presipitasi: Faktor pemicu yang menyebabkan timbulnya atau memperburuk kondisi gangguan mental.

Halusinasi: Persepsi sensori terhadap sesuatu yang tidak ada rangsangan eksternal.

Intervensi Keperawatan: Tindakan yang dilakukan perawat untuk membantu klien mencapai tujuan kesehatan.

Litium: Obat penstabil suasana hati yang digunakan dalam pengobatan gangguan bipolar.

Orientasi Realita: Kemampuan seseorang untuk memahami dan mengenali kenyataan di sekitarnya.

Pohon Masalah: Analisis sistematis untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam asuhan keperawatan.

Psikofarmakologi: Ilmu tentang penggunaan obat-obatan untuk mengobati gangguan mental.

Psikoterapi: Terapi berbicara yang membantu individu mengatasi masalah emosional dan mental.

Rehabilitasi Psikososial: Program yang membantu individu mengembangkan keterampilan sosial dan fungsional.

Waham: Keyakinan yang salah yang bertahan lama meskipun bertentangan dengan kenyataan.

T. Daftar Pustaka

Direja, A. H. S. (2011). Buku ajar asuhan keperawatan jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika.

Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015). Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2017). Concise textbook of clinical psychiatry (4th ed.). Wolters Kluwer.

Keliat, B. A. (2019). Asuhan keperawatan jiwa. Jakarta: EGC.

Keliat, B. A., Akemat, H. N. C. D., & Nurhaeni, H. (2007). Keperawatan kesehatan jiwa komunitas: CMHN (basic course). Jakarta: EGC.

Maramis, W. F. (2010). Catatan ilmu kedokteran jiwa. Surabaya: Airlangga University Press.

Mundakir, M. K. (2021). Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa 1. Surabaya: UM Surabaya Publishing.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2017). Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik (Edisi 1, Cetakan III, Revisi). Jakarta: PPNI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan (Edisi 1, Cetakan II). Jakarta: PPNI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2019). Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan (Edisi 1, Cetakan II). Jakarta: PPNI.

Prastika, Y., Mundakir, S. K., & Reliani, S. K. (2014). Asuhan keperawatan jiwa pada pasien waham kebesaran dengan diagnosis medis skizofrenia hebefrenik di ruang Flamboyan RS Jiwa Menur (Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Surabaya). Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Stuart, G. W., & Laraia, M. T. (2005). Principles and practice of psychiatric nursing (8th ed.). St. Louis, MO: Mosby.
- Stuart, G. W., & Sundeen, S. J. (2002). Buku saku keperawatan jiwa (Edisi 3). Jakarta: EGC.
- Suliswati. (2004). Konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa. Jakarta: EGC.
- Sutejo. (2019). Keperawatan kesehatan jiwa: Prinsip dan praktik keperawatan asuhan jiwa. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Varcarolis, E. M. (2006). Fundamentals of psychiatric nursing (5th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Yusuf, A. H., P. K., R. F., & Nihayati, H. E. (2015). Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa. Jakarta: Salemba.

BAB 3

ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI DEFISIT PERAWATAN DIRI

Pendahuluan

Masalah defisit perawatan diri sering ditemukan pada penderita gangguan jiwa. Perawat memiliki peran penting dalam membantu klien meningkatkan kemampuan perawatan diri dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang berbasis bukti serta strategi komunikasi yang memperhatikan kebutuhan dan latar belakang sosial budaya klien.

Bab ini akan membahas tentang konsep defisit perawatan diri dan asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dari penulisan bab ini adalah agar peserta didik mampu memahami asuhan keperawatan pada klien dengan defisit perawatan diri dalam konteks penderita gangguan jiwa. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi sarjana keperawatan.

Gambaran pembahasan pada bab ini mencakup konsep dasar seperti pengertian, penyebab, tanda dan gejala, model/teori yang mendasari sampai konsep asuhan keperawatan. Struktur bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan defisit perawatan diri dalam konteks gangguan jiwa berdasarkan bukti ilmiah teori dan penelitian keperawatan.

Tujuan Instruksional Khusus

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian defisit perawatan diri
- Mahasiswa mampu menganalisa penyebab defisit perawatan diri
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala defisit perawatan diri
- Mahasiswa mampu menjelaskan teori *self-care deficit* Orem
- Mahasiswa mampu menjelaskan penatalaksanaan defisit perawatan diri
- Mahasiswa mampu menjelaskan kondisi klinis defisit perawatan diri

- Mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan defisit perawatan diri

Capaian Pembelajaran:

Kognitif

Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas, keperawatan gawat darurat dan kritis, manajemen keperawatan, serta keperawatan bencana;

Psikomotor

- Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan;
- Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis;

Afektif

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.
- Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pengertian dan penyebab, tanda dan gejala, model teori Orem, kondisi klinis terkait, serta asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa intervensi dan implementasi, evaluasi pada klien dengan defisit perawatan diri.

A. Pengertian Defisit Perawatan Diri

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan perawatan diri sebagai kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menjaga kesehatan, dan mengatasi penyakit dan disabilitas dengan atau tanpa dukungan penyedia layanan kesehatan (WHO, 2014). Defisit Perawatan Diri (DPD) merupakan suatu kondisi dimana penderita mengalami gangguan atau hambatan dalam melakukan aktivitas perawatan dirinya. Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Defisit Perawatan Diri didefinisikan sebagai sikap tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri (PPNI, 2017). Defisit perawatan diri mencakup ketidakmampuan individu dalam menjaga kebersihan diri, kerapian dalam berpakaian, aktivitas makan dan minum, kemampuan eliminasi dan keterkaitan dengan lingkungan (Keliat et al., 2019).

Menurut Teori Orem, defisit perawatan diri didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan (Wilkinson & Ahern, 2013). Defisit perawatan diri dapat disebabkan oleh gangguan fisik, kognitif, atau emosional. Tujuan perawatan dalam konteks ini adalah untuk menilai kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri dan mengembangkan intervensi yang memungkinkan atau membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Perawat dalam hal ini memiliki peran besar sehingga perlu adanya pemahaman tentang asuhan keperawatan pada klien dengan defisit perawatan diri.

Pada penderita gangguan jiwa, masalah defisit perawatan diri bisa ditemukan akibat dari berbagai faktor kognitif, emosional, perilaku, dan sosial yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pribadi. Kondisi kesehatan mental dapat secara signifikan mengganggu motivasi, kesadaran diri, dan kapasitas seseorang untuk terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Hambatan/gangguan kemampuan merawat diri pada klien skizofrenia disebabkan oleh gangguan kognitif atau persepsi (Wilkinson & Ahern, 2013). Beberapa gangguan yang dialami oleh klien skizofrenia seperti gangguan perilaku, persepsi, ketidakmampuan kognitif dan hal ini menyebabkan klien tidak dapat merawat dirinya sendiri. Klien dapat sangat disibukkan dengan

delusi atau halusinasi hingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari (Videbeck Sheila L, 2011).

B. Teori Self-care Deficit Orem

Orem menyatakan bahwa perawatan diri (*self-care*) merupakan konsep luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan tidak hanya manajemen penyakit, meskipun fokus keperawatan yang utama memberikan dukungan terhadap perawatan diri akibat dampak dari penyakit atau masalah kesehatan (Hellqvist, 2021).

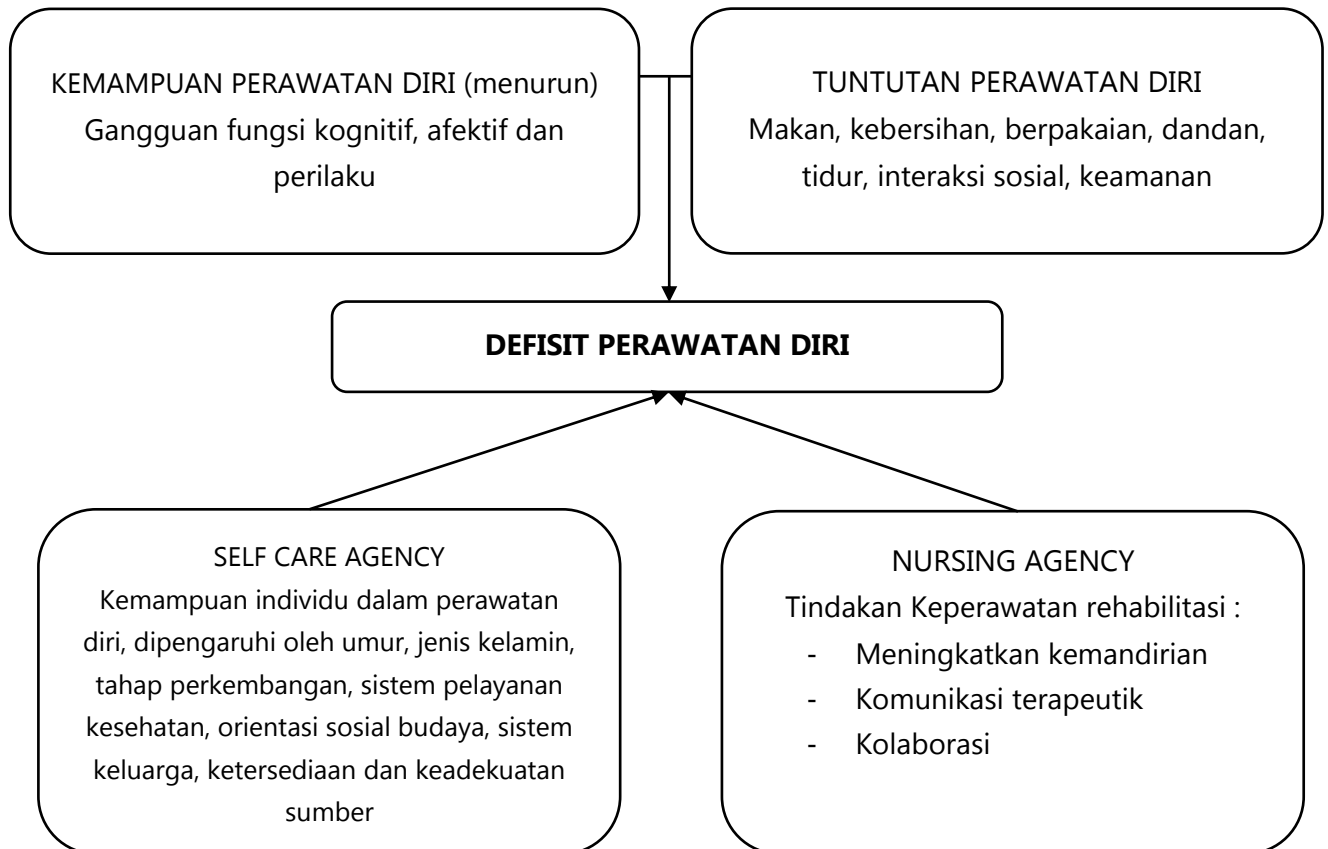
Teori Defisit Perawatan Diri Orem merupakan konsep dasar dalam keperawatan yang berfokus pada kemampuan individu untuk melakukan aktivitas perawatan diri yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Menurut Orem, ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan diri mereka karena penyakit yang diderita atau cedera, atau keterbatasan, maka akan muncul masalah defisit perawatan diri. Defisit ini menciptakan kebutuhan akan intervensi keperawatan untuk mendukung individu dalam mendapatkan kembali atau mempertahankan kemampuan perawatan diri. Pada penderita gangguan jiwa, kondisi penyakit yang mereka derita menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas perawatan diri. Model Orem dibangun atas tiga komponen utama: perawatan diri, defisit perawatan diri, dan sistem keperawatan. Perawatan diri mengacu pada aktivitas yang dilakukan individu untuk meningkatkan kesehatan, seperti makan, mandi, berpakaian, berhias, dan mengelola kondisi kronis. Ketika seseorang tidak dapat melakukan aktivitas ini secara mandiri, maka akan teridentifikasi defisit perawatan diri, dan peran perawat adalah untuk melakukan intervensi dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui pendidikan, perawatan langsung, atau alat pendukung.

Teori Defisit Perawatan Diri Orem khususnya relevan dalam perawatan individu dengan gangguan kesehatan mental, karena kondisi ini sering kali mengganggu kemampuan individu untuk melakukan tugas perawatan diri. Gangguan kesehatan mental, seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan bipolar, dapat menyebabkan gangguan kognitif, disregulasi emosi, dan kurangnya motivasi, yang semuanya mengganggu aktivitas perawatan diri sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mengalami depresi mungkin kekurangan energi atau motivasi untuk makan, mandi, atau bahkan terlibat dalam interaksi sosial, yang menyebabkan pengabaian kebutuhan kesehatan dasar. Dalam kasus seperti itu, intervensi keperawatan, berdasarkan teori Orem, bertujuan untuk menilai defisit spesifik individu dan memberikan dukungan yang ditargetkan, seperti mendorong rutinitas kebersihan, membantu manajemen pengobatan, dan meningkatkan nutrisi dan istirahat.

Perawat juga dapat mendidik pasien tentang cara mengelola kondisi mereka, memberi mereka keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan otonomi mereka dalam jangka panjang.

Penerapan teori Orem dalam perawatan kesehatan mental melibatkan berbagai intervensi keperawatan yang dirancang untuk memberdayakan individu agar dapat mengendalikan kesehatan mereka dan mengurangi defisit perawatan diri. Perawat dapat menggunakan kombinasi perawatan langsung dan strategi edukasi untuk mengatasi defisit perawatan diri pada pasien kesehatan mental. Misalnya, individu dengan skizofrenia mungkin kesulitan mematuhi pengobatan karena gangguan kognitif, dan perawat dapat memberikan dukungan melalui pengingat pengobatan, menetapkan rutinitas, dan mendidik pasien tentang pentingnya perawatan yang konsisten. Selain itu, perawat dapat bekerja dengan individu untuk mengidentifikasi hambatan dalam perawatan diri, seperti isolasi sosial atau kurangnya motivasi, dan membantu mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan ini. Dengan menerapkan Teori Defisit Perawatan Diri Orem, perawat dapat memainkan peran penting dalam memulihkan kemampuan perawatan diri dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi mereka yang hidup dengan gangguan mental.

Susanti, (2010) menguraikan skema defisit perawatan diri pada penderita gangguan jiwa khususnya Skizofrenia berdasarkan teori Orem sebagai berikut..



C. Penyebab Defisit Perawatan Diri dalam Konteks Gangguan Jiwa

Defisit perawatan diri terjadi ketika seseorang tidak mampu melakukan aktivitas yang menjaga kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologisnya. Berbagai faktor dapat menyebabkan timbulnya defisit perawatan diri. Penyebab ini dapat berasal dari faktor fisik, psikologis, kognitif, atau lingkungan, dan dapat bersifat sementara atau jangka panjang. Pada penderita gangguan jiwa, faktor yang berhubungan dengan Defisit Perawatan Diri antara lain:

1. Karakteristik Demografis Pasien

Karakteristik demografi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan perawatan diri pasien. Pertama, tingkat pendidikan pasien mempengaruhi seluruh dimensi kemampuan perawatan diri meliputi aktivitas dasar sehari-hari, pekerjaan rumah tangga, dan fungsi sosial, yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kuat kemampuan perawatan diri (Chen et al., 2022).

2. Perjalanan Penyakit

Semakin lama perjalanan penyakit, semakin lemah kemampuan pasien untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan fungsi sosial. Gangguan mental,

sebagai penyakit kronis, memiliki karakteristik perjalanan penyakit yang panjang dan sering kambuh. Pasien cenderung kehilangan kepercayaan diri dan menjadi negatif, secara bertahap beralih dari pengobatan komplementer ke terapi resistensi dalam proses pengobatan jangka panjang.

3. Faktor Sosial

Prasangka dan diskriminasi sering terjadi di masyarakat, dan pasien memiliki rasa stigma yang membuat mereka kehilangan identitas sosial, sehingga mengakibatkan kerusakan fungsi sosial yang lebih serius. Oleh karena itu, perlu untuk mempopulerkan pengetahuan kesehatan mental di seluruh masyarakat. Dengan cara ini, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit mental dan mengubah prasangka masyarakat terhadap gangguan mental.

D. Tanda dan Gejala Defisit Perawatan Diri

Dalam mengasuh pasien dengan dengan defisit perawatan diri, perawat perlu memperhatikan tanda dan gejala yang dimanifestasikan oleh pasien. Tanda dan gejala ini biasanya bisa diobservasi dan bisa juga didapatkan melalui wawancara. Defisit perawatan diri menurut Keliat dkk, (2019) dimanifestasikan sebagai berikut :

1. Subjektif

- a. Ungkapan penolakan untuk melakukan aktivitas perawatan diri.
- b. Klien menyampaikan ketidakinginan melakukan perawatan diri.
- c. Klien menyatakan tidak tahu cara perawatan diri.

2. Objektif

- a. Bagian tubuh klien seperti kulit, rambut, gigi, kuku terlihat kotor.
- b. Klien terlihat makan dan minum secara tidak beraturan.
- c. Klien terlihat tidak rapi dalam berpakaian.
- d. Klien terlihat BAB dan BAK tidak pada tempatnya.

E. Kondisi Klinis Defisit Perawatan Diri

Klien dengan defisit perawatan diri berkaitan dengan beberapa kondisi klinis psikiatri seperti Skizofrenia, Depresi Mayor dan Ansietas.

1. Depresi
2. Skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya
3. Demensia
4. Retardasi Mental

F. Asuhan Keperawatan Defisit Perawatan Diri

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahapan pertama dalam proses keperawatan dan merupakan proses yang sangat penting. Perawat menggunakan pendekatan terapeutik untuk dapat mengumpulkan data dari klien. Langkah pertama dalam proses keperawatan pada klien dengan defisit perawatan diri adalah menilai kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL). Ini termasuk evaluasi menyeluruh terhadap status fisik, kognitif, dan emosional pasien. Perawat harus mengumpulkan informasi dari pasien, anggota keluarga, dan anggota tim perawatan kesehatan. Area khusus yang akan dinilai meliputi kemampuan fisik, fungsi kognitif, keadaan emosional, dan faktor lingkungan.

2. Diagnosa Keperawatan

Setelah seluruh data terkumpul pada fase pengkajian, data tersebut selanjutnya membuat kesimpulan diagnosis dalam bentuk diagnosis keperawatan. Menurut Sutejo (2022), diagnosis keperawatan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah yang dialami oleh klien, adanya respon klien terhadap penyakit, program pengobatan, dan tes diagnostik.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah (mengidentifikasi etiologi).
- c. Mengidentifikasi keadaan klien termasuk kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah yang dialaminya (mengidentifikasi tanda dan gejala).

Dalam merumuskan diagnosis keperawatan, terdapat beberapa komponen yaitu problem atau masalah (P), etiologi atau penyebab (E), dan Sign and Symptom atau tanda dan gejala (S).

3. Intervensi Keperawatan

Menurut Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, perawat bisa mengatasi masalah defisit perawatan diri dengan melakukan tindakan keperawatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Intervensi Keperawatan

Diagnosa Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Tindakan Keperawatan
	Dukungan Perawatan Diri	Observasi 1. Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia 2. Monitor tingkat kemandirian 3. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Terapeutik 1. Sediakan lingkungan yang terapeutik (misalnya suasana hangat, rileks, privasi) 2. Siapkan keperluan pribadi (misalnya parfum, sikat gigi, dan sabun mandi) 3. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri 4. Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan 5. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri 6. Jadwalkan rutinitas perawatan diri Edukasi Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan
	Dukungan Perawatan BAB/BAK	Observasi Diri: 1. Identifikasi kebiasaan BAK/BAB sesuai usia 2. Monitor integritas kulit pasien Terapeutik 1. Buka pakaian yang diperlukan untuk memudahkan eliminasi 2. Dukung penggunaan toilet/commode/pispot/urinal secara konsisten 3. Jaga privasi selama eliminasi 4. Ganti pakaian setelah eliminasi, jika perlu 5. Bersihkan alat bantu BAK/BAB setelah digunakan 6. Latih BAK/BAB sesuai jadwal jika perlu 7. Sediakan alat bantu (misalnya kateter urinal, jika perlu) Edukasi 1. Anjurkan BAB/BAK secara rutin 2. Anjurkan ke kamar mandi/toilet, jika perlu

Dukungan
Perawatan
Berpakaian

Observasi

- Diri:
1. Identifikasi usia dan budaya dalam membantu berpakaian/berhias
 2. Sediakan pakaian pada tempat yang mudah dijangkau
 3. Sediakan pakaian pribadi, sesuai kebutuhan
 4. Fasilitasi mengenakan pakaian, jika perlu
 5. Fasilitasi berhias (mis. menyisir rambut, merapikan kumis/jenggot)
 6. Jaga privasi selama berpakaian
 7. Tawarkan untuk laundry, jika perlu
 8. Berikan pujian terhadap kemampuan berpakaian secara mandiri.

Edukasi

1. Informasikan pakaian yang tersedia untuk dipilih, jika perlu
2. Ajarkan mengenakan pakaian, jika perlu

Dukungan
Perawatan
Makan/Minum

Observasi

- Diri:
1. Identifikasi diet yang dianjurkan
 2. Monitor kemampuan menelan
 3. Monitor status hidrasi pasien, jika perlu

Terapeutik

1. Ciptakan lingkungan yang menyenangkan selama makan
2. Atur posisi yang nyaman untuk makan/minum
3. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu
4. Letakkan makanan di sisi mata yang sehat
5. Sediakan sedotan untuk minum, sesuai kebutuhan
6. Siapkan makanan dengan suhu yang meningkatkan nafsu makan
7. Sediakan makanan dan minuman yang disukai
8. Berikan bantuan saat makan/minum sesuai tingkat kemandirian, jika perlu
9. Motivasi untuk makan di ruang makan, jika tersedia
10. Jelaskan posisi makanan pada pasien yang mengalami gangguan penglihatan menggunakan arah jarum mas

Edukasi

11. Kolaborasi pemberian obat, sesuai indikasi

Dukungan
Perawatan
Mandi

- Observasi
- Diri:
1. Identifikasi usia dan budaya dalam membantu kebersihan diri
 2. Identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan
 3. Monitor kebersihan tubuh (mis. Rambut, mulut, kulit, kuku)
 4. Monitor integritas kulit
- Terapeutik
1. Sediakan peralatan mandi (mis, sabun, sikat gigi, shampoo, pelembab kulit)
 2. Sediakan lingkungan yang aman dan nyaman
 3. Fasilitasi menggosok gigi, sesuai kebutuhan
 4. Fasilitasi mandi, sesuai kebutuhan
 5. Pertahankan kebiasaan kebersihan diri
 6. Berikan bantuan sesuai tingkat kemandirian
- Edukasi
1. Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan
 2. Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien, jika perlu

Sumber : *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, 2018*

4. Implementasi

Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya, dengan tujuan mencapai status kesehatan yang lebih baik sesuai dengan kriteria hasil yang diinginkan. Pada fase implementasi, perawat melaksanakan rencana perawatan yang telah disiapkan. Intervensi yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pasien secara individu.

- a. Memberikan bantuan untuk aktivitas sehari-hari: Ini dapat melibatkan bantuan untuk mandi, berdandan, atau makan, terutama untuk pasien dengan keterbatasan fisik.
- b. Memberikan edukasi dan sumber daya: Perawat harus mendidik pasien dan keluarga tentang teknik perawatan diri yang dapat meningkatkan kemandirian, seperti menggunakan perangkat adaptif (misalnya, sikat mandi bergagang panjang atau alat bantu untuk berpakaian).

- c. Terapi fisik dan rehabilitasi: Untuk pasien dengan masalah mobilitas, terapi fisik dapat meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.
- d. Meningkatkan keselamatan: Memastikan lingkungan pasien aman, dengan perangkat bantu dan area yang bebas dari kekacauan, dapat mencegah kecelakaan (Vellone et al., 2013).
- e. Perawat juga memainkan peran penting dalam memantau kemajuan pasien, membuat penyesuaian terhadap intervensi, dan memastikan bahwa pasien menerima dukungan yang memadai untuk perawatan diri yang berhasil.

5. Evaluasi

Langkah terakhir dalam proses keperawatan adalah evaluasi, di mana perawat menilai apakah intervensi berhasil mengatasi defisit perawatan diri. Evaluasi merupakan langkah proses keperawatan yang memungkinkan perawat untuk menentukan apakah intervensi keperawatan telah berhasil meningkatkan kondisi klien (Sutejo, 2022). Selama fase ini, perawat harus mempertimbangkan pencapaian Hasil: Penilaian Berkelanjutan: Menilai ulang kemajuan pasien secara terus-menerus dan menyesuaikan rencana perawatan sesuai kebutuhan sangatlah penting. Misalnya, jika pasien dengan defisit kognitif tidak membaik, pendekatan yang lebih intensif mungkin diperlukan. Umpan Balik Pasien dan Keluarga: Evaluasi harus mencakup masukan dari pasien dan keluarga mereka untuk menentukan kepuasan terhadap perawatan yang diberikan dan untuk menilai bagaimana perasaan pasien tentang kemampuan perawatan diri mereka. Penyesuaian rencana perawatan dan intervensi berdasarkan evaluasi membantu memastikan bahwa kebutuhan pasien terus terpenuhi seiring dengan perubahannya dari waktu ke waktu (Wilkinson et al., 2017).

G. Latihan

Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan defisit perawatan diri menurut Teori Orem?
 - A. Ketidakmampuan individu dalam menjaga kebersihan diri karena faktor lingkungan
 - B. Ketidakmampuan individu dalam melakukan aktivitas perawatan diri untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan
 - C. Ketidakmampuan individu untuk makan dengan baik
 - D. Ketidakmampuan individu untuk mengenali kebutuhan fisik mereka
 - E. Ketidakmampuan individu dalam mengelola stres dan emosi
2. Pada pasien dengan skizofrenia, defisit perawatan diri sering kali disebabkan oleh gangguan dalam aspek berikut, kecuali:
 - A. Gangguan kognitif

- B. Gangguan perilaku
 - C. Gangguan persepsi
 - D. Gangguan social
 - E. Gangguan fisik
3. Apa yang harus dilakukan perawat saat mengkaji kemampuan perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa?
 - A. Memberikan obat-obatan untuk memperbaiki defisit perawatan diri
 - B. Menganalisis masalah perawatan diri hanya berdasarkan wawancara dengan pasien
 - C. Mengkaji kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL) dan mengidentifikasi faktor penyebabnya
 - D. Mengabaikan tanda dan gejala yang ada pada pasien
 - E. Mengutamakan hanya aspek fisik dari perawatan diri
 4. Manakah dari intervensi berikut yang paling sesuai untuk membantu pasien dengan defisit perawatan diri akibat depresi?
 - A. Mendorong pasien untuk mandi dengan jadwal yang ketat
 - B. Memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan diri
 - C. Membantu pasien melakukan perawatan diri tanpa memberi mereka pilihan
 - D. Menyediakan alat bantu kebersihan diri dan berpakaian sesuai dengan kebutuhan pasien
 - E. Menjaga jarak dengan pasien untuk memberikan mereka waktu sendiri
 5. Dalam mengatasi defisit perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa, peran perawat adalah untuk:
 - A. Menyelesaikan semua aktivitas perawatan diri untuk pasien
 - B. Memberikan dukungan psikologis dan fisik, serta membantu pasien dalam meningkatkan kemampuan perawatan diri secara mandiri
 - C. Menerapkan pengobatan tanpa melibatkan pasien
 - D. Menghindari melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan diri mereka
 - E. Mengabaikan faktor sosial dan emosional yang mempengaruhi perawatan diri

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian defisit perawatan diri menurut Teori Orem, dan bagaimana teori ini diterapkan dalam perawatan klien dengan gangguan jiwa?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan defisit perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa? Berikan contoh konkret dari gangguan jiwa seperti depresi atau skizofrenia.

3. Deskripsikan tahapan pengkajian dalam proses keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Bagaimana peran perawat dalam menilai kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari?
4. Berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, sebutkan dan jelaskan beberapa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk pasien dengan defisit perawatan diri terkait dengan mandi dan berpakaian.
5. Evaluasi pentingnya langkah evaluasi dalam proses keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Apa yang harus dievaluasi oleh perawat untuk memastikan keberhasilan intervensi yang diberikan?

H. Kunci Jawaban

1. B
2. E
3. C
4. D
5. B

I. Rangkuman Materi

1. Defisit Perawatan Diri (DPD) adalah ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas perawatan diri seperti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian, makan, minum, dan eliminasi (PPNI, 2017).
2. Defisit perawatan diri terjadi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, membutuhkan intervensi keperawatan untuk mendukung pemulihan kemampuan perawatan diri.
3. Faktor fisik, psikologis, kognitif, dan lingkungan menjadi penyebab utama defisit perawatan diri.
4. Pengkajian: Menilai kemampuan klien dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL), meliputi status fisik, kognitif, emosional, dan faktor lingkungan.
5. Diagnosa Keperawatan: Mengidentifikasi masalah, faktor penyebab, dan kemampuan klien untuk mengatasi masalahnya.
6. Intervensi Keperawatan: Mencakup dukungan perawatan diri untuk aktivitas seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan eliminasi. Contoh intervensi: Membantu aktivitas, memberi dukungan untuk kemandirian, edukasi, serta menyediakan alat bantu yang dibutuhkan. Implementasi: Perawat melaksanakan rencana perawatan, memberikan bantuan sesuai kebutuhan pasien, edukasi, terapi fisik, dan memastikan keselamatan pasien.
7. Evaluasi: Menilai apakah intervensi berhasil, melakukan penyesuaian rencana perawatan, dan mendapatkan umpan balik dari pasien dan keluarga.

J. Glosarium

Ansietas: Ansietas adalah kondisi kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan, biasanya disertai dengan perasaan takut, gelisah, atau tegang.

Kognitif: Kognitif berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, ingatan, dan pemecahan masalah

Retardasi Mental: Retardasi mental, sekarang lebih sering disebut sebagai **disabilitas intelektual**, adalah kondisi yang ditandai dengan keterlambatan dalam perkembangan kemampuan kognitif dan adaptif individu

Skizofrenia: Skizofrenia adalah gangguan jiwa serius yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang

K. Daftar Pustaka

- Chen, C., Chen, Y., Huang, Q., Yan, S., & Zhu, J. (2022). Self-Care Ability of Patients With Severe Mental Disorders: Based on Community Patients Investigation in Beijing, China. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.847098>
- Hellqvist, C. (2021). Promoting self-care in nursing encounters with persons affected by long-term conditions—a proposed model to guide clinical care. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052223>
- Keliat, B. A., Hamid, A. Y. S., Putri, Y. S. E., Daulima, N. H. C., Wardani, I. Y., Susanti, H., Hardiana, G., & Panjaitan, R. U. (2019). *Asuhan Keperawatan Jiwa*. EGC.
- PPNI, T. P. S. D. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik Edisi 1. In *Dewan Pengurus Pusat PPNI*. <https://doi.org/10.1080/15022250.2015.1015765>
- Susanti, H. (2010). DEFISIT PERAWATAN DIRI PADA KLIEN SKIZOFRENIA. *Defisit Perawatan Diri*.
- Sutejo. (2022). *Keperawatan kesehatan jiwa : Prinsip dan praktik asuhan keperawatan jiwa*. Pustaka Baru Press.
- Videbeck Sheila L. (2011). Psychiatric Mental Health Nursing fifth edition. In *International Affairs*.
- Wilkinson, J. M., & Ahern, N. R. (2013). *Buku saku diagnosis keperawatan Diagnosis Nanda, Intervensi Nic Kriteria Hasil Noc edisi 9 revisi*. EGC.
- World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. (2014). Self care for health. WHO Regional Office for South-East Asia. <https://iris.who.int/handle/10665/205887>

BAB 4

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA KLIEN DAN KELUARGA AKIBAT COVID 19 DAN PENYAKIT KRONIS HIV AIDS

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 dan penyakit kronis seperti HIV/AIDS telah membawa dampak yang signifikan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga terhadap kesehatan jiwa individu dan keluarganya. Ketidakpastian, stigma sosial, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, serta beban emosional yang berkepanjangan meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, stres, dan isolasi sosial. Perawat jiwa memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik, komprehensif, dan empatik terhadap klien serta keluarganya yang terdampak oleh kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan asuhan keperawatan jiwa yang tepat, adaptif, dan berbasis bukti dalam menangani klien dengan COVID-19 maupun HIV/AIDS.

Buku ajar ini disusun untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa kepada klien dan keluarganya yang terdampak oleh COVID-19 dan HIV/AIDS, serta untuk mengembangkan kemampuan analisis, komunikasi terapeutik, dan pemecahan masalah keperawatan secara profesional.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar asuhan keperawatan jiwa pada klien dan keluarga yang mengalami dampak psikologis akibat COVID-19 dan HIV/AIDS.
- Mengidentifikasi masalah keperawatan jiwa yang umum muncul pada klien dan keluarga dengan COVID-19 dan HIV/AIDS.
- Merancang intervensi keperawatan jiwa yang sesuai berdasarkan pendekatan terapeutik dan budaya.
- Menerapkan komunikasi terapeutik dalam membina hubungan saling percaya dengan klien dan keluarganya.

- Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan jiwa secara komprehensif dan berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan pembelajaran dari buku ini, mahasiswa mampu:

- Memahami teori dan prinsip asuhan keperawatan jiwa pada klien dan keluarga dengan kondisi COVID-19 dan HIV/AIDS.
- Mampu melakukan pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan jiwa secara profesional dan empatik.
- Menunjukkan sikap empati, non-diskriminatif, dan menghargai martabat klien dan keluarga dalam setiap tindakan keperawatan jiwa

Uraian Materi

A. Asuhan Keperawatan Jiwa Klien dan Keluarga Akibat Covid 19

1. Definisi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) muncul akibat virus korona baru, yang sekarang dikenal sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 tidak sama dengan virus korona lain yang biasanya menyebar pada manusia dan menyebabkan flu biasa. COVID-19 adalah penyakit infeksi pernapasan akut yang terutama ditularkan melalui saluran pernapasan (CCDC, 2020). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan kemudian menyebar secara global, sehingga dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada Maret 2020.

SARS-CoV-2 (COVID-19) adalah virus RNA untai tunggal. nama "Corona" adalah kata latin yang berarti "Mahkota" yang diberikan karena kemiripan duri-durinya dengan mahkota. Virus korona memiliki riwayat menyebabkan berbagai sindrom pada manusia dan hewan, termasuk *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV). Penularan SARS-CoV terjadi melalui kontak manusia ke manusia melalui penularan droplet.

2. Tanda & Gejala

COVID-19 memengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan mengalami penyakit ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perlu dirawat di rumah sakit.

Gejala yang paling umum:

1. demam
2. batuk
3. kelelahan
4. hilangnya indera perasa atau penciuman

Gejala yang kurang umum:

1. sakit tenggorokan
2. sakit kepala
3. nyeri otot dan sendi
4. diare
5. ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki
6. mata merah atau teriritasi

Gejala yang serius:

1. kesulitan bernapas atau sesak napas
2. kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, atau kebingungan
3. nyeri dada

Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala yang serius. Selalu hubungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi dokter atau fasilitas kesehatan. Orang dengan gejala ringan yang kondisi kesehatannya baik secara umum sebaiknya mengelola gejalanya di rumah. Rata-rata dibutuhkan waktu 5–6 hari sejak seseorang terinfeksi virus hingga gejala muncul, namun bisa juga memakan waktu hingga 14 hari.

3. Asuhan Keperawatan

Pengkajian

1. Identitas Klien

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Status Pernikahan

Alamat

Tanggal Pengkajian

2. Identitas Keluarga

Nama

Hubungan dengan
Klien

Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

3. Keluhan Utama

- a. Keluhan Utama pada Klien
 - 1) Kecemasan (Anxiety)

Klien sering merasa takut tertular COVID-19, takut menghadapi ketidakpastian, dan mengalami kecemasan sosial akibat isolasi (WHO, 2020a).

2) Depresi

Terjadi akibat kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, atau isolasi sosial berkepanjangan (Brooks, S. K. et al, 2020).

3) Gangguan tidur (Insomnia)

Stres dan kecemasan dapat menyebabkan gangguan tidur yang signifikan (Huang, Y. & Zhao, N., 2020)

4) Gangguan stres pasca trauma (PTSD)

Beberapa klien, khususnya yang pernah terinfeksi COVID-19 berat atau kehilangan anggota keluarga, menunjukkan gejala trauma psikologis (Liu, N. et al., 2020)

b. Keluhan Utama pada Keluarga

1) Stres dan beban psikologis sebagai caregiver

Anggota keluarga yang merawat pasien COVID-19 sering mengalami tekanan mental dan emosional (Rajkumar, R.P., 2020)

2) Rasa bersalah dan kecemasan sosial

Keluarga merasa bersalah jika dianggap menularkan virus atau mendapat stigma dari lingkungan sosial (WHO, 2020b)

3) Kehilangan ekonomi dan tekanan finansial

Dampak pandemi terhadap pekerjaan atau pendapatan keluarga menyebabkan kecemasan dan konflik internal (United Nations, 2020).

4) Kesedihan mendalam (grief)

Keluarga yang kehilangan anggota karena COVID-19 sering mengalami proses duka yang kompleks (Eisma, M.C. & Boelen, P.A., 2020)

4. Riwayat Psikososial

a. Riwayat Gangguan Jiwa Sebelumnya

Aspek yang dikaji (Taquet, M. et al., 2021)

1) Adakah diagnosa gangguan jiwa sebelumnya (depresi, gangguan kecemasan, bipolar, skizofrenia)?

2) Penggunaan obat-obatan psikotropika atau terapi psikologis sebelumnya?

3) Riwayat rawat inap di fasilitas kejiwaan?

4) Riwayat bunuh diri atau percobaan bunuh diri? (Vindegaard, N., & Benros, M. E., 2020)

b. Riwayat Penyakit Fisik Lain

Aspek yang dikaji (Mazza, M. G. et al., 2020).

- 1) Komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, penyakit paru kronik, kanker.
- 2) Pengaruh penyakit tersebut terhadap kondisi psikologis dan imunologis.
- 3) Dampak kelelahan fisik terhadap daya tahan mental.
- c. Pengalaman Selama Isolasi/Pengobatan

Aspek yang dikaji (Brooks, S. K. et al. (2020))

 - 1) Durasi dan kondisi isolasi (di rumah/RS/ICU).
 - 2) Dukungan sosial selama isolasi.
 - 3) Rasa takut, kesepian, marah, atau tidak berdaya. (Liu, D. et al. (2020)).
 - 4) Paparan stigma atau diskriminasi.
- d. Perubahan Kehidupan Sehari-hari

Aspek yang dikaji (Xiong, J. et al. (2020), Galea, S. et al. (2020)).

 - 1) Kehilangan pekerjaan atau pendapatan.
 - 2) Gangguan dalam pola hidup (makan, tidur, ibadah, rekreasi).
 - 3) Masalah dalam hubungan keluarga (konflik, kekerasan domestik).
 - 4) Kesulitan menjalankan peran sosial atau pendidikan.

5. Status Mental

- a. Penampilan Umum
 - 1) Klien: Tampak letih, tidak terawat, penurunan berat badan, ekspresi wajah cemas atau sedih. (WHO, 2020a)
 - 2) Keluarga: Terlihat lelah secara fisik dan emosional, kadang kurang menjaga penampilan karena stres berkepanjangan (CDC, 2021)
- b. Mood dan Afek
 - 1) Klien: Mood depresif, cemas, afek tumpul atau tidak sesuai konteks. (Vindegard & Benros (2020))
 - 2) Keluarga: Mood labil, mudah marah, tegang, cemas berlebihan terhadap kesehatan anggota keluarga (Pfefferbaum & North, 2020)
- c. Proses Pikir
 - 1) Klien: Alur pikir lambat, cenderung pesimis atau obsesif, sulit berkonsentrasi.
 - 2) Keluarga: Pikiran kacau saat membuat keputusan, bisa ada pikiran obsesif terhadap pencegahan infeksi. (Brooks et al., 2020)
- d. Isi Pikir
 - 1) Klien: Pikiran negatif tentang masa depan, ide bunuh diri pada kasus depresi berat, pikiran tidak logis.
 - 2) Keluarga: Pikiran berlebihan tentang keamanan, kadang menyalahkan diri sendiri atau pihak lain. (WHO, 2020b)
- e. Persepsi

- 1) Klien: Halusinasi bisa muncul pada klien dengan gangguan berat, terutama akibat isolasi atau delirium.
 - 2) Keluarga: Distorsi persepsi akibat hoaks/misinformasi media sosial. (Rogers et al., 2020).
- f. Fungsi Kognitif
- 1) Klien: Penurunan memori jangka pendek, gangguan konsentrasi ("brain fog"), terutama pada pasien post-COVID.
 - 2) Keluarga: Kelelahan mental menyebabkan penurunan daya fokus dan kemampuan membuat keputusan. (Hampshire et al. (2021)
- g. Wawasan dan Penilaian
- 1) Klien: Bisa kurang menyadari kebutuhan akan bantuan, penilaian realita menurun.
 - 2) Keluarga: Wawasan bisa baik namun keputusan terganggu oleh tekanan emosional. (APA, 2020)
- h. Kontrol Impuls
- 1) Klien: Emosi mudah meledak, bisa terjadi perilaku agresif atau menyakiti diri sendiri.
 - 2) Keluarga: Marah tiba-tiba, menyalahkan pihak lain (misalnya tenaga medis), kesulitan mengelola stres. (Liu et al., 2020).

6. Psikodinamik

a. Stressor Utama

- 1) Kehilangan (Kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan).
- 2) Isolasi Sosial (Pembatasan sosial menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan)
- 3) Ketidakpastian (Ketidakpastian mengenai masa depan, ketakutan terhadap infeksi ulang)
- 4) Stigma Sosial (Diskriminasi terhadap pasien yang pernah positif COVID-19)
- 5) Overload Informasi (Informasi berlebihan dari media sosial menyebabkan kebingungan dan kecemasan). (Ho, C. S., Chee, C. Y., & Ho, R. C., 2020)

b. Mekanisme Koping (APA, 2020)

Tabel 4.1. Mekanisme Koping

Tipe Koping	Contoh pada Klien/Keluarga
Koping Adaptif (Mature)	1. Mencari informasi akurat dan valid 2. Mengakses layanan konseling 3. Dukungan sosial aktif dari keluarga dan komunitas
Koping Maladaptif (Immature/Neurotik)	1. Menyangkal keberadaan virus 2. Melampiaskan emosi pada orang lain 3. Menarik diri dari lingkungan sosial secara berlebihan
Mekanisme Pertahanan Ego (Freud)	1. Denial (Penolakan): "COVID-19 itu tidak nyata, hanya konspirasi." 2. Projection (Proyeksi): Menyalahkan pemerintah atau tetangga sebagai penyebab penderitanya. 3. Rationalization: "Saya sakit karena kerja terlalu keras, bukan karena virus." 4. Displacement: Melampiaskan kemarahan pada anak/pasangan.

7. Dukungan Sosial

Keluarga

Teman/lingkungan

Tenaga kesehatan

Kelompok dukungan

Diagnosa Keperawatan (DPP PPNI, 2020)

- Ansietas *b.d* kurang terpapar informasi *d.d* merasa bingung, sulit berkonsentrasi, tampak gelisah, tampak tegang
- Berduka *b.d* kematian keluarga *d.d* merasa sedih, tidak menerima kehilangan, merasa tidak ada harapan, menangis, tidak mampu berkonsentrasi
- Harga diri rendah situasional *b.d* riwayat penolakan *d.d* menilai diri tidak berguna, merasa malu, melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri, berbicara pelan dan lirih, menolak berinteraksi dengan orang lain, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk.
- Isolasi sosial *b.d* perubahan status mental *d.d* merasa ingin sendirian, merasa tidak aman ditempat umum, menarik diri, menolak berinteraksi dengan orang lain

Tabel 4.2. Intervensi Keperawatan

Diagnosa Keperawatan (SDKI)	Tujuan & Kriteria Hasil (SLKI)	Intervensi Keperawatan (SIKI)
Ansietas	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil: 1. Verbalisasi kebingungan menurun 2. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun 3. Perilaku gelisah menurun 4. Perilaku tegang menurun 5. Konsentrasi membaik 6. Pola tidur membaik	1. Reduksi Ansietas (I.09314) Observasi • Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis: kondisi, waktu, stresor) • Identifikasi kemampuan mengambil keputusan • Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal) Terapeutik • Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan • Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan • Pahami situasi yang membuat ansietas • Dengarkan dengan penuh perhatian • Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan • Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan • Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan • Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang Edukasi • Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami • Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis • Anjurkan keluarga untuk tetap Bersama pasien, jika perlu • Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan • Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi

- Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
- Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
- Latih Teknik relaksasi

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

2. Terapi Relaksasi (I.09326)

Observasi

- Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif
- Identifikasi Teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan
- Identifikasi kesiapan, kemampuan, dan penggunaan Teknik sebelumnya
- Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah Latihan
- Monitor respons terhadap terapi relaksasi

Terapeutik

- Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan
- Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi
- Gunakan pakaian longgar
- Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama
- Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau Tindakan medis lain, jika sesuai

Edukasi

- Jelaskan tujuan, manfaat, Batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (mis: musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif)

		• Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih • Anjurkan mengambil posisi nyaman • Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi • Anjurkan sering mengulangi atau melatih Teknik yang dipilih • Demonstrasikan dan latih Teknik relaksasi (mis: napas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing)
Berduka	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka tingkat berduka menurun, dengan kriteria hasil: 1. Verbalisasi menerima kehilangan meningkat 2. Verbalisasi harapan meningkat 3. Verbalisasi perasaan sedih menurun 4. Menangis menurun 5. Konsentasi membaik	Dukungan Proses Berduka (I.09274) Observasi • Identifikasi kehilangan yang dihadapi • Identifikasi proses berduka yang dialami • Identifikasi sifat keterikatan pada benda yang hilang atau orang yang meninggal • Identifikasi reaksi awal terhadap kehilangan Terapeutik • Tunjukkan sikap menerima dan empati • Motivasi agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan • Motivasi untuk menguatkan dukungan keluarga atau orang terdekat • Fasilitasi melakukan kebiasaan sesuai dengan budaya, agama, dan norma sosial • Fasilitasi mengekspresikan perasaan dengan cara yang nyaman (mis: membaca buku, menulis, menggambar, atau bermain) • Diskusikan strategi koping yang dapat digunakan Edukasi • Jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar

menawar, depresi, dan menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan

- Anjurkan mengidentifikasi ketakutan terbesar pada kehilangan
- Anjurkan mengekspresikan perasaan tentang kehilangan
- Ajarkan melewati proses berduka secara bertahap

Dukungan Emosional (I.09256)

Observasi

- Identifikasi fungsi marah, frustrasi, dan amuk bagi pasien
- Identifikasi hal yang telah memicu emosi

Terapeutik

- Fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih
- Buat pernyataan suportif atau empati selama fase berduka
- Lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan (mis: merangkul, menepuk-nepuk)
- Tetap Bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas, jika perlu
- Kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah

Edukasi

- Jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu
- Anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami (mis: ansietas, marah, sedih)
- Anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan pola respons yang biasa digunakan
- Ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat

Kolaborasi

- Rujuk untuk konseling, jika perlu

Isolasi Sosial

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka keterlibatan sosial meningkat, dengan kriteria hasil:

1. Minat interaksi meningkat
2. Verbalisasi isolasi menurun
3. Verbalisasi ketidakamanan ditempat umum menurun
4. Perilaku menarik diri menurun

Promosi Sosialisasi (I.13498)

Observasi

- Identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain
- Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain

Terapeutik

- Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan
- Motivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan
- Motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok
- Motivasi berinteraksi di luar lingkungan (mis: jalan-jalan, ke toko buku)
- Diskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain
- Diskusikan perencanaan kegiatan di masa depan
- Berikan umpan balik positif dalam perawatan diri
- Berikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan

Edukasi

- Anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap
- Anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan
- Anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain
- Anjurkan meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain
- Anjurkan penggunaan alat bantu (mis: kacamata dan alat bantu dengar)
- Anjurkan membuat perencanaan kelompok kecil untuk kegiatan khusus
- Latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi

- Latih mengekspresikan marah dengan tepat

B. Asuhan Keperawatan Jiwa Klien dan Keluarga Akibat penyakit kronis HIV AIDS

1. Definisi HIV-AIDS

Human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) terjadi pada tahap infeksi yang paling lanjut. HIV menyerang sel darah putih tubuh, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini membuat orang lebih mudah jatuh sakit karena penyakit seperti tuberkulosis, infeksi, dan beberapa jenis kanker. HIV menyebar dari cairan tubuh orang yang terinfeksi, termasuk darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. HIV tidak menyebar melalui ciuman, pelukan, atau berbagi makanan. HIV juga dapat menyebar dari ibu ke bayinya.

HIV dapat dicegah dan diobati dengan terapi antiretroviral (ART). HIV yang tidak diobati dapat berkembang menjadi AIDS, seringkali setelah bertahun-tahun.

WHO kini mendefinisikan Penyakit HIV Lanjut (AHD) sebagai jumlah sel CD4 kurang dari 200 sel/mm³ atau stadium 3 atau 4 pada orang dewasa dan remaja. Semua anak di bawah usia 5 tahun yang hidup dengan HIV dianggap memiliki penyakit HIV lanjut. (WHO, 2021)

2. Tanda & Gejala

Gejala HIV bervariasi tergantung pada stadium infeksi. HIV menyebar lebih mudah dalam beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi, tetapi banyak yang tidak menyadari status mereka hingga stadium lanjut. Dalam beberapa minggu pertama setelah terinfeksi, orang mungkin tidak mengalami gejala. Yang lain mungkin mengalami penyakit seperti influenza termasuk (WHO, 2021):

- a. Demam
- b. sakit kepala
- c. ruam kulit
- d. sakit tenggorokan.

Infeksi ini secara progresif melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan tanda dan gejala lain:

- a. pembengkakan kelenjar getah bening
- b. penurunan berat badan
- c. demam
- d. diare
- e. batuk.

Tanpa pengobatan, orang yang hidup dengan infeksi HIV juga dapat mengembangkan penyakit parah:

- a. tuberkulosis (TB)
- b. meningitis kriptokokus
- c. infeksi bakteri parah
- d. kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi.

HIV menyebabkan infeksi lain menjadi lebih parah, seperti hepatitis C, hepatitis B, dan mpox.

3. Penularan

HIV dapat ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh dari orang yang hidup dengan HIV, termasuk darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. HIV juga dapat ditularkan ke anak selama kehamilan dan persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi HIV melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi barang pribadi, makanan, atau air.

Orang yang hidup dengan penderita HIV dan menjalani terapi antiretroviral (ART) serta memiliki viral load yang tidak terdeteksi tidak akan menularkan HIV kepada pasangan seksual mereka. Oleh karena itu, akses awal terhadap ART dan dukungan untuk tetap menjalani pengobatan sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan orang yang hidup dengan HIV, tetapi juga untuk mencegah penularan HIV.

4. Faktor Risiko

Perilaku dan kondisi yang membuat seseorang lebih berisiko tertular HIV meliputi:

- a. Melakukan hubungan seks anal atau vaginal tanpa kondom
- b. Memiliki infeksi menular seksual (ims) lain seperti sifilis, herpes, klamidia, gonore, dan vaginosis bacterial
- c. Penggunaan alkohol atau obat-obatan secara berbahaya dalam konteks perilaku seksual
- d. Berbagi jarum suntik, alat suntik, atau larutan obat yang terkontaminasi saat menyuntikkan narkoba
- e. Menerima suntikan, transfusi darah, atau transplantasi jaringan yang tidak aman
- f. Prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau penusukan tanpa alat steril; atau cedera akibat tertusuk jarum secara tidak sengaja, termasuk di kalangan tenaga kesehatan.

5. Pencegahan

HIV adalah penyakit yang dapat dicegah. Risiko infeksi HIV dapat dikurangi dengan:

- a. menggunakan kondom pria atau wanita saat berhubungan seks
- b. melakukan tes HIV dan infeksi menular seksual (IMS)
- c. menjalani sunat medis sukarela pada pria
- d. menggunakan layanan pengurangan dampak buruk bagi pengguna dan penyuntik narkoba.

Dokter mungkin menyarankan obat-obatan dan alat medis untuk membantu mencegah infeksi HIV, termasuk:

- a. obat antiretroviral (ARV), termasuk Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) oral dan produk jangka Panjang
- b. dapivirine vaginal rings
- c. injectable long acting cabotegravir.

ARV juga dapat digunakan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Orang yang menjalani terapi antiretroviral (ART) dan tidak memiliki virus yang terdeteksi dalam darah tidak akan menularkan HIV kepada pasangan seksualnya. Akses terhadap tes dan ART merupakan bagian penting dalam pencegahan HIV.

6. Asuhan Keperawatan

Pengkajian

a. Aspek Biologis

Pengkajian dimulai dengan menilai kondisi fisik dan status kesehatan klien, termasuk stadium HIV/AIDS, riwayat pengobatan antiretroviral (ARV), efek samping obat, serta status nutrisi dan infeksi oportunistik (Potter & Perry, 2017).

Riwayat medis dan pemeriksaan fisik penting dilakukan untuk mengetahui gangguan fisik yang bisa memengaruhi kondisi psikologis, seperti nyeri kronis, kelelahan, atau neuropati (Nursalam, 2020).

b. Aspek Psikologis

Evaluasi kondisi emosi klien, termasuk adanya kecemasan, depresi, rasa bersalah, dan stres akibat stigma sosial sangat penting karena HIV/AIDS sering kali berdampak pada kesehatan mental (Kaplan & Sadock, 2015).

Perlu dikaji juga mekanisme koping klien dalam menghadapi diagnosis HIV/AIDS, apakah adaptif (misalnya mencari dukungan sosial) atau maladaptif (misalnya isolasi diri atau penyalahgunaan zat) (Videbeck, 2021).

c. Aspek Sosial

Aspek ini mencakup hubungan interpersonal klien, termasuk dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas (Notoatmodjo, 2012).

Penting juga untuk mengetahui apakah klien mengalami diskriminasi atau penolakan sosial, karena hal ini berdampak langsung terhadap motivasi berobat dan kesejahteraan psikososial (WHO, 2021).

Peran keluarga sebagai sistem pendukung perlu dikaji, termasuk pemahaman mereka terhadap penyakit dan kesiapan mereka untuk merawat klien (Nursalam, 2020).

d. Aspek Spiritual

Penyakit kronis seperti HIV/AIDS sering menimbulkan krisis spiritual, sehingga penting mengkaji nilai-nilai, kepercayaan, dan harapan klien terhadap kehidupan dan kematian (Potter & Perry, 2017).

Kaji apakah klien mendapatkan dukungan spiritual dari agama atau komunitas keagamaan, serta apakah klien merasakan konflik spiritual seperti marah kepada Tuhan atau merasa kehilangan makna hidup (Dossey & Keegan, 2013).

e. Aspek Perilaku

Amati perubahan perilaku klien, termasuk penarikan diri, agresivitas, atau perubahan dalam pola tidur dan makan, yang bisa menjadi indikator gangguan jiwa seperti depresi atau gangguan penyesuaian (Videbeck, 2021).

Perilaku klien terhadap pengobatan juga perlu dikaji, apakah patuh terhadap terapi ARV atau ada hambatan seperti takut efek samping, stigma, atau akses terbatas ke layanan kesehatan (UNAIDS, 2020).

Diagnosa Keperawatan (DPP PPNI, 2020)

- a. Ansietas *b.d* kurang terpapar informasi *d.d* merasa bingung, sulit berkonsentrasi, tampak gelisah, tampak tegang
- b. Keputusasaan *b.d* penurunan kondisi fisiologis *d.d* mengungkapkan keputusasaan, berperilaku pasif.
- c. Isolasi sosial *b.d* perubahan status mental *d.d* merasa ingin sendirian, merasa tidak aman ditempat umum, menarik diri, menolak berinteraksi dengan orang lain
- d. Risiko Bunuh Diri *d.d* gangguan fisik (penyakit kronis)

Intervensi Keperawatan

Tabel 4.3. Intervensi Keperawatan

Diagnosa Keperawatan	Tujuan & Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
Ansietas	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil: 1. Verbalisasi kebingungan menurun	Reduksi Ansietas (I.09314) Observasi - Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis: kondisi, waktu, stresor) - Identifikasi kemampuan mengambil keputusan

2. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun
3. Perilaku gelisah menurun
4. Perilaku tegang menurun
5. Konsentrasi membaik
6. Pola tidur membaik

- Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal)

Terapeutik

- Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
- Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
- Pahami situasi yang membuat ansietas
- Dengarkan dengan penuh perhatian
- Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan
- Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
- Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang

Edukasi

- Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
- Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
- Anjurkan keluarga untuk tetap Bersama pasien, jika perlu
- Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan
- Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
- Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
- Latih Teknik relaksasi

		Kolaborasi • Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu
Keputusan	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka harapan meningkat, dengan kriteria hasil: 1. Keterlibatan dalam aktivitas perawatan meningkat 2. Verbalisasi keputusan menurun 3. Perilaku pasif menurun	Dukungan Emosional (I.09256) Observasi • Identifikasi fungsi marah, frustrasi, dan amuk bagi pasien • Identifikasi hal yang telah memicu emosi Terapeutik • Fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih • Buat pernyataan suportif atau empati selama fase berduka • Lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan (mis: merangkul, menepuk-nepuk) • Tetap Bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas, jika perlu • Kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah Edukasi • Jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu • Anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami (mis: ansietas, marah, sedih) • Anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan pola respons yang biasa digunakan • Ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat Kolaborasi • Rujuk untuk konseling, jika perlu Promosi Harapan (I.09307) Observasi

- Identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup

Terapeutik

- Sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting
- Pandu mengingat Kembali kenangan yang menyenangkan
- Libatkan pasien secara aktif dalam perawatan
- Kembangkan rencana perawatan yang melibatkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan kompleks
- Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok
- Ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual

Edukasi

- Anjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dengan realistis
- Anjurkan mempertahankan hubungan (mis: menyebutkan nama orang yang dicintai)
- Anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik dengan orang lain
- Latih menyusun tujuan yang sesuai dengan harapan
- Latih cara mengembangkan spiritual diri
- Latih cara mengenang dan menikmati masa lalu (mis: prestasi, pengalaman)

Promosi Koping (I.09312)

Observasi

- Identifikasi kegiatan jangka pendek dan Panjang sesuai tujuan

- Identifikasi kemampuan yang dimiliki
- Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan
- Identifikasi pemahaman proses penyakit
- Identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan
- Identifikasi metode penyelesaian masalah
- Identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial

Terapeutik

- Diskusikan perubahan peran yang dialami
- Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- Diskusikan alasan mengkritik diri sendiri
- Diskusikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengevaluasi perilaku sendiri
- Diskusikan konsekuensi tidak menggunakan rasa bersalah dan rasa malu
- Diskusikan risiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri
- Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
- Berikan pilihan realistis mengenai aspek-aspek tertentu dalam perawatan
- Motivasi untuk menentukan harapan yang realistis
- Tinjau Kembali kemampuan dalam pengambilan keputusan
- Hindari mengambil keputusan saat pasien berada dibawah tekanan
- Motivasi terlibat dalam kegiatan sosial

- Motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia
- Damping saat berduka (mis: penyakit kronis, kecacatan)
- Perkenalkan dengan orang atau kelompok yang berhasil mengalami pengalaman sama
- Dukung penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat
- Kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam

Edukasi

- Anjurkan menjalin hubungan yang memiliki kepentingan dan tujuan sama
- Anjurkan penggunaan sumber spiritual, jika perlu
- Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- Anjurkan keluarga terlibat
- Anjurkan membuat tujuan yang lebih spesifik
- Ajarkan cara memecahkan masalah secara konstruktif
- Latih penggunaan Teknik relaksasi
- Latih keterampilan sosial, sesuai kebutuhan
- Latih mengembangkan penilaian obyektif

Risiko Bunuh Diri Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka kontrol diri meningkat, dengan kriteria hasil:

1. Verbalisasi keinginan bunuh diri menurun
2. Verbalisasi isyarat bunuh diri menurun
3. Verbalisasi ancaman bunuh diri menurun
4. Verbalisasi rencana bunuh diri menurun

Manajemen Mood (I.09289)

Observasi

- Identifikasi mood (mis: tanda, gejala, Riwayat penyakit)
- Identifikasi risiko keselamatan diri atau orang lain
- Monitor fungsi kognitif (mis: konsentrasi, memori, kemampuan membuat keputusan)

- Monitor aktivitas dan tingkat stimulasi lingkungan

Terapeutik

- Fasilitasi pengisian kuesioner self-report (mis: beck depression inventory, skala status fungsional), jika perlu
- Berikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dengan cara yang tepat (mis: sandak, terapi seni, aktivitas fisik)

Edukasi

- Jelaskan tentang gangguan mood dan penanganannya
- Anjurkan berperan aktif dalam pengobatan dan rehabilitasi, jika perlu
- Anjurkan rawat inap sesuai indikasi (mis: risiko keselamatan, deficit perawatan diri, sosial)
- Ajarkan mengenali pemicu gangguan mood (mis: situasi stres, masalah fisik)
- Ajarkan memonitor mood secara mandiri (mis: skala tingkat 1 – 10, membuat jurnal)
- Ajarkan keterampilan coping dan penyelesaian masalah baru

Kolaborasi

- Kolaborasi pemberian obat, jika perlu
- Rujuk untuk psikoterapi (mis: perilaku, hubungan interpersonal, keluarga, kelompok), jika perlu

C. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, setelah dikaji pasien telah kehilangan 2 anggota keluarga yang dicintainya akibat covid-19. Pasien tampak sedih, pandangan menunduk, tidak ada kontak mata, dan sering menangis. Pasien juga mengatakan tidak punya semangat hidup lagi dan merasa tidak berguna.
Prioritas masalah keperawatan pada kasus tersebut adalah?
A. Harga diri rendah
B. Keputusanasaan
C. Ketidakberdayaan
D. Berduka
E. Risiko Bunuh Diri
2. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, setelah dikaji pasien telah kehilangan 2 anggota keluarga yang dicintainya akibat covid-19. Pasien tampak sedih, pandangan menunduk, tidak ada kontak mata, dan sering menangis. Pasien juga mengatakan tidak punya semangat hidup lagi dan merasa tidak berguna.
Tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut adalah?
A. Dukungan emosional
B. Promosi harapan
C. Dukungan proses berduka
D. Dukungan koping keluarga
E. Pencegahan bunuh diri
3. Seorang Perempuan bernama Ny. S terdiagnosa HIV-AIDS 6 bulan yang lalu karena terpapar dari suaminya yg sudah meninggal akibat HIV-AIDS. Ny. S mengatakan menyerah pada penyakitnya karena tidak akan bisa diobati sampai kapanpun. Perilaku Ny. S tampak pasif, tidak mau makan, dan kurang terlibat dalam aktivitas perawatan dirinya. Prioritas masalah keperawatan pada Ny. S adalah?
A. Risiko bunuh diri
B. Harga diri rendah
C. Berduka
D. Ketidakberdayaan
E. Keputusanasaan

4. Seorang wanita berusia 29 tahun, pasien HIV/AIDS, dirawat di rumah sakit karena infeksi oportunistik. Ia terlihat sedih, menarik diri, dan enggan berbicara dengan keluarga atau tenaga kesehatan. Ketika perawat mengajaknya berbicara, ia berkata, "Untuk apa aku hidup, semua orang menjauhiku."
- Apa tindakan keperawatan jiwa paling tepat dalam situasi ini?
- A. Mendengarkan secara aktif dan memberikan validasi terhadap perasaannya
 - B. Memberikan informasi bahwa HIV bisa dikontrol dengan ART (Antiretroviral Therapy)
 - C. Mengajak pasien untuk mengikuti kegiatan kelompok dukungan pasien HIV
 - D. Menjelaskan pentingnya dukungan keluarga dalam proses penyembuhan
 - E. Mengarahkan pasien untuk berpikir positif dan bersyukur
5. Seorang ibu berusia 50 tahun mengalami kecemasan berat setelah mengetahui anaknya, seorang mahasiswa, terinfeksi HIV dan juga pernah positif COVID-19. Ia merasa bersalah, takut menghadapi stigma, dan menyalahkan pola asuhnya sendiri. Ia mulai mengalami nyeri dada dan sulit tidur.
- Apa intervensi keperawatan jiwa yang paling tepat untuk kondisi ibu tersebut?
- A. Memberikan edukasi tentang HIV dan COVID-19 kepada ibu
 - B. Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam dan manajemen stress
 - C. Mengajak ibu untuk mengikuti kelompok dukungan orang tua ODHA
 - D. Merujuk ibu ke psikiater untuk pengobatan farmakologis
 - E. Menyarankan ibu untuk menerima kenyataan dan tetap bersikap positif

D. Kunci Jawaban

1. B: Keputusanasaan

Pembahasan: karena pasien menunjukkan perasaan putus harapan, tidak ada semangat hidup, dan merasa tidak berguna, dimana hal tersebut merupakan ciri utama dari keputusanasaan, yang menjadi dasar intervensi lebih lanjut untuk mencegah risiko yang lebih berat seperti bunuh diri.

2. E: Pencegahan bunuh diri

Pembahasan: prioritas utama untuk mencegah risiko yang mengancam nyawa. Setelah keselamatan terjamin, intervensi seperti dukungan emosional, promosi harapan, dan fasilitasi proses berduka dapat menyusul.

3. E: Keputusanasaan

Pembahasan: Karena ini mencerminkan kondisi psikologis terdalam pasien: hilangnya harapan, menyerah, dan tidak percaya akan pemulihan, yang membutuhkan intervensi segera untuk mencegah penurunan lebih lanjut atau bahkan risiko bunuh diri.

4. A: Mendengarkan secara aktif dan memberikan validasi terhadap perasaannya

Pembahasan: Perawat jiwa perlu menggunakan komunikasi terapeutik dan mendengarkan aktif untuk membangun kepercayaan dan memahami kondisi emosional klien, terutama saat menunjukkan gejala depresi atau hopelessness.

5. B: Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam dan manajemen stress

Pembahasan: Gejala fisik akibat kecemasan berat dapat dibantu dengan teknik relaksasi dan manajemen stres sebagai intervensi awal. Edukasi dan dukungan lanjutan bisa dilakukan setelah kecemasan teratasi.

E. Rangkuman Materi

Asuhan Keperawatan Jiwa Klien dan Keluarga Akibat COVID-19 COVID-19 merupakan infeksi pernapasan akut akibat virus SARS-CoV-2 yang menyebar secara global. Gejala umumnya meliputi demam, batuk, kelelahan, serta kehilangan indera penciuman dan perasa, dengan gejala serius seperti sesak napas dan nyeri dada memerlukan penanganan medis segera. Kondisi pandemi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan mental klien dan keluarga, mencakup kecemasan, depresi, insomnia, PTSD pada klien, serta stres, rasa bersalah, tekanan finansial, dan duka mendalam pada keluarga.

Asuhan keperawatan jiwa mencakup pengkajian lengkap identitas klien dan keluarga, keluhan utama, riwayat psikososial, status mental, psikodinamik, dan mekanisme koping yang digunakan. Diagnosa keperawatan utama meliputi ansietas, berduka, harga diri rendah situasional, dan isolasi sosial. Intervensi keperawatan yang disarankan adalah reduksi ansietas, terapi relaksasi, dukungan proses berduka, dukungan emosional, serta promosi sosialisasi dengan melibatkan edukasi, observasi, tindakan terapeutik, dan kolaborasi tim kesehatan.

Asuhan Keperawatan Jiwa Klien dan Keluarga Akibat Penyakit Kronis HIV/AIDS HIV adalah virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh dan bisa berkembang menjadi AIDS. Penularannya terjadi melalui cairan tubuh, dengan risiko tinggi pada perilaku seksual tanpa proteksi dan penggunaan jarum suntik tidak steril. Pencegahan HIV mencakup penggunaan kondom, tes HIV secara rutin, terapi antiretroviral (ART), dan strategi pengurangan dampak buruk.

Klien HIV/AIDS mengalami tantangan psikososial seperti kecemasan, depresi, isolasi sosial, dan risiko bunuh diri. Pengkajian keperawatan dilakukan melalui aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan perilaku untuk memahami dampak penyakit terhadap klien. Diagnosa utama yang muncul meliputi ansietas, keputusasaan, isolasi sosial, dan risiko bunuh diri. Intervensi keperawatan mencakup reduksi ansietas, promosi harapan, dukungan emosional, promosi koping, serta manajemen

mood yang melibatkan edukasi pasien dan keluarga, intervensi terapeutik, observasi ketat, dan kolaborasi multidisiplin.

F. Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. (2020). Mental health disorders related to COVID-19 pandemic.
- APA. (2020). Coping with stress during infectious disease outbreaks. <https://www.apa.org/helpcenter/pandemics>
- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395(10227), 912–920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Coping with stress during infectious disease outbreaks. <https://www.cdc.gov>
- Dossey, B. M., & Keegan, L. (2013). *Holistic nursing*. Jones & Bartlett.
- DPP PPNI. (2020). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) (edisi 1)*. DPP PPNI.
- DPP PPNI. (2020). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) (edisi 1)*. DPP PPNI.
- DPP PPNI. (2020). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) (edisi 1)*. DPP PPNI.
- Eisma, M. C., & Boelen, P. A. (2020). COVID-19, bereavement and grief: A pandemic legacy. *Clinical Psychology: Science and Practice*. <https://doi.org/10.1111/cpsp.12376>
- Galea, S., Merchant, R. M., & Lurie, N. (2020). The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: The need for prevention and early intervention. *JAMA Internal Medicine*, 180(6), 817–818. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.1562>
- Hampshire, A., Trender, W., Chamberlain, S. R., et al. (2021). Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. *EClinicalMedicine*, 39, 101044. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101044>
- Ho, C. S., Chee, C. Y., & Ho, R. C. (2020). Mental health strategies to combat the psychological impact of COVID-19. *Brain, Behavior, and Immunity*, 87, 72–73. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.018>
- Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: A web-based cross-sectional survey. *Psychiatry Research*, 288, 112954. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112954>

- Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015). *Synopsis of psychiatry* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Liu, D., Baumeister, R. F., Veilleux, J. C., et al. (2020). Depression and anxiety during COVID-19 pandemic in survivors. *Journal of Affective Disorders*, 282, 11–17. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.159>
- Liu, N., Zhang, F., Wei, C., et al. (2020). Prevalence and predictors of PTSS during COVID-19 outbreak in China hardest-hit areas: Gender differences matter. *Psychiatry Research*, 287, 112921. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112921>
- Liu, Y., Chen, H., Zhang, N., et al. (2020). Depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers and family members during COVID-19. *Brain, Behavior, and Immunity*, 88, 916–921. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.010>
- Mazza, M. G., De Lorenzo, R., Conte, C., et al. (2020). COVID-19 and risk of psychiatric sequelae: A systematic review. *Brain, Behavior, and Immunity - Health*, 5, 100150. <https://doi.org/10.1016/j.bbih.2020.100150>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). *Asuhan keperawatan jiwa*. Salemba Medika.
- Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the COVID-19 pandemic. *The New England Journal of Medicine*, 383(6), 510–512. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). *Fundamentals of nursing* (9th ed.). Elsevier.
- Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. *Asian Journal of Psychiatry*, 52, 102066. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102066>
- Rogers, J. P., Chesney, E., Oliver, D., et al. (2020). Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 7(7), 611–627. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30203-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30203-0)
- Taquet, M., Luciano, S., Geddes, J. R., & Harrison, P. J. (2021). Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: Retrospective cohort studies of 62,354 COVID-19 cases in the USA. *The Lancet Psychiatry*, 8(2), 130–140. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30462-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30462-4)
- Taylor, S. (2019). *The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease*. Cambridge Scholars Publishing.
- UNAIDS. (2020). *Global AIDS update*. <https://www.unaids.org>
- United Nations. (2020). *Policy brief: COVID-19 and the need for action on mental health*. <https://www.un.org>

- Vaillant, G. E. (1992). Ego mechanisms of defense: A guide for clinicians and researchers. American Psychiatric Publishing.
- Videbeck, S. L. (2021). Psychiatric-mental health nursing (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Vindegaard, N., & Benros, M. E. (2020). COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of current evidence. *Brain, Behavior, and Immunity*, 89, 531–542. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.048>
- WHO. (2020a). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1>
- WHO. (2020b). Social stigma associated with COVID-19 – A guide to preventing and addressing social stigma. <https://www.who.int/publications/i/item/social-stigma-associated-with-covid-19>
- WHO. (2021). HIV/AIDS fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
- Xiong, J., Lipsitz, O., Nasri, F., et al. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 277, 55–64. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.001>

BAB 5

KONSEP RECOVERY: KARAKTERISTIK RECOVERY, MODEL DAN SUPPORTIVE ENVIRONMENT

Pendahuluan:

Perawat mempunyai peranan yang penting dalam proses *recovery* pasien. Tahap *recovery* merupakan periode risiko bunuh diri yang relatif tinggi pada pasien skizofrenia. Perawat mempunyai tugas untuk membantu pasien mencapai *recovery*. Bab ini akan membahas konsep *recovery*, karakteristik *recovery*, model dan *supportive environment*. Tujuan penulisan bab ini adalah agar peserta didik memahami konsep *recovery*, karakteristik *recovery*, model dan *supportive environment*. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi sarjana keperawatan.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah konsep *recovery*, karakteristik *recovery*, model dan *supportive environment*. Konsep *recovery* menjelaskan tentang definisi *recovery*, tingkatan *recovery*, Karakteristik *recovery* pada pasien skizofrenia meliputi fisik, psikologis, social, ekonomi, religius, pengobatan, dan komunikasi. Bab ini juga menjelaskan tentang teori *Tidal Recovery*.

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan konsep *recovery* pada pasien gangguan jiwa.
- Menjelaskan karakteristik *recovery* pada pasien gangguan jiwa.
- Menjelaskan model dan *supportive environment* pada pasien gangguan jiwa dalam mencapai *recovery*.

Capaian Pembelajaran:

CPL Prodi yang dibebankan pada MK

CPL 10:

Mampu menerapkan asuhan keperawatan secara lengkap dan berkesinambungan sesuai standar asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggungjawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien.

CPMK 3:

Mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan psikiatri secara lengkap dan berkesinambungan sesuai standar asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggungjawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien.

Sub CPMK-3:

Mampu membuat *evidence based practice* pada kasus gangguan jiwa.

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar meliputi konsep *recovery*, karakteristik *recovery*, model dan *supportive environment*.

A. Konsep *Recovery*

Perjalanan setiap orang menuju *recovery* adalah unik. *Recovery* (pemulihan) merupakan aspek rehabilitasi, merujuk pada penggabungan atas keterbatasan sebagai bagian dari realitas, perubahan mimpi dan aspirasi, penggalan ide-ide baru dan sampai pada penyesuaian terhadap penyakitnya. Hal ini diasumsikan bahwa klien akan berubah dengan memperhatikan penempatan tujuan tempat dan cara hidup, bekerja, sosialisasi, dan rekreasi. Rehabilitasi adalah proses, bukan perbaikan yang cepat. *Recovery* adalah suatu *outcome* dari proses pemulihan (Fontaine, 2009). Tenaga kesehatan mempunyai perbedaan persepsi tentang *recovery* pada pasien gangguan jiwa. Ini akan mempengaruhi proses perawatan pada pasien dalam mencapai *recovery* (Mamnua et.al., 2019).

Menurut Warner (2004), ada tiga pembagian *recovery* yaitu: *complete recovery*, *social recovery* dan *hospitalization*. *Complete recovery* adalah hilangnya gejala psikotik dan pasien kembali berfungsi seperti sebelum sakit. *Social recovery* adalah pasien mandiri secara ekonomi, tempat tinggal dan minimnya gangguan sosial. Pasien bisa bekerja secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan tidak tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya. *Hospitalization* adalah waktu yang dialami pasien di rumah sakit jiwa. Menurut Ng *et al.* (2008) sebagian besar pasien beranggapan bahwa *full recovery* adalah apabila pasien tidak mengonsumsi obat lagi, mempunyai pekerjaan tetap, dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan sahabat. Keluarga mempunyai peran penting untuk mencegah kekambuhan pasien gangguan jiwa agar bisa mencapai *recovery* (Mamnua, 2021). Penelitian *recovery* yang ada masih terbatas dan sebagian besar penelitian intervensi (Mamnua, et.al., 2016).

B. Karakteristik *Recovery*

Karakteristik *recovery* pada pasien skizofrenia meliputi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, religius, pengobatan, dan komunikasi (Mamnua, et.al. 2025). Liberman *et al.* (2002) merumuskan kriteria *recovery*, yaitu selama dua tahun berturut-turut memiliki kriteria sebagai berikut: tidak ada gejala positif dan negatif yang signifikan secara klinis, bisa bekerja dan berfungsi secara sosial, hubungan dengan keluarga dan rekan harmonis, mengikuti pertemuan atau berinteraksi dengan orang lain minimal seminggu sekali, hidup mandiri, merasa puas dalam kehidupannya, harga diri dan identitas diri stabil, ikut serta dalam pemilu dan bisa membela dirinya.

Liberman and Kopelowicz (2005) menggambarkan karakteristik *recovery* pada pasien skizofrenia seperti pada Tabel 1.

Tabel 4.1 Karakteristik *recovery* pasien skizofrenia

Variabel	Studi			
	Harding <i>et al.</i> , 1987 (20)	Liberman <i>et al.</i> , 2002 (24)	Torgalsboen <i>et al.</i> , 2002 (38)	Whitehorn <i>et al.</i> , 2002 (37)
Psikopa tologi	Bebas gejala dan tidak minum obat psikotropika	Skor <i>Brief Psychiatric Rating Scale</i> (BPRS) < 4	Tidak dirawat di RSJ selama 5 tahun	Skor PANSS < 4
Fungsi psikoso-sial	Hidup sosial dengan tetangga, punya pekerjaan atau relawan	Bekerja atau sekolah paruh waktu; mandiri mengelola keuangan dan obat; seminggu sekali sosialisasi dengan kelompoknya	Skor <i>Global Assessment of Functioning</i> (GAF) > 65	Skor GAF > 50
Durasi	Tidak ditulis	Dua tahun	Lima tahun	Dua tahun

C. Model dan *Supportive Environment*

Tenaga kesehatan mempunyai peran dalam membantu pasien skizofrenia mencapai *recovery*. Tenaga kesehatan tersebut berada di layanan primer, sekunder, dan tersier. Layanan primer berada di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 1 (PPK 1) terdiri atas praktik bidan, perawat, dokter, dokter gigi, klinik bersalin, klinik, puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes, dan polindes). Layanan sekunder berada di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2) terdiri dari rumah sakit umum baik milik pemerintah maupun swasta. Layanan tersier berada di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 3 (PPK 3) terdiri dari rumah sakit rujukan tertinggi, rumah sakit jiwa, rumah sakit provinsi, rumah sakit wilayah, yang selanjutnya difokuskan pada rumah sakit jiwa (Kusumawardani, dkk., 2015). Salah satu tenaga kesehatan yang berada di setiap layanan, baik primer, sekunder, maupun tersier adalah perawat.

Menurut Stuart (2013), ada tiga ranah praktik keperawatan jiwa kontemporer adalah: memberikan asuhan langsung, komunikasi dan manajemen. Ranah ini tumpang tindih dengan fungsi perawat yaitu: pengajaran, koordinasi, delegasi dan kolaborasi. Peran perawat untuk membantu proses *recovery* pasien skizofrenia di

komunitas adalah: manajemen penyakit dan pemulihan (psikoedukasi, pembentukan perilaku untuk pengobatan, pelatihan pencegahan kambuh, dan pelatihan keterampilan hidup) dan mengakses dukungan komunitas (program rehabilitasi, layanan berpusat pada konsumen, layanan perumahan, dukungan pekerjaan dan pelayanan pendidikan). Menurut Newell and Gournay (2009), peran perawat juga harus memperhatikan budaya yang berlaku seperti: struktur keluarga, komunikasi antar budaya, nilai, sikap, kepercayaan, perilaku, sikap terhadap pengkajian, diagnosis, terapi dan perkembangan kesehatan jiwa pasien.

Salah satu teori yang menjelaskan tentang *recovery* pada pasien dengan gangguan jiwa adalah Model Tidal. Tidal *recovery* menurut Barker and Barker (2005) bahwa *recovery* berdasarkan model Tidal didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

1. Fokus terapi utama perawatan kesehatan jiwa adalah komunitas alamiah. Tujuan perawatan kesehatan jiwa adalah mengembalikan pasien tersebut ke kehidupan alamiahnya, sehingga bisa melanjutkan perjalanan hidupnya.
2. Perubahan adalah proses yang berlangsung secara konstan. Tidal Model bertujuan untuk membantu pasien mengembangkan kesadaran dirinya dan berarti dalam kehidupan mereka.
3. Pemberdayaan adalah jantungnya proses *recovery*. Tenaga profesional akan membantu perubahan besar dalam kehidupan pasien dan semua itu berkaitan dengan yang dialami pasien.
4. Hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien berjalan bersama. Mereka seperti penari yang menari bersama. Implementasinya tidak hanya dalam hubungan tenaga profesional-pasien, akan tetapi juga memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk mempertahankan integritas pasien.

Tidal Model muncul berdasarkan serangkaian studi mengenai kebutuhan keperawatan jiwa. *Tidal Model* memperluas dan mengembangkan beberapa asumsi tradisional mengenai hubungan interpersonal dalam praktik keperawatan, khususnya menekankan pentingnya makna yang dirasakan dalam pengalaman hidupnya dan peran pengembangan rencana perawatan yang berpusat pada individu. Model ini juga mengintegrasikan proses yang berbeda untuk kembali memberdayakan orang yang mengalami gangguan jiwa dan menyediakan tempat untuk mengeksplorasi dimensi spiritual pengalaman hidup seseorang (Barker, 2001).

Barker and Barker (2005) memberikan pendapatnya mengenai pelayanan kesehatan jiwa tradisional yang dibedakan antara perawatan yang di rumah mereka sendiri atau di klinik dan perawatan yang diberikan di rumah sakit. Pemikiran pemisahan level tempat perawatan berasal dari sejarah psikiatri, ketika model perawatan institusi mendominasi pada zaman *asylum* dan secara perlahan digantikan dengan model perawatan komunitas. Meskipun banyak perawatan

kesehatan jiwa difokuskan pada pelayanan berbasis komunitas, akan tetapi ketika seseorang dipertimbangkan mengalami distress serius atau membutuhkan perawatan intensif dan perhatian, mereka biasanya diterima oleh berbagai rumah sakit atau rumah perawatan.

Barker and Barker (2005) juga menjelaskan hubungan antara perawatan di rumah sakit dan di komunitas. Secara khusus, orang menerima dua jenis perawatan komunitas, yaitu perawatan primer dari dokter keluarga mereka atau konselor dan perawatan tersier yang mengikuti penatalaksanaan dari rumah sakit, bisa sebagai pasien yang dirawat di rumah atau didukung oleh pelayanan berbasis komunitas lainnya.

Barker and Barker (2005) yang mencetuskan model Tidal ini mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk membantu pasien kembali ke rumah. Pelayanan kesehatan jiwa bisa dilakukan di rumah atau di klinik dan di rumah sakit. *The Tidal Model care continuum* menjelaskan ada tiga tahapan yang dilakukan pasien, yaitu: *intermediate care, transitional care and developmental care*. Perawatan dilakukan dimulai sejak pasien dirawat di rumah sakit sampai membantu pasien kembali ke rumah.

1. Immediate care

Menurut Barker and Barker (2005), tujuan perawatan segera (*immediate care*) adalah membantu pasien menemukan atau menyusun solusi terhadap masalah-masalah mereka dengan segera. *Tidal model* ini mengidentifikasi kebutuhan yang bisa dilakukan untuk membantu pasien kembali ke rumah dan mengantarkan pasien bisa hidup di tempat tinggalnya sesuai dengan yang bisa dikerjakan. Perawatan segera difokuskan pada pemecahan masalah yang dihadapi pasien dalam jangka pendek dengan menggunakan sumber personal dan interpersonal dan diidentifikasi melalui pengkajian secara holistik. Perlu menjamin keamanan fisik dan emosional dan mengurangi risiko kekerasan pada pasien dan orang lain.

2. Transitional care

Menurut Barker and Barker (2005), indikasi perawatan transisional adalah menyiapkan pasien pulang dari rumah sakit atau memasukkan pasien ke bentuk perawatan yang lain. Tujuan perawatan transisional adalah untuk menjamin pasien mengalami transisi dengan mudah dari satu tempat ke tempat lainnya. Penting juga untuk menjamin bahwa semua informasi penting tentang perawatan dasar yang ditawarkan dan berbagai jenis perawatan yang diharapkan bisa dilewati dari satu tempat perawatan ke tempat perawatan lainnya. Pengelolaan perawatan transisional penting untuk menjamin bahwa hubungan yang tepat antara semua anggota tim kesehatan inter disiplin relevan dan pasien sebisa mungkin dilibatkan dalam membuat rencana perpindahan perawatan. Meskipun

semua tim kesehatan penting di tiga level perawatan, ketika pasien melalui perjalanan dari satu tempat perawatan ke tempat perawatan lainnya, pasien membutuhkan interaksi dan komunikasi semua pihak termasuk dirinya dan anggota keluarga.

3. *Development care*

Menurut Barker and Barker (2005), pasien membutuhkan perawatan pengembangan untuk membantu pasien menerima kelanjutan perawatan di rumah setelah dirawat di rumah sakit dan membutuhkan dukungan dalam jangka waktu lama, baik di rumah maupun di klinik, sebagai program berkelanjutan rehabilitasi. Fokus *development care* adalah membutuhkan dukungan atau intervensi terapeutik yang lebih lama dan intensif. *Development care* membantu pasien mengembangkan cara-cara menghadapi masalah-masalah potensial kehidupan yang bisa muncul dalam jangka waktu menengah dan panjang. *Development care* juga menawarkan mempertahankan dukungan secara berkala melalui identifikasi profesional atau tim yang ada di kelompok dukungan yang berbasis komunitas.

D. Penutup

Recovery pasien gangguan jiwa bersifat unik artinya setiap pasien melalui proses perjalanan *recovery* yang berbeda. Tingkatan *recovery* ada tiga yaitu *complete recovery*, *social recovery* dan *hospitalization*. *The Tidal Model care continuum* menjelaskan ada tiga tahapan yang dilakukan pasien, yaitu: *intermediate care*, *transitional care* and *developmental care*.

E. Latihan

Pilihan ganda.

Silahkan pilih sesuai dengan jawaban yang benar.

1. Manakah pernyataan yang benar tentang *recovery*?
 - A. Proses *recovery* setiap pasien adalah unik
 - B. Tidak ada pasien yang mencapai *recovery*
 - C. *Recovery* tidak dibutuhkan oleh pasien
 - D. Keluarga tidak berperan dalam proses *recovery* pasien
 - E. *Recovery* harus tetap minum obat
2. Manakah yang bukan merupakan karakteristik *recovery*?
 - A. Indikator fisik
 - B. Indikator psikologis
 - C. Indikator pendidikan
 - D. Indikator religius

- E. Indikator komunikasi
3. Apakah salah satu nama teori tentang recovery?
- A. *Intermediate Care*,
 - B. *Tidal Model*
 - C. *Transitional Care*
 - D. *Developmental Care*.
 - E. *Recovery Model*
4. Apakah nama perawatan yang dipersiapkan menyiapkan pasien pulang dari rumah sakit atau memasukkan pasien ke bentuk perawatan yang lain?
- A. *Intermediate Care*,
 - B. *Tidal Model*
 - C. *Recovery Model*
 - D. *Transitional Care*
 - E. *Developmental Care*.
5. Manakah yang merupakan ranah praktik keperawatan jiwa kontemporer?
- A. memberikan asuhan secara tidak langsung
 - B. mengembangkan terapi komplementer
 - C. tidak perlu mempelajari komunikasi
 - D. tidak perlu mengikuti perkembangan zaman
 - E. mengembangkan manajemen keperawatan

Soal Essay

1. Jelaskan tentang recovery pada pasien gangguan jiwa!
2. Jelaskan karakteristik recovery pasien gangguan jiwa!
3. Apakah peran tenaga kesehatan terhadap recovery pasien?
4. Jelaskan tingkat recovery pasien gangguan jiwa!
5. Jelaskan recovery berdasarkan analisis jurnal internasional bereputasi (5 jurnal terbaru dalam 5 tahun terakhir)!

F. Kunci Jawaban

1. A
2. C
3. B
4. D
5. E

G. Rangkuman Materi

Recovery pada pasien gangguan jiwa adalah unik, artinya proses recovery pasien yang satu dengan lainnya akan berbeda dalam perjalanan mencapai recovery. Karakteristik recovery meliputi fisik, psikologis, social, ekonomi, religius, pengobatan, dan komunikasi. Recovery mempunyai 3 jenis yaitu *complete recovery*, *social recovery* dan *hospitalization*. Teori Tidal tentang recovery menjelaskan ada 3 tahapan yaitu *intermediate care*, *transitional care* and *developmental care*.. Peran tenaga kesehatan dalam membantu proses *recovery* pasien adalah melakukan praktek keperawatan jiwa kontemporer.

H. Glosarium

complete recovery: pemulihan secara keseluruhan

social recovery: pemulihan secara social melalui interaksi dengan orang lain

hospitalization: proses masuknya kembali pasien dirawat di rumah sakit

I. Daftar Pustaka

- Barker, P. 2001. The tidal model: the lived-experience in person-centred mental health nursing care. *Nursing Philosophy*, 2, 213–223 2.
- Barker, P. & Barker, P. B. 2005. *The Tidal Model A guide for mental health professionals*. New York: Brunner-Routledge.
- Fontaine, K. L. (2009). *Mental Health Nursing*. Pearson Prentice Hall.
- Kusumawardhani, AAAA., Dharmono, S., Amir, N., Diatri H., & Malik, K., 2015. *From curing to caring: achieving patient's recovery. Rekomendasi tata laksana layanan skizofrenia*. Centra communication.
- Liberman, R. P. & Kopelowicz., A. 2005. Recovery from schizophrenia: A concept in search of research. *Psychiatric Services*, 56, 735-742.
- Liberman, R. P., Kopelowicz, A., Ventura, J. & Gutkind, D. 2002. Operational criteria and factors related to recovery from schizophrenia. *International Review of Psychiatry*, 14, 256-272.
- Mamnuah. (2021). The Role of the Family in Preventing Relapse of Schizophrenia Patient. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 44–49. <https://doi.org/10.1097/ADT.0000000000000277>
- Mamnuah., Nurjannah, I., Prabandari, Y. S., Raymondalexa, C. M., Literature review of mental health recovery in Indonesia. *GSTF Journal of Nursing and Health Care (JNHC)* Vol.3 No.2, June 2016.
- Mamnuah, A., Nurjannah, I., Suryo Prabandari, Y., & Marchira, C. R. (2019). Health Professional's Perceptions Toward Recovery of Patients with Schizophrenia in Community. *The Open Public Health Journal*, 12(1), 26–32.

<https://doi.org/10.2174/1874944501912010026>

- Mamnua, Isnaeni, Y., Ernawati, D., (2025) Instrumen Recovery Pasien Skizofrenia di Komunitas. Nuansa Fajar Cemerlang: Jakarta.
- Newell, R. & Gournay, K. 2009. *Mental health nursing an evidence-based approach*, Philadelphia, Churchill Livingstone Elsevier.
- Ng, R. M. K., Pearson, V., Lam, M., Law, C. W., Chiu, C. P. Y. & Chen, E. Y. H. 2008. What Does Recovery From Schizophrenia Mean? Perceptions of Long-Term Patients. *International Journal of Social Psychiatry*, 54, 118-130.
- Stuart, G. W. 2013. *Principles and practice of psychiatric nursing* Canada, Mosby Elsevier.
- Warner, R. 2004. *Recovery from schizophrenia psychiatry and political economy*, USA, Brunner-Routledge.

BAB 6

TERAPI MODALITAS PASIEN GANGGUAN JIWA

Pendahuluan

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang terus meningkat secara global. Menurut laporan World Health Organization (WHO), sekitar 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan mental. Menurut data WHO, prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia mencapai 9,8% pada tahun 2021, dengan angka depresi mencapai 6,6%, dengan prevalensi skizofrenia mencapai tujuh kasus per seribu rumah tangga. Kondisi ini menegaskan bahwa gangguan mental bukan sekedar masalah pribadi melainkan memiliki konsekuensi yang luas bagi keluarga dan masyarakat.

Pasien dengan masalah kesehatan mental sering menghadapi situasi yang tidak menyenangkan terutama dalam mengelola perasaan, berkomunikasi dengan orang lain serta beradaptasi dalam aktifitas sehari-hari seperti makan, tidur. Kondisi pasien yang kesulitan beradaptasi memicu kecenderungan pasien mengalami kekambuhan, yang dikarenakan mereka merasa terasing di masyarakat karena merasa perilaku yang berbeda dan mereka terstigma secara terstruktur. Selain itu faktor putus obat menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan terutama saat pasien berada di rumah sakit maupun pengawasan pengobatan saat di rumah dan berada di lingkungan sosial pasien. Dengan demikian selain tentang obat, pasien perlu diajarkan bagaimana dia mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain obat yang diminum pasien dipastikan telah di minum pasien, perawat juga perlu melakukan terapi non farmakologi, yang berupa terapi modalitas maupun terapi komplementer. Terapi ini sebagai langkah holistik dalam upaya mendukung pasien gangguan jiwa dalam mencapai keadaan mental yang lebih sehat dan mampu bertahan menghadapi stressor yang memicu kambuhnya penyakit.

Terapi modalitas adalah suatu pendekatan dalam keperawatan jiwa yang ditujukan untuk membantu pasien dengan gangguan jiwa untuk mengasah kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Beberapa pasien gangguan jiwa menghadapi tantangan dalam pengelolaan emosi, berinteraksi dengan orang lain serta menjalankan kegiatan sehari-hari. Ketidakmampuan ini

dapat menghambat proses pemulihan serta kemungkinan kambuh kembali akibat kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian terapi modalitas dapat membantu pasien untuk berlatih beradaptasi, perilaku yang terpandu serta mendorong pasien untuk mengasah ketrampilan pasien beradaptasi terutama dalam berinteraksi sosial dengan orang lain dan kehidupan pribadinya.

Terapi Modalitas terapi dalam keperawatan jiwa mencakup berbagai metode, seperti sesi individual, terapi lingkungan, terapi kognitif, dukungan keluarga, dan terapi kegiatan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperkuat kemampuan beradaptasi, meningkatkan keterampilan sosial, serta mereduksi gejala gangguan mental. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penggabungan modalitas terapi dengan pengobatan dapat mendongkrak efektivitas pemulihan pasien lebih baik dibandingkan sekadar bergantung pada obat-obatan. Dengan adanya modalitas terapi, pasien menerima tidak hanya pengobatan, tetapi juga pelatihan, dukungan emosional, dan pendidikan yang membantu mereka untuk berfungsi dengan lebih baik dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas untuk memahami serta mendukung penerapan modalitas terapi demi meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami gangguan jiwa.

Tujuan Intruksional:

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep terapi modalitas dalam perawatan jiwa
- Menjelaskan jenis terapi modalitas
- Memahami berbagai terapi modalitas pasien gangguan jiwa
- Mengidentifikasi kebutuhan terapi modalitas pasien gangguan jiwa
- Menetapkan kesesuaian kondisi pasien dengan terapi modalitas

Capaian Pembelajaran:

- **Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai:**

- (CP.ST.10) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- (CP.ST.12) Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik perawat Indonesia

- **Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum:**

- (CP.KU.01) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
- (CP.KU.02) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

- **Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus:**
 - (CP.PK.01): Mampu mengaplikasikan prinsip caring, etik, legal dan peka budaya dalam asuhan keperawatan
 - (CP.PK.02) Mampu memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan secara professional dengan menekankan keselamatan klien dan mutu pelayanan
 - (CP.PK.03): Mampu mengimplementasikan komunikasi terapeutik dan berperan secara aktif dalam kolaborasi interprofessional dengan tim kesehatan, klien, keluarga dan masyarakat
 - (CP.PK.13) Mampu menguasai konsep dan prinsip yang berhubungan dengan pemberian asuhan keperawatan

Uraian Materi

A. Permasalahan yang terjadi dalam Penerapan Terapi Modalitas

Pasien yang mengalami masalah mental seringkali berhadapan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mencoba menyesuaikan diri dengan sekitar. Kesulitan ini dapat muncul akibat sejumlah hal, seperti gangguan dalam proses berpikir, ketidakstabilan emosi, kurangnya kemampuan sosial, serta pandangan negatif dari masyarakat. Berikut ini beberapa isu utama yang dialami pasien yang mengalami gangguan jiwa yang memerlukan terapi modalitas dalam berbagai bentuk seperti:

1. Gangguan dalam Interaksi Sosial

Pada umumnya pasien gangguan jiwa mengalami kesulitan di dalam membangun komunikasi yang sehat. Gangguan dalam berinteraksi dengan orang lain membuat mereka kesulitan dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini terjadi pada pasien skizofrenia misalnya, mereka umumnya mengalami delusi (waham) atau halusinasi. Kedua keadaan ini menyebabkan pasien akan menarik diri dari lingkungannya. Gangguan dalam proses berpikir menyebabkan mereka terstigma dan terisolasi, akibat kurangnya kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial yang baik dan sehat. Penyebab gangguan interaksi sosial lainnya adalah harga diri rendah, merasa dirinya tidak sakit serta pikiran dan perasaannya dihantui perasaan curiga dan manipulatif. Keadaan pasien yang menyendiri ini seringkali menyebabkan gangguan kecemasan sosial dan ketakutan berlebihan saat.

2. Ketidakmampuan Mengelola Emosi dan Perilaku

Beberapa pasien gangguan jiwa mengalami emosi yang tidak stabil, seperti mudah marah, cemas berlebihan, atau merasa putus asa. Emosi dan perilaku yang tidak terkendali sebagai dampak pasien tidak bisa tidur dan rawat diri yang jelek. Ketidakmampuan mengontrol emosi ini dapat menyebabkan konflik dengan orang lain atau bahkan perilaku agresif yang membuat mereka semakin terisolasi.

3. Kesulitan dalam Aktivitas Sehari-hari

Pasien gangguan jiwa sering mengalami kesulitan dalam merawat diri sendiri, seperti menjaga kebersihan, mengatur pola makan, atau melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Akibatnya, mereka bergantung pada orang lain dan sulit untuk hidup mandiri di masyarakat.

4. Stigma dan Diskriminasi dari Masyarakat

Terdapat stigma negatif terhadap gangguan jiwa di masyarakat. Pasien sering ditolak oleh masyarakat, menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan,

atau bahkan dikucilkan oleh keluarga dan lingkungan mereka. Hal ini memperburuk keadaan mereka dan mempersulit pemulihan.

5. Risiko Kekambuhan dan Isolasi Sosial

Pasien gangguan jiwa sangat rentan terhadap kekambuhan jika mereka tidak menerima dukungan yang tepat. Mereka dapat merasa tidak diterima oleh lingkungan yang tidak mendukung dan tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, yang menyebabkan mereka memilih untuk mengisolasi diri dan akhirnya mengalami penurunan kondisi mental.

B. Bentuk dan Peran Terapi Modalitas dalam Membantu Adaptasi Pasien

Karena kesulitan pasien dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, mereka membutuhkan bantuan untuk mengatasi efek negatif dari kondisi ini. Akibatnya, solusi untuk membantu pasien gangguan jiwa mengatasi masalah ini memerlukan terapi modalitas. Manfaat terapi modalitas untuk meningkatkan kemampuan adaptasi pasien meliputi:

1. Terapi Lingkungan

Terapi modalitas ini guna menyediakan kondisi yang mendukung adaptasi dengan lingkungan yang ada. Lingkungan yang kondusif sangat berpengaruh dalam proses adaptasi pasien. Dalam terapi lingkungan, tenaga kesehatan menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar pasien dapat belajar berinteraksi dengan orang lain, membangun kebiasaan positif, serta mengurangi stres yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Terapi modalitas ini membantu menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar pasien dapat berlatih keterampilan sosial dan emosional. Lingkungan yang kondusif sangat berpengaruh dalam proses adaptasi pasien. Dalam terapi lingkungan, tenaga kesehatan menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar pasien dapat belajar berinteraksi dengan orang lain, membangun kebiasaan positif, serta mengurangi stres yang dapat memperburuk kondisi pasien.

2. Terapi Kognitif dan Perilaku

Terapi ini mengembangkan pola berpikir yang lebih sehat dalam menghadapi stressor. Hal ini perlu dilakukan karena umumnya pasien gangguan jiwa sering memiliki distorsi kognitif atau pola pikir negatif yang menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi. Terapi kognitif membantu mereka mengenali dan mengubah pola pikir yang maladaptif menjadi lebih realistis dan positif. Dengan demikian, mereka dapat merespons lingkungan secara lebih sehat dan efektif.

Terapi ini ditujukan untuk membantu pasien mengubah pola pikir negatif dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sosial. Pasien gangguan jiwa sering memiliki distorsi kognitif atau pola pikir negatif yang menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi. Terapi kognitif membantu mereka mengenali dan mengubah pola pikir yang maladaptif menjadi lebih realistis dan positif. Dengan demikian, mereka dapat merespons lingkungan secara lebih sehat dan efektif. Strategi memodifikasi keyakinan dan sikap yg mempengaruhi perasaan dan perilaku klien

- a. Proses: membantu mempertimbangkan stresor dan mengidentifikasi pola berpikir dan keyakinan yg tdk akurat
- b. Fokus asuhan: reevaluasi ide, nilai, harapan, dan memulai menyusuri perubahan kognitif

Pelaksanaan terapi kognitif pada pasien dengan gangguan kognitif dengan melakukan :

- a. Mengajar substitusi pikiran
- b. Penyelesaian masalah
- c. Memodifikasi percakapan diri negatif

3. Terapi Kelompok dan Keluarga

Penerapan terapi ini digunakan untuk meningkatkan dukungan sosial pasien dalam aktifitas sosialnya. Dukungan sosial memiliki peran penting dalam proses adaptasi pasien gangguan jiwa. Terapi kelompok membantu pasien belajar berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan yang terkontrol, sementara terapi keluarga mengedukasi keluarga agar dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pasien.

Agar pasien tidak merasa sendirian, terapi modalitas ini akan mengajarkan keterampilan sosial dan dukungan psikososial. Aktivitas sehari-hari, seperti menjaga kebersihan diri, mengelola keuangan, atau bekerja, menjadi masalah bagi banyak pasien gangguan jiwa. Terapi okupasi membantu pasien belajar keterampilan hidup yang penting agar mereka lebih mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Dukungan sosial memiliki peran penting dalam proses adaptasi pasien gangguan jiwa. Terapi kelompok membantu pasien belajar berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan yang terkontrol, sementara terapi keluarga mengedukasi keluarga agar dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pasien.

4. Terapi Okupasi

Terapi okupasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Peran terapi okupasi dalam membantu pasien gangguan jiwa adalah membantu pasien menjalankan aktivitas sehari-hari secara

mandiri dan meningkatkan keterampilan kerja mereka. Banyak pasien gangguan jiwa menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti menjaga kebersihan diri, mengelola keuangan, atau bekerja. Tujuan terapi okupasi adalah untuk memberi pasien keterampilan hidup penting agar mereka lebih mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan mereka.

Banyak pasien gangguan jiwa mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengurus kebersihan diri, mengelola keuangan, atau bekerja. Terapi okupasi bertujuan melatih keterampilan hidup yang esensial, sehingga pasien dapat lebih mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.

5. Terapi Psikoedukasi

Pasien gangguan jiwa sering kali tidak sepenuhnya memahami kondisi mereka, yang menyebabkan kesulitan dalam mengatasi tantangan mental yang mereka hadapi. Melalui terapi psikoedukasi, pasien diberikan informasi mengenai kondisi mereka dan strategi koping yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan.

Sangat sulit bagi pasien gangguan jiwa untuk mengatasi masalah mental mereka karena mereka seringkali tidak sepenuhnya memahami kondisi mereka. Terapi ini akan membantu pasien dalam memahami penyakitnya saat ini dan membangun kesadaran untuk berusaha sembuh dari penderitaan. Dalam terapi ini, pasien menerima informasi tentang kondisi mereka dan strategi koping untuk meningkatkan adaptasi lingkungan mereka melalui terapi psikoedukasi.

Terapi modalitas adalah pendekatan keperawatan jiwa yang bertujuan untuk membantu pasien dengan gangguan jiwa belajar mengelola emosi, memperoleh keterampilan sosial, dan kembali beradaptasi dengan lingkungan mereka sehingga mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pasien gangguan jiwa sering mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi mereka, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Ketidakmampuan ini dapat menyebabkan pemulihan menjadi lebih sulit dan meningkatkan risiko kekambuhan. Terapi modalitas melatih, membimbing, dan mendukung pasien agar mereka dapat mengembangkan keterampilan adaptasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan pribadi.

C. Terapi Modalitas Psikofarmaka

Terapi psikofarmaka adalah pengobatan gangguan mental dengan obat-obatan yang memengaruhi susunan saraf pusat. Metode keperawatan jiwa yang dikenal sebagai terapi modalitas psikofarmaka menggunakan obat psikotropika

untuk menangani gejala gangguan jiwa. Pasien lebih mampu mengikuti terapi lain, seperti terapi kognitif, terapi lingkungan, dan terapi okupasi, dengan bantuan psikofarmaka. Dalam terapi psikofarmaka, peran perawat selain memastikan obat masuk sesuai dengan indikasi pasien, perawat juga melakukan pengkajian terhadap efek samping obat. Memastikan obat diminum pasien, merupakan peran sangat penting bagi perawat, selain itu keberlangsungan minum obat juga menjadi bagian penting bagi pasien untuk mencegah kekambuhan.

Psikofarmaka dan psikoterapi disarankan sebagai pilihan pengobatan utama untuk gangguan jiwa. Penggunaan obat psikofarmakan akan membantu meredakan dan mengendalikan gejala seperti halusinasi dan perubahan suasana hati. Psikofarmaka sifatnya hanya mengendalikan gejala dan perilaku pasien, namun pasien tetap harus minum obat selama di rumah.

1. Tujuan Terapi Psikofarmaka

- a. Mengurangi gejala gangguan jiwa seperti halusinasi, delusi, kecemasan, atau perubahan suasana hati yang ekstrem.
- b. Menstabilkan kondisi mental pasien sehingga mereka dapat berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Meningkatkan efektivitas terapi tambahan seperti terapi psikososial dan terapi okupasi.
- d. Mencegah kekambuhan dan membantu pasien mempertahankan perilaku adaptif dan keseimbangan emosional.

2. Jenis-Jenis Obat Psikofarmaka

Terapi modalitas psikofarmaka adalah komponen penting dalam penanganan gangguan jiwa. Kombinasi antara pengobatan dan terapi psikososial dapat membantu pasien meningkatkan kemampuan adaptasi, mengurangi gejala, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, penggunaan obat harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis untuk mencegah efek samping dan ketergantungan. Psikofarmaka dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan target gejalanya:

- a. Antipsikotik
 - 1) Digunakan untuk menangani skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan psikotik lainnya.
 - 2) Contoh: Haloperidol, Risperidone, Olanzapine, Clozapine.
 - 3) Berfungsi mengurangi halusinasi, delusi, dan pikiran tidak terorganisir.
- b. Antidepresan
 - 1) Digunakan untuk mengatasi depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan obsesif-kompulsif (OCD).
 - 2) Contoh: Fluoxetine, Sertraline, Amitriptyline.

- 3) Berfungsi meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin untuk memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan.
- c. Stabilisator Mood
 - 1) Digunakan untuk pasien dengan gangguan bipolar atau perubahan suasana hati ekstrem.
 - 2) Contoh: Lithium, Valproate, Carbamazepine.
 - 3) Membantu mengontrol episode mania dan depresi, serta mencegah kekambuhan.
- d. Anxiolytics (Obat Anti-Kecemasan)
 - 1) Digunakan untuk mengatasi kecemasan dan gangguan panik.
 - 2) Contoh: Diazepam, Lorazepam, Alprazolam.
 - 3) Berfungsi menenangkan sistem saraf pusat, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan ketergantungan.
- e. Stimulan
 - 1) Digunakan untuk gangguan perhatian dan hiperaktif (ADHD).
 - 2) Contoh: Methylphenidate, Amphetamine.
 - 3) Membantu meningkatkan fokus dan kontrol impuls pasien.

D. Hubungan Terapi Psikofarmaka dengan Adaptasi Pasien

1. Membantu pasien mengontrol gejala, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan.
2. Meningkatkan efektivitas terapi lain, seperti terapi kognitif dan terapi okupasi.
3. Mengurangi risiko kekambuhan, sehingga pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan mandiri.

Di rumah sakit jiwa, umumnya pasien didominasi dengan skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku, ditandai dengan halusinasi, delusi, gangguan berpikir, serta penurunan fungsi sosial dan kognitif. Salah satu pendekatan utama dalam penanganan skizofrenia adalah terapi psikofarmaka, yang bertujuan untuk mengendalikan gejala dan mencegah kekambuhan.

Psikofarmaka, terutama antipsikotik, merupakan terapi utama dalam penanganan skizofrenia. Pemilihan obat disesuaikan dengan tingkat keparahan gejala, respons pasien, serta efek samping yang mungkin terjadi. Untuk hasil terbaik, terapi obat harus dikombinasikan dengan intervensi psikososial agar pasien dapat beradaptasi dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

E. Jenis Psikofarmaka untuk Skizofrenia

Obat-obatan yang digunakan dalam terapi skizofrenia umumnya berasal dari kelompok antipsikotik, yang berfungsi mengurangi halusinasi, delusi, serta gangguan berpikir. Antipsikotik bekerja dengan menghambat aktivitas dopamin, neurotransmitter yang berperan dalam munculnya gejala psikotik.

1. Antipsikotik Generasi Pertama (Klasik/Tipikal)

Antipsikotik tipikal bekerja dengan memblokir reseptor dopamin (D2), efektif dalam mengurangi gejala positif skizofrenia, seperti halusinasi dan delusi. Namun, obat ini memiliki risiko efek samping ekstrapiramidal (gangguan gerakan).

Contoh Antipsikotik Tipikal:

- a. Haloperidol. Obat ini efektif untuk gejala psikotik akut, tetapi berisiko tinggi menyebabkan efek samping motorik seperti tremor dan kekakuan.
- b. Chlorpromazine. Obat ini sering digunakan untuk menenangkan pasien dengan agitasi, tetapi dapat menyebabkan sedasi berlebihan.
- c. Fluphenazine. Obat ini memberikan efek jangka panjang dan sering digunakan dalam bentuk suntikan depot untuk pasien yang tidak patuh minum obat.

Efek Samping Utama:

- a. Gangguan ekstrapiramidal (tremor, kekakuan otot, gerakan tidak terkendali)
- b. Sedasi dan kantuk
- c. Hipotensi ortostatik
- d. Peningkatan berat badan

2. Antipsikotik Generasi Kedua (Atypical/Atipikal)

Antipsikotik atipikal memiliki mekanisme kerja blokade dopamin dan serotonin, sehingga lebih efektif dalam mengatasi gejala negatif (misalnya, kehilangan motivasi, gangguan kognitif, dan isolasi sosial) dengan risiko efek samping motorik yang lebih rendah.

Contoh Antipsikotik Atipikal:

- a. Risperidone, derivat obat ini sering digunakan sebagai pilihan awal, efektif untuk gejala positif dan negatif dengan efek samping motorik lebih ringan dibandingkan Haloperidol.
- b. Olanzapine, obat ini lebih efektif untuk gejala positif dan negatif, tetapi dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan risiko diabetes.
- c. Quetiapine, golongan obat ini memberikan efek sedatif yang lebih kuat, sering digunakan pada pasien dengan skizofrenia dan gangguan tidur atau kecemasan.
- d. Clozapine, obat ini umumnya digunakan untuk skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan lain, tetapi memerlukan pemantauan ketat karena risiko agranulositosis (penurunan drastis sel darah putih).

Efek Samping Utama:

- a. Peningkatan berat badan
- b. Risiko diabetes dan gangguan metabolik
- c. Hipotensi ortostatik
- d. Sedasi (terutama Quetiapine)
- e. Gangguan produksi darah (khusus Clozapine)

F. Terapi Psikofarmaka dalam Pengelolaan Skizofrenia

Terapi psikofarmaka dalam pengelolaan pasien skizofrenia diberikan secara bertahap mengikuti kondisi perkembangan mental pasien. Beberapa tahapan pemberian obat ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Fase Akut

- a. Antipsikotik diberikan untuk mengendalikan gejala psikotik yang aktif (halusinasi, delusi, agitasi).
- b. Dapat diberikan dalam bentuk oral atau injeksi jika pasien tidak kooperatif.

2. Fase Pemeliharaan (Maintenance Therapy)

- a. Setelah gejala akut terkendali, pasien tetap harus mengonsumsi antipsikotik untuk mencegah kekambuhan.
- b. Antipsikotik depot (injeksi jangka panjang) seperti Risperidone atau Haloperidol sering digunakan untuk pasien yang sulit patuh minum obat.

3. Fase Rehabilitasi

- a. Terapi psikofarmaka dikombinasikan dengan terapi psikososial, terapi kognitif, dan terapi okupasi untuk membantu pasien beradaptasi dengan lingkungan.
- b. Dukungan keluarga sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.

G. Peran perawat dalam pengobatan psikofarmaka

1. Melakukan pengkajian pasien sebelum pengobatan

Sebelum pasien diberikan obat, perawat perlu melakukan pengkajian terkait dengan riwayat penyakit, diagnosis medis, hasil pemeriksaan laboratorium, riwayat pengobatan, jenis obat yang digunakan (dosis, cara pemberian, waktu pemberian), dan mengetahui program terapi lain bagi pasien. Perawat juga perlu melakukan pemeriksaan fisik, terutama difokuskan dengan kondisi fisik pasien sebelum diberikan pengobatan. Hasilnya di catatat dan didokumentasikan.

2. Mengkoordinasikan Obat dengan Terapi Modalitas

Perawat mengatur waktu minum obat pasien dengan pelaksanaan terapi modalitas yang akan dilaksanakan ke pasien. Pengaturan waktu minum obat harus disesuaikan dengan waktu paruh obat, sehingga terapi psikofarmaka berkesinambungan dengan terapi modalitas yang dialami pasien. Sinkronisasi kedua terapi ini akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jika tidak dilakukan sinkronisasi pengobatan.

3. Memberikan Pendidikan Kesehatan.

Penyebab utama kekambuhan pasien gangguan jiwa adalah putus obat. Putus obat yang dilakukan sepihak oleh keluarga maupun pasien menstimulasi pasien mengalami kekambuhan. Pendidikan kesehatan mengenai pentingnya minum obat teratur sesuai waktu paruh obat, memberikan pengertian dan pemahaman yang baik pada pasien dan keluarga akan mencegah putus obat dan mencegah kekambuhan. Sehingga keluarga dan pasien dalam program *discharge planning* perawat perlu dilakukan secara benar dan tepat.

Fenomena yang terjadi pada pasien dan keluarga tentang status minum obat juga perlu lebih ditekankan. Karena pendidikan kesehatan tentang obat diperlukan oleh pasien dan keluarga karena adanya anggapan bahwa jika pasien sudah pulang ke rumah tidak perlu lagi minum obat padahal ini menyebabkan risiko kekambuhan dan dirawat kembali di rumah sakit.

4. Memonitor Efek Samping Obat

Hasil pengkajian sebelum minum obat dijadikan dasar bagi perawat untuk mengevaluasi pengobatan yang sedang dijalankan pasien saat ini. Perawat harus mampu memonitor efek samping obat dan reaksi-reaksi lain yang kurang baik setelah pasien minum obat, penting dilakukan agar pemberian obat optimal.

H. Terapi Individu pada Pasien Gangguan Jiwa

Terapi individu adalah jenis intervensi psikologis di mana pasien dan terapis bertemu satu sama lain untuk membantu pasien gangguan jiwa mengelola gejala mereka, menjadi lebih sadar diri, dan mengembangkan strategi koping yang adaptif.

Fokus terapi individu adalah untuk membantu pasien memahami perilaku, emosi, dan pola pikir mereka sehingga mereka dapat lebih baik beradaptasi dengan lingkungan mereka.

1. Tujuan Terapi Individu

- a. Menurunkan gejala gangguan jiwa seperti kecemasan, depresi, halusinasi, atau delusi. Membantu pasien mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang dapat memperburuk kondisi mental mereka.
- b. Membangun keterampilan coping untuk menghadapi stres dan tekanan hidup. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan relasi sosial pasien.
- c. Membantu pasien memahami penyakitnya dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatannya.
- d. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri pasien.

Manfaat Terapi Individu bagi Pasien Gangguan Jiwa: Pertama, terapi individu membantu pasien lebih memahami diri mereka sendiri dan kondisinya. Kedua, gejalanya menjadi lebih ringan dan ringan. Ketiga, pasien belajar berpikir positif dan menghadapi stres. Keempat, pasien menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Kelima, terapi individu meningkatkan kemampuan sosial dan interpersonal mereka.

2. Jenis-Jenis Terapi Individu dalam Gangguan Jiwa

- a. Terapi Kognitif-Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT)

Terapi ini memungkinkan pasien dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini baik secara kognitif maupun perilaku. Terapi ini membangun kompetensi pasien agar mampu beradaptasi dengan lingkungan. Terapi secara keseluruhan bertujuan untuk membantu pasien mengenali pola pikir yang negatif atau tidak rasional dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Terapi ini akan efektif jika pasien dalam kondisi depresi, gangguan kecemasan, OCD, PTSD, dan skizofrenia. Contoh penerapan terapi kognitif-perilaku adalah kondisi pasien yang memerlukan terapi ini adalah pasien skizofrenia yang mengalami delusi dapat dibantu untuk membedakan pikiran yang nyata dan tidak nyata.

- b. Terapi Psikodinamika

Terapi psikodinamika adalah terapi yang berfokus pada hubungan antara pengalaman masa lalu, emosi, dan pola pikir seseorang dengan sikap dan perilaku mereka saat ini. Terapi ini cocok untuk pasien dengan gangguan kepribadian atau trauma emosional. Terapi psikodinamika bertujuan untuk:

- 1) Membantu pasien memiliki kesadaran diri yang lebih baik.

2) Membantu pasien memiliki pemahaman dan kesadaran diri dalam memahami pikiran, perasaan dan keyakinan terhadap diri sendiri dengan baik. Membantu klien mengungkap konflik yang belum terselesaikan

3) Membantu klien memahami pola-pola pemikiran bawah sadar mereka

Teknik terapi psikodinamika Teknik asosiasi bebas, Interpretasi atau penafsiran, Analisis transferens.

c. Terapi Dukungan (Supportive Therapy)

Terapi suportif adalah jenis terapi yang mendorong dan memberikan dukungan emosional kepada penderita masalah kesehatan mental. Terapi ini membantu penderita terbuka terhadap perasaan mereka dan hal-hal yang mereka khawatirkan, dan memberikan dukungan emosional untuk membantu mereka merasa lebih percaya diri dan kurang cemas.

Prinsip terapi ini adalah menunjukkan hubungan saling percaya, berbicara tentang hal-hal yang tabu, menghargai dan bertindak sesuai dengan keadaan mereka, memiliki sistem dukungan yang membantu mereka, dan menyelesaikan masalah secara individual. Terapi ini dapat diterapkan pada pasien dengan gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar.

d. Terapi Motivasi (Motivational Interviewing/MI)

Terapi *Motivational Interviewing* (MI) adalah teknik konseling yang membantu klien menemukan motivasi untuk mengubah perilaku mereka. Terapi ini digunakan untuk membantu pasien memotivasi dirinya berkaitan dengan kemampuannya untuk berubah dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Teknik ini juga dapat membantu klien mengatasi perasaan ambivalen. Terapi ini biasanya digunakan untuk pasien dengan gangguan penyalahgunaan zat atau gangguan bipolar

e. Terapi Mindfulness dan Relaksasi

Terapi mindfulness adalah terapi yang menggunakan teknik kesadaran untuk membantu mengatasi berbagai masalah, baik mental maupun fisik. Dalam terapi ini pasien diajarkan teknik meditasi, pernapasan dalam, dan kesadaran penuh untuk mengelola stres dan emosi negatif. Terapi ini akan efektif untuk pasien dengan gangguan kecemasan, PTSD, dan depresi.

Terapi memberikan efek dalam membantu meningkatkan kesadaran akan pikiran, perasaan, dan dunia sekitar. Membantu pasien mengenali tanda-tanda kecemasan atau stres secara dini. Selain itu, terapi ini membantu mengelola emosi secara efektif dan memberikan dampak bagi kesehatan fisik pasien. Terapi efektif dalam membantu pasien dengan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecanduan, gangguan kecemasan, dan penyalahgunaan zat

I. Terapi Kelompok

Salah satu jenis terapi modalitas yang digunakan dalam perawatan pasien gangguan jiwa adalah terapi kelompok, yang melibatkan sekelompok pasien dengan kondisi serupa yang dipandu oleh profesional kesehatan untuk berbagi pengalaman, memberikan dukungan satu sama lain, dan meningkatkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang diri mereka sendiri, meningkatkan keterampilan koping, dan meningkatkan adaptasi sosial dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

1. Tujuan Terapi Kelompok

- a. Meningkatkan keterampilan sosial pasien. Keterampilan sosial akan membantu mereka berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik.
- b. Membantu pasien mengekspresikan emosinya akan membantu mengurangi tekanan emosional karena berbagi perasaan dan pengalaman negatif yang telah mereka alami sebelumnya.
- c. Membantu pasien membuat rencana koping. Terapi akan memberi Anda cara baru untuk mengatasi kecemasan dan stres.
- d. Terapi secara berkelompok ini dapat membantu pasien merasa didukung oleh orang lain yang mengalami kondisi serupa, yang dapat mengurangi perasaan kesepian dan isolasi.
- e. Meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri pasien: Pasien dapat merasa lebih dihargai dan diterima dalam kelompok jika mereka lebih percaya diri.

2. Manfaat Terapi Kelompok bagi Pasien Gangguan Jiwa

- a. Meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi
- b. Menurunkan perasaan kesepian dan meningkatkan dukungan sosial
- c. Membantu pasien memahami dan mengelola emosinya dengan lebih baik
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan
- e. Mengajarkan teknik koping yang lebih baik untuk mengatasi stres dan kecemasan

3. Jenis-Jenis Terapi Kelompok dalam Modalitas Gangguan Jiwa

- a. Terapi Kelompok Psikoedukasi

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang gangguan jiwa, obat-obatan untuk gangguan jiwa, dan cara mengelola gejala. Pasien mengetahui pentingnya pola pikir sehat, strategi pemulihan, dan kepatuhan terhadap obat. Terapi sangat cocok untuk orang dengan skizofrenia, gangguan bipolar, atau kecemasan.

b. Terapi Kelompok Dukungan (Support Group Therapy)

Berkonsentrasi pada berbagi pengalaman dan menawarkan dukungan emosional kepada anggota kelompok. Ketika mereka menghadapi perjuangan mereka, pasien merasa lebih dipahami. Tipe terapi ini sangat cocok untuk pasien dengan depresi, gangguan bipolar, atau trauma post-traumatic.

c. Terapi Kelompok Kognitif-Perilaku (Cognitive Behavioral Group Therapy/CBGT)

Terapi kognitif-perilaku (CBT) membantu pasien dengan gangguan kecemasan, gangguan kecemasan obsesif-kompulsif, atau depresi mengubah pola pikir dan perilaku negatif mereka.

d. Terapi Kelompok Interpersonal

Membantu pasien dengan gangguan kepribadian, skizofrenia, atau gangguan kecemasan sosial dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan hubungan sosial.

e. Terapi Kelompok Kreatif (Art Therapy, Music Therapy, Drama Therapy)

Membantu pasien menyalurkan emosi mereka melalui media ekspresi seperti seni, musik, atau drama. Terapi ini cocok untuk pasien dengan gangguan emosi, PTSD, atau skizofrenia.

f. Terapi Kelompok Relaksasi dan Mindfulness

Mengajar pasien teknik relaksasi, meditasi, dan kesadaran diri untuk menurunkan stres dan meningkatkan kesadaran diri. Ini cocok untuk pasien dengan gangguan kecemasan, gangguan post-trauma jiwa, atau gangguan psikosomatik.

Secara spesifik terapi kelompok akan dibahas sesuai standard pelayanan keperawatan dan sering digunakan di klinik adalah terapi aktifitas kelompok. Terapi aktifitas kelompok ini mengacu pada penyelesaian masalah keperawatan pasien yang telah dilakukan intervensi secara individu, dilanjutkan dengan terapi aktifitas kelompok.

Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) adalah salah satu bentuk terapi modalitas dalam keperawatan jiwa yang melibatkan sekelompok pasien untuk melakukan aktivitas bersama dengan tujuan membantu mereka meningkatkan keterampilan sosial, ekspresi diri, serta mengelola emosi dan perilaku secara lebih adaptif. Dalam terapi aktifitas kelompok ini, kelompok terapi dibangun melalui kesamaan pasien berupa masalah keperawatan yang sama, telah dilakukan terapi individu serta mau bekerja sama selama terapi berlangsung.

TAK dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana pasien dapat belajar dari satu sama lain, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kemampuan interpersonal yang lebih baik.

Syarat pasien yang dapat dilakukan TAK adalah

- a. Pasien berkomitmen melaksanakan terapi sampai selesai
- b. Kesadaran diri baik dan mau bekerjasama dalam kelompok
- c. Pasien telah dilaksanakan terapi individu sebelumnya terutama dalam TAK yang akan dilaksanakan
- d. Pasien memiliki masalah utama yang sama, meskipun beberapa pasien terdapat masalah lain

4. Jenis-Jenis Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)

Jenis TAK dilaksanakan berdasarkan standar asuhan perawatan dan memiliki gejala klinis serta masalah keperawatan yang sama. TAK ini bagian dari terapi kelompok yang didasari permasalahan keperawatan yang sama. TAK terdiri dari berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, di antaranya:

a. TAK Sosialisasi

TAK sosialisasi adalah terapi aktivitas kelompok yang bertujuan membantu klien yang mengalami isolasi sosial untuk bersosialisasi secara bertahap. TAK sosialisasi merupakan salah satu modalitas terapi yang dilakukan perawat kepada sekelompok pasien. TAK dengan aktivitas belajar tahapan komunikasi dengan orang lain untuk meningkatkan kemampuan dalam berhubungan sosial.

Tujuan TAK sosialisasi memfasilitasi kemampuan sosialisasi klien, membantu klien yang mengalami isolasi sosial, membantu klien yang mengalami kerusakan komunikasi verbal, sehingga pasien memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan interaksi sosial pasien. Terapi ini biasanya dilakukan untuk pasien dengan gangguan interaksi sosial, gangguan kecemasan sosial, skizofrenia, dan depresi. Terapi ini dapat berbentuk : diskusi kelompok, bermain peran, atau berbagi pengalaman. Indikasi TAK sosialisasi di tujukan pada pasien dengan masalah keperawatan sebagai berikut

- 1) Pasien baru
- 2) Isolasi social
- 3) Kerusakan interaksi social
- 4) Harga diri rendah.

Pelaksanaan TAK sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dengan beberapa sesi. Setiap sesi menggambarkan toleransi pasien dalam melaksanakan sosialisasi. Adapun setiap sesi nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sesi I: Memperkenalkan diri
- 2) Sesi II: Berkenalan dengan anggota kelompok
- 3) Sesi III: Bercakap-cakap dengan anggota

- 4) Sesi IV: Menyampaikan topik pembicaraan
- 5) Sesi V: Menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi dgn orang lain.
- 6) Sesi VI : Bekerjasama dlm permainan sosialisasi kelompok
- 7) Sesi VII: Menyampaikan pendapat ttg manfaat kegiatan kelompok yg telah dilakukan

b. TAK Orientasi realita

TAK dgn kegiatan utama upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata pada pasien psikotik , yaitu orientasi pada diri sendiri orang lain, lingkungan/ tempat dan waktu. Indikasi: Pasien yang terganggu orientasi realitanya : orang,tempat,waktu pada pasien psikotik dan demensia.

TAK ini dilaksanakan dalam tiga sesi kegiatan kelompok yaitu:

- 1) Sesi I: pengenalan orang
- 2) Sesi II: pengenalan tempat
- 3) Sesi III: pengenalan waktu

c. TAK Stimulasi Persepsi

Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi halusinasi adalah terapi yang menggunakan aktifitas kelompok sebagai stimulus dan pengungkapan pengalaman pasien untuk didiskusikan di kelompok.. Hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau alternatif penyelesaian masalah.

TAK ini bertujuan untuk membantu pasien mengenali halusinasi yang dideritanya, mengidentifikasi pengalaman pasien lain dalam menghadapi halusinasi dan mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaannya tentang halusinasinya dan bagaimana mereka menghadapinya. Dalam terapi ini setiap pasien akan mengungkapkan pengalamannya kepada pasien lainnya dalam kelompok dengan fasilitator perawat. Perawat akan mencatat setiap upaya yang dilakukan pasien dan bersama pasien menganggapinya, setelah itu akan muncul kesepakatan bersama berkomitmen melawan halusinasi. TAK ini diharapkan kelompok memiliki kontrol sosial untuk bersama saling membantu dalam menghadapi halusinasi. Kontrol untuk saling mengingatkan dan mencegah jika tiba-tiba halusinasi muncul. Terapi ini sering dilakukan di klinik, oleh karena itu sebagai catatan penerapan terapi ini diharapkan menjadi dasar bagi pasien untuk mencegah dan mengurangi dampak halusinasi bagi pasien skizofrenia.

TAK stimulasi sensori dapat diindikasikan pada pasien dengan masalah keperawatan sebagai berikut:

- 1) Risiko perilaku kekerasan
- 2) Halusinasi
- 3) Isolasi sosial

4) Harga diri rendah

Berikut ini sesi tahapan pelaksanaan TAK stimulasi persepsi sensori sesuai dengan indikasi masalah keperawatan sebagai berikut.

1) TAK Stimulasi persepsi umum:

- a) 1. Sesi i: menonton tv
- b) Sesi ii: membaca majalah/koran
- c) Sesi iii: melihat gambar

2) TAK stimulasi persepsi mengontrol halusinasi:

- a) Sesi I: mengenal halusinasi
- b) Sesi II: mengontrol halusinasi: menghardik halusinasi
- c) Sesi III: mengontrol halusinasi: melakukan kegiatan
- d) Sesi IV: mengontrol halusinasi: bercakap-cakap
- e) Sesi V: mengontrol halusinasi: minum obat teratur

3) TAK Stimulasi persepsi mengontrol perilaku kekerasan:

- a) 1. Sesi I: mengenal pk
- b) 2. Sesi II: mencegah pk dengan kegiatan fisik
- c) 3. Sesi III: mencegah pk dgn kegiatan interaksi sosial asertif
- d) 4. Sesi IV: mencegah pk dgn kegiatan patuh minum obat
- e) 5. Sesi V: mencegah pk dgn kegiatan ibadah

d. TAK Kognitif

- 1) Fokus pada stimulasi fungsi otak dan peningkatan daya ingat. Contoh: Permainan memori, teka-teki, dan latihan pemecahan masalah.
- 2) Cocok untuk pasien dengan demensia, skizofrenia, atau gangguan kognitif ringan.

e. TAK Perilaku

- 1) Membantu pasien mengembangkan pola perilaku yang lebih sehat dan adaptif. Contoh: Pelatihan manajemen stres, latihan pengendalian emosi, dan teknik relaksasi.
- 2) Cocok untuk pasien dengan gangguan bipolar, skizofrenia, atau gangguan impulsif.

f. TAK Sensorimotorik

- 1) Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan keterampilan motorik pasien. Contoh: Senam ringan, yoga, atau latihan pernapasan.
- 2) Cocok untuk pasien dengan gangguan jiwa yang mengalami gangguan koordinasi atau kecemasan berlebih.

g. TAK Kreatif

- 1) Menggunakan seni dan ekspresi kreatif untuk membantu pasien menyalurkan emosi mereka. Contoh: Melukis, menggambar, menulis puisi, atau bermain musik.
- 2) Cocok untuk pasien dengan gangguan depresi, PTSD, atau kecemasan.

h. TAK Rekreasional

- 1) Bertujuan untuk menghibur pasien sambil tetap meningkatkan keterampilan sosial.
- 2) Contoh: Bermain permainan kelompok, karaoke, atau olahraga ringan.
- 3) Cocok untuk semua pasien gangguan jiwa yang membutuhkan stimulasi positif.

5. Proses terapi aktivitas kelompok

Terapi aktifitas kelompok dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam setiap sesi kegiatannya, yaitu

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap orientasi
- c. Tahap kerja
- d. Tahap terminasi

Peran perawat dalam TAK Pemimpin kelompok:

- a. Leader, bertugas merancang tak, memimpin jalannya TAK ak
- b. Wakil pemimpin kelompok : co leader yang bertugas dalam membantu leader memimpin tak
- c. Fasilitator: seolah menjadi anggota kelompok, berperan dalam membantu menstimulasi kelompok
- d. Observer: mengamati, menilai, memberi masukan

Tahap persiapan

Sebelum kegiatan dimulai, perawat perlu melakukan Identifikasi pasien yang akan dilibatkan dalam TAK yaitu pasien dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Sehat fisik
 - b. Sudah kooperatif
 - c. Berkomunikasi dgn baik
 - d. Tidak dlm pengaruh obat yang mengganggu kemampuan konsentrasi pasien
- Jenis TAK ditentukan oleh masalah keperawatan yang dialami oleh klien adapun jenis TAK yg bisa dilaksanakan yaitu:
- a. Klien PK: TAK Sosialisasi dilanjutkan dgn TAK SP mengontrol PK
 - b. Klien Halusinasi: TAK Sosialisasi dilanjutkan dgn TAK SP mengontrol halusinasi
 - c. Klien Isolasi sosial: TAK sosialisasi

- d. Klien HDR: TAK Sosialisasi dilanjutkan TAK SP meningkatkan HDR
 - e. Klien DPD: TAK Sosialisasi (fase 4 topik yg dibicarakan ttg perawatan diri)
 - f. Klien Waham: TAK Sosialisasi dilanjutkan TAK SP meningkatkan HDR
 - g. Klien demensia: TAK Orientasi realita dilanjutkan TAK Sosialisasi
- Persiapan alat dan bahan misalnya bola plastik, kaset dll sesuai dengan TAK yang akan dilaksanakan
- a. Tentukan tempat yang luas,nyaman dan aman
 - b. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan kesepakatan klien\

Tahap orientasi

Dilakukan setelah klien berkumpul ditempat pelaksanaan TAK dan kegiatan orientasi meliputi:

- a. Mengucapkan salam
- b. Memvalidasi perasaan klien
- c. Menjelaskan tujuan TAK
- d. Menyepakati aturan main TAK

Tahap Kerja

Leader memimpin klien untuk melakukan aktivitas. TAK untuk mencapai tujuan misalnya: untuk TAK sosialisasi fase I mengajak klien memperkenalkan diri secara bergantian dan seterusnya

Tahap Terminasi

Dilakukan untuk mengakhiri TAK, dgn kegiatan:

- a. Evaluasi perasaan klien
- b. Memberikan pujian
- c. Memberikan tindak lanjut kegiatan
- d. Menyepakati kegiatan TAK berikutnya

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan untuk menilai proses berjalannya TAK yang berjalan. Evaluasi pelaksanaan yang dapat dilihat dari 2 sisi yaitu kemajuan pasien dan perawat. Adapun evaluasi ini dapat dilaksanakan sebagai berikut

- a. Evaluasi kemampuan pasien

Dilakukan dgn mengamati perilaku klien selama TAK, apakah klien menunjukkan perilaku seperti yang direncanakan/tidak? Dengan cara mengisi tabel evaluasi pada masing-masing jenis TAK
- b. Evaluasi kemampuan perawat

Dalam melaksanakan TAK, sesuai peran masing-masing. Tujuan evaluasi ini dalam meningkatka profesionalisme perawat dalam melaksanakan terapi ini,

terutama integrasi kesesuaian antara terapi individu yang dilakukan dan aktifitas kelompok yang dijalankan pasien saat ini.

J. *Electroconvulsive Therapy*

Electroconvulsive Therapy (ECT) adalah prosedur medis yang menggunakan arus listrik bertegangan rendah untuk merangsang otak guna menimbulkan kejang yang terkontrol. Terapi ini dilakukan di bawah pengaruh anestesi umum dan digunakan untuk menangani gangguan jiwa yang tidak merespons terapi lain, seperti depresi berat, skizofrenia, atau gangguan bipolar.

1. Manfaat ECT bagi Pasien Gangguan Jiwa

- a. Efek lebih cepat dibandingkan obat psikofarmaka, terutama dalam kasus depresi berat dan risiko bunuh diri.
- b. Bermanfaat untuk pasien yang tidak merespons terapi obat.
- c. Efektif dalam mengatasi gejala psikotik atau katatonik pada skizofrenia.
- d. Prosedur aman dengan tingkat keberhasilan tinggi.

2. Indikasi Penggunaan ECT

ECT biasanya direkomendasikan untuk pasien dengan kondisi berikut:

- a. Depresi berat yang resistan terhadap pengobatan
 - 1) Pasien yang tidak membaik dengan obat antidepresan atau terapi psikologis.
 - 2) Depresi dengan gejala psikotik seperti halusinasi atau delusi.
- b. Skizofrenia atau gangguan psikotik berat
 - 1) Pasien dengan gejala katatonik (tidak bergerak, diam, atau kaku dalam waktu lama).
 - 2) Skizofrenia yang tidak membaik dengan obat antipsikotik.
- c. Gangguan Bipolar

Mengatasi episode manik berat atau depresi ekstrem yang tidak merespons terapi lain.
- d. Tendensi Bunuh Diri yang Mendesak

ECT dapat memberikan efek cepat dalam menurunkan ide bunuh diri pada pasien dengan depresi berat.
- e. Kondisi Darurat Psikiatri

Pasien dalam kondisi psikotik akut yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

3. Efek Samping dan Risiko ECT

Meskipun aman, ECT dapat menyebabkan beberapa efek samping, seperti:

- a. Gangguan Memori (Amnesia Sementara)
 - 1) Kesulitan mengingat kejadian sebelum atau setelah terapi.

- 2) Biasanya berangsur membaik dalam beberapa minggu atau bulan.
- b. Kebingungan
Setelah prosedur, pasien bisa merasa bingung selama beberapa menit hingga jam.
- c. Sakit Kepala atau Nyeri Otot
Efek dari pelepasan otot atau kejang yang ditimbulkan.
- d. Mual
Akibat penggunaan anestesi.
- e. Risiko Kardiovaskular
Peningkatan tekanan darah atau detak jantung yang bisa berisiko bagi pasien dengan penyakit jantung.

K. Psychotherapy (Talk Therapy)

Psychotherapy, atau yang lebih dikenal sebagai *talk therapy*, adalah suatu pendekatan pengobatan dalam kesehatan mental yang menggunakan komunikasi verbal dan teknik psikologis untuk membantu pasien mengatasi masalah emosional, perilaku, dan mental. Terapi ini dilakukan oleh psikolog, psikiater, perawat spesialis atau terapis berlisensi dengan pengalaman kerja yang sesuai. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien memahami perasaan mereka, mengubah pola pikir negatif, serta meningkatkan keterampilan coping dalam menghadapi stres atau trauma.

Psychotherapy atau talk therapy adalah metode yang efektif dan berbasis ilmiah dalam menangani berbagai gangguan jiwa. Dengan berbagai pendekatan seperti CBT, *Dialectical Behavior Therapy* (DBT), dan *psychodynamic therapy*, pasien dapat belajar mengatasi stres, memahami emosi, dan mengembangkan pola pikir yang lebih sehat. Psychotherapy dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau keluarga, dan sering kali dikombinasikan dengan pengobatan psikofarmaka untuk hasil yang optimal.

Tujuan Psychotherapy

1. Membantu pasien memahami dan mengelola emosi mereka.
2. Mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang merugikan.
3. Meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi.
4. Membantu pasien mengatasi trauma dan pengalaman buruk di masa lalu.
5. Mengurangi gejala gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau skizofrenia.
6. Meningkatkan kualitas hidup dan hubungan interpersonal.

Jenis-Jenis Psychotherapy (Talk Therapy)

1. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)
 - a. Fokus pada mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif.

- b. Efektif untuk depresi, gangguan kecemasan, OCD, PTSD, dan gangguan makan.
- 2. *Psychodynamic Therapy*
 - a. Membantu pasien memahami bagaimana pengalaman masa lalu memengaruhi emosi dan perilaku saat ini.
 - b. Cocok untuk gangguan kepribadian, trauma, atau konflik emosional yang mendalam.
- 3. *Humanistic Therapy (Person-Centered Therapy)*
 - a. Berfokus pada pengembangan diri dan pemahaman diri sendiri.
 - b. Membantu pasien meningkatkan harga diri dan mencapai potensi diri.
- 4. *Dialectical Behavior Therapy (DBT)*
 - a. Dikembangkan untuk gangguan kepribadian borderline (BPD), tetapi juga efektif untuk gangguan makan, PTSD, dan depresi.
 - b. Mengajarkan keterampilan pengendalian emosi, kesadaran diri (mindfulness), dan toleransi terhadap stres.
- 5. *Interpersonal Therapy (IPT)*
 - a. Membantu pasien dalam memperbaiki hubungan interpersonal dan mengatasi konflik sosial.
 - b. Efektif untuk depresi, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan mood.
- 6. *Exposure Therapy*
 - a. Digunakan untuk gangguan kecemasan, PTSD, dan fobia.
 - b. Pasien secara bertahap dihadapkan pada sumber ketakutan mereka dalam lingkungan yang aman.
- 7. *Family Therapy dan Couples Therapy*
 - a. Bertujuan untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan dalam keluarga atau pasangan.
 - b. Efektif untuk mengatasi konflik keluarga, gangguan perilaku anak, dan permasalahan pernikahan.

L. Latihan

Setelah anda membaca materi terapi modalitas, silahkan anda menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Seorang pasien gangguan jiwa mengeluhkan sulitnya dia menghindari pikiran-pikiran negatif yang selalu menghantuinya. Sebagai perawat, pasien tersebut terindikasi memerlukan terapi modalitas adalah
 - A. Terapi bermain
 - B. Terapi kognitif
 - C. Terapi psikofarmaka

- D. Terapi lingkungan
 - E. Terapi meditasi
2. Pasien gangguan jiwa mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan dimana dia tinggal. Kesulitan adaptasi pasien disebabkan oleh
- A. Gangguan proses berpikir
 - B. Takut halusinasinya mengganggu
 - C. Kesulitan dalam mengungkapkan perasaan
 - D. Selalu ingin menang sendiri
 - E. Gagal dalam membina hubungan saling percaya
3. Kesulitan pasien gangguan jiwa disebabkan karena
- A. Gangguan dalam berkomunikasi dengan orang lain
 - B. Kesulitan memulai komunikasi dengan orang lain
 - C. Hambatan dalam proses berpikir
 - D. Kesulitan dalam mengungkapkan kata-kata
 - E. Tidak mampu membina hubungan saling percaya
4. Psikoterapi dalam terapi modalitas sering disebut dengan:
- A. *Talk therapy*
 - B. Psikoedukasi
 - C. *Burn out therapy*
 - D. *Lihgting therapy*
 - E. *Talking with hallucination*
5. Peran perawat dalam melaksanakan terapi modalitas adalah
- A. Mengembalikan fungsi normal pasien
 - B. Membantu pasien beradaptasi dengan kondisinya
 - C. Membantu mendorong pasien bersosialisasi
 - D. Membantu meningkatkan coping pasien
 - E. Mendorong pasien membina hubungan saling percaya
6. Seorang pasien mengungkapkan kesulitan dalam menyesuaikan pekerjaannya terutama setelah dia masuk RS jiwa. Sebelumnya pasien bekerja sebagai tukang. Terapi modalitas apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut?
- A. Terapi okupasi
 - B. Terapi kognitif
 - C. Terapi psikofarmaka
 - D. Terapi lingkungan
 - E. Terapi meditasi

7. Seorang pasien tidak mau minum obat setelah merasakan air liurnya sering keluar dan mulutnya kering. Berdasarkan data tersebut, pasien mengalami efek samping dari obat psikotropika apa?
 - A. Clorprmazin
 - B. Triheksilpenitine
 - C. Haloperidol
 - D. Kloramfenikol
 - E. Fentamine
8. Pemberian obat psikofarmaka ditujukan untuk mengurangi gejala yang dikeluarkan pasien. Obat yang digunakan untuk mencegah efek ekstrapiramidal adalah obat
 - A. Haldol
 - B. CPZ
 - C. THP
 - D. Amfetamine
 - E. Diazepam
9. Seorang pasien dengan perilaku kekerasan dengan masalah yang dominan halusinasi pendengaran, telah menjalani terapi individu. Langkah selanjutnya untuk pasien ini adalah
 - A. Terapi aktifitas kelompok sosialisasi
 - B. Terapi aktifitas kelompok persepsi sensori
 - C. Terapi aktifitas kelompok perilaku kekerasan
 - D. Terapi aktifitas kelompok marah
 - E. Terapi aktifitas kelompok halusinasi
10. Peran perawat sebelum memberikan obat psikofarmaka, yang perlu diperhatikan pada pasien tersebut adalah
 - A. Melakukan assesment terkait pengalaman menggunakan obat sebelumnya
 - B. Menanyakan ke dokter dosis obat yang sesuai
 - C. Mendorong pasien untuk taat minum obat
 - D. Mengkaji efek samping minum obat psikotropika
 - E. Kebiasaan minum obat pasien

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas.

1. Mengapa terapi modalitas diperlukan bagi pasien gangguan jiwa?
2. Apa yang menyebabkan pasien gangguan jiwa sulit beradaptasi dengan lingkungan?
3. Apa permasalahan dalam penerapan terapi modalitas pada pasien gangguan jiwa?

4. Umumnya pasien gangguan mengalami gangguan interaksi sosial, apa yang menyebabkan pasien mengalami masalah ini?
5. Apa yang akan terjadi jika pasien gangguan jiwa tidak mampu mengelola emosi dan mengontrol perilakunya?

M. Kunci Jawaban

1. B
2. A
3. A
4. A
5. B
6. A
7. C
8. C
9. B
10. A

N. Rangkuman Materi

Terapi modalitas melibatkan perawat sebagai alat terapeutic pasien dalam membantu pasien beradaptasi dengan lingkungannya. Peran perawat dalam dalam terapi modalitas mendorong pasien meningkatkan harga diri, membangun kembali relasi, membangun coping dalam menghadapi stres. Melalui terapi modalitas, perawat membangun harapan baru bagi pasien dalam proses kesembuhannya.

Terapi modalitas dalam buku ini memberikan gambaran beberapa terapi yang sering digunakan pasien gangguan jiwa baik di rumah sakit jiwa maupun di komunitas melalui layanan primer. Buku ini menjelaskan tentang terapi modalitas dan bagaimana cara menerapkannya sesuai dengan indikasi pasien.

Pembaca diharapkan dapat menentukan dan mengidentifikasi kebutuhan pasien tentang terapi modalitas. Melalui penerapan konsep keperawatan jiwa, buku ini menjelaskan bagaimana penerapan konsep pendekatan perawatan jiwa dalam pelaksanaan terapi modalitas. Secara prinsip, terapi modalitas yang diterapkan terlebih dahulu menyelesaikan terapi individu terlebih dulu, sebelum menjalani berbagai program terapi modalitas yang diterapkan.

O. Glosarium

A

ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) = gangguan neurobiologis yang menyebabkan kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivita

Antipsikotik = obat yang digunakan untuk mengatasi gejala psikosis, seperti halusinasi dan delusi

D

Distorsi kognitif = pola pikir yang tidak sehat dan irasional yang dapat memengaruhi emosi dan persepsi seseorang

Delusi (waham) = gangguan mental yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan

G

Gangguan bipolar = gangguan kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati secara drastis

H

Halusinasi = gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

Holistik = memberikan dukungan yang melihat keseluruhan orang tersebut, bukan hanya kebutuhan kesehatan mentalnya

Hipotensi ortostatik = hipotensi akibat perubahan posisi tubuh

I

Isolasi social = kondisi ketika seseorang menghindari interaksi sosial dengan orang lain

O

Okupasi terapi = layanan kesehatan yang membantu orang dengan gangguan fisik atau mental untuk melakukan aktivitas sehari-hari

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) = gangguan mental jangka panjang yang memengaruhi pikiran dan perilaku seseorang

M

Mindfulness = kesadaran penuh atau kewawasan akan diri sendiri, pikiran, dan perilaku saat ini

P

Psikofarmaka = obat yang digunakan untuk mengobati gangguan kejiwaan, seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia.

Psikoterapi = metode terapi untuk mengatasi masalah kejiwaan, seperti depresi, stres, dan gangguan kecemasan. Psikoterapi juga dikenal sebagai terapi bicara

Post-traumatic stress disorder (PTSD)= gangguan mental yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis

S

Sedasi = depresi kesadaran sementara yang diinduksi secara medis sebelum prosedur yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada pasien.

Skizofrenia = gangguan mental berat yang memengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku seseorang

Stigma = keyakinan negatif atau label buruk yang disematkan kepada seseorang atau kelompok tertentu.

Substitusi pikiran = penggantian atau penukar sesuatu dengan pikiran ke pikiran yang lain

P. Daftar Pustaka

- Alexander, L. (2024). Psychiatric Mental Health Nursing. In *Comprehensive Healthcare Simulation: Nursing* (pp. 85-100). Cham: Springer International Publishing.
- American Psychiatric Association. (2020). *Practice Guidelines for the Psychiatric Evaluation of Adults*. American Psychiatric Publishing.
- Amir, E. E. S., Sulistyowati, E. C., Sulistyowati, D. A., Gunawan, I., Restiana, N., Sholihat, N., & Nuraenah, N. (2024). *Terapi Modalitas Keperawatan Jiwa: Teori dan Aplikasinya*. Penerbit Tahta Media.
- Amir, E. E. S., Sulistyowati, E. C., Sulistyowati, D. A., Gunawan, I., Restiana, N., Sholihat, N., & Nuraenah, N. (2024). *Terapi Modalitas Keperawatan Jiwa: Teori dan Aplikasinya*. Tahta Media.
- Azizah, L. M., Zainuri, I., & A., A. (2019). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa: Teori dan Aplikasi Praktik Klinik*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Barker, P. (2021). *Psychiatric and Mental Health Nursing: The Craft of Caring* (4th ed.). CRC Press.
- Boyd, M. A. (2022). *Psychiatric Nursing: Contemporary Practice* (7th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Butcher, H. K., Bulechek, G. M., Dochterman, J. M., & Wagner, C. (2020). *Nursing Interventions Classification (NIC)* (7th ed.). Elsevier.
- Elder, R., Evans, K., & Nizette, D. (2020). *Psychiatric and Mental Health Nursing* (5th ed.). Elsevier.
- Fitzpatrick, J. J., & Kazer, M. W. (2021). *Encyclopedia of Nursing Research* (4th ed.). Springer Publishing Company.
- Ghofur, A., R, R. P., Hilda, A., & Sasmito, P. (2024). Increasing Self-Compassion and State-Mindfulness to Maintain Mental Health of Health Care Professionals

- through e-WellMind App: A Cluster Randomized Controlled Trial. *International Journal of Public Health Excellence (IJPHE)*, 4(1), 188–196.
<https://doi.org/10.55299/ijphe.v4i1.1113>
- Gorman, J. M., & Anker, J. J. (2021). *Treating Comorbid Opioid Use Disorder in Chronic Pain* (1st ed.). Springer.
- Halter, M. J. (2021). *Varcarolis' Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing: A Clinical Approach* (9th ed.). Elsevier.
- Herawani, N., & Syahrums. (2020). The Effect of Perception Stimulation Group Activity Therapy on Controlling Ability of Hallucinations in Patients with Schizophrenia. *Journal of Global Health Research*, 2(1), 57–64.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2021). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2021–2023*. Thieme Medical Publishers.
- Kaplan, B. J., & Sadock, V. A. (2022). *Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry* (12th ed.). Wolters Kluwer.
- Keltner, N. L., & Steele, D. (2020). *Psychiatric Nursing* (8th ed.). Elsevier.
- Keliat, dkk, 2014., [*Keperawatan Jiwa Terapi Aktivitas Kelompok*](#), Jakarta, EGC
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pelaksanaan Terapi Modalitas dalam Keperawatan Jiwa. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lusk, S. L., & Melnyk, B. M. (2021). *Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Morrison-Valfre, M. (2020). *Foundations of Mental Health Care* (6th ed.). Elsevier.
- O'Brien, P. G., Kennedy, W. Z., & Ballard, K. A. (2020). *Psychiatric Mental Health Nursing: An Introduction to Theory and Practice* (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Peplau, H. E. (2021). *Interpersonal Relations in Nursing: A Conceptual Frame of Reference for Psychodynamic Nursing*. Springer Publishing Company.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Prasetyo, B., & Wulandari, S. (2021). Efektivitas Terapi Musik terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Pasien Skizofrenia. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(2), 123–130.
- Rahmawati, D., & Setiawan, A. (2020). Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif terhadap Kualitas Tidur pada Pasien dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia*, 15(1), 45–52.
- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2021). *Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry* (10th ed.). Wolters Kluwer.

- Sapitri, Y., Aprilla, N., & Daud, S. (2024). Penerapan Terapi Modalitas (Terapi Senam Aerobik) Pada Ny. R Dengan Halusinasi Pendengaran Terhadap Frekuensi Halusinasi Pendengaran Di Rsj Tampan Provinsi Riau. *Excellent Health Journal*, 3(1), 572-578.
- Sari, M., & Yulianti, R. (2022). Implementasi Terapi Kognitif Perilaku untuk Mengurangi Gejala Depresi pada Pasien Gangguan Jiwa. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 11(3), 210–218.
- Sari, R., & Budiarto, E. (2025). Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Halusinasi dan Kombinasi Musik pada Pasien Gangguan Jiwa (Studi Kasus). *Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat*, 3(1), 46-52.
- Sheehy, L., & Nieginski, E. (2020). *Manual of Psychiatric Nursing Care Planning: Assessment Guides, Diagnoses, Psychopharmacology* (6th ed.). Elsevier.
- Standar Asuhan Keperawatan Jiwa (SAK). (2017). Program Pendidikan Ners Spesialis Keperawatan Jiwa. Depok: Universitas Indonesia.
- Stuart, G. W. (2020). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Suci, R. (2023). Penerapan Terapi Aktivitas Waktu Luang (Senam) pada Pasien dengan GSP: Halusinasi Pendengaran dan Penglihatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(8).
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2021). *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice* (10th ed.). F.A. Davis Company.
- Varcarolis, E. M. (2020). *Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: A Communication Approach to Evidence-Based Care* (4th ed.). Elsevier.
- Videbeck, S. L. (2021). *Psychiatric-Mental Health Nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Wheeler, K. (2020). *Psychotherapy for the Advanced Practice Psychiatric Nurse: A How-To Guide for Evidence-Based Practice* (2nd ed.). Springer Publishing Company.
- World Health Organization. (2021). *Guidelines on Mental Health at Work*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). *Gangguan Jiwa: Fakta dan Angka*.
- Zuckerman, E. L. (2020). *Clinician's Thesaurus: The Guide to Conducting Interviews and Writing Psychological Reports* (8th ed.). Guilford Press.
- Zung, W. W. K. (2020). *Self-Rating Depression Scale in Psychiatry*. Springer.

BAB 7

MANAJEMEN PELAYANAN KEPERAWATAN JIWA PROFESIONAL DI KLINIK DAN KOMUNITAS

Pendahuluan

Pelayanan keperawatan jiwa profesional di klinik dan komunitas memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup individu dengan gangguan jiwa dan keluarganya. Seiring dengan meningkatnya prevalensi gangguan jiwa, manajemen pelayanan keperawatan yang profesional menjadi hal yang krusial baik di lingkungan klinis maupun komunitas. Manajemen yang efektif mencakup koordinasi yang terintegrasi, pengembangan kebijakan yang mendukung pelayanan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan. Perawat jiwa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, berbasis bukti, serta responsif terhadap kebutuhan individu dan komunitas dalam berbagai tatanan kesehatan jiwa.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola pelayanan keperawatan jiwa secara profesional dan terintegrasi baik di lingkungan klinis maupun komunitas dengan pendekatan berbasis bukti dan prinsip etika profesional untuk mendukung kualitas hidup pasien dan keluarga.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen pelayanan keperawatan jiwa secara profesional di berbagai tatanan pelayanan kesehatan jiwa, baik klinik maupun komunitas, berdasarkan standar praktik keperawatan psikiatri terbaru.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional di tatanan klinik dan komunitas.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai model manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional yang efektif untuk klinik dan komunitas.

- Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan manajerial dalam mengelola pelayanan keperawatan jiwa yang berorientasi pada pasien dan komunitas.
- Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas pelayanan keperawatan jiwa yang telah diterapkan di berbagai tatanan.
- Mahasiswa mampu mengembangkan strategi kolaborasi interprofesional dan komunitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan jiwa.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa

1. Definisi dan Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa

Manajemen pelayanan keperawatan jiwa merupakan proses sistematis yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan jiwa untuk mencapai tujuan terapi yang efektif. Ruang lingkungannya mencakup promosi kesehatan mental, pencegahan gangguan jiwa, diagnosis dini, intervensi terapeutik, hingga rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Pelayanan ini dilakukan di berbagai tatanan, mulai dari rumah sakit, pusat rehabilitasi, hingga komunitas, yang mencakup seluruh aspek kebutuhan pasien dan keluarganya.

Manajemen keperawatan jiwa juga melibatkan penggunaan sumber daya yang efisien, peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, serta integrasi peran profesional dari berbagai disiplin ilmu dalam praktik keperawatan jiwa.

2. Peran dan Tanggung Jawab Perawat Jiwa Profesional

Perawat jiwa profesional memiliki peran penting dalam pengelolaan pelayanan keperawatan jiwa, antara lain:

- a. Caregiver: Memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien, melakukan pengkajian mendalam, menentukan diagnosis keperawatan jiwa, merancang intervensi terapeutik, serta mengevaluasi efektivitas intervensi.
- b. Koordinator Tim: Mengelola koordinasi antar tim multidisiplin, memastikan komunikasi yang efektif antara berbagai profesional kesehatan seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan terapis lainnya.
- c. Edukator: Menyediakan pendidikan dan informasi terkait gangguan jiwa, manajemen gejala, serta strategi pencegahan kepada pasien, keluarga, dan komunitas.
- d. Advokat: Bertindak sebagai pembela hak pasien dengan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya serta menjamin hak-hak pasien dihormati dalam seluruh aspek pelayanan.
- e. Konsultan: Memberikan konsultasi kepada pihak-pihak terkait mengenai cara terbaik mengelola pelayanan kesehatan jiwa, meningkatkan kualitas layanan, dan memecahkan masalah yang muncul dalam praktik.
- f. Peneliti: Berperan aktif dalam penelitian untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan evidence-based practice dan melakukan inovasi dalam manajemen pelayanan kesehatan jiwa.

3. Prinsip-prinsip Manajemen Keperawatan Jiwa

Manajemen pelayanan keperawatan jiwa didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Berpusat pada Pasien (Patient-Centered Care): Menempatkan pasien sebagai prioritas utama dalam seluruh proses pelayanan dengan pendekatan holistik yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.
- b. Pendekatan Multidisiplin: Melibatkan berbagai profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan terpadu.
- c. Kolaborasi dan Kemitraan: Menjalinkan kerja sama yang erat dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk mendukung proses pemulihan.
- d. Kontinuitas Perawatan: Menjamin kesinambungan pelayanan mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- e. Praktik Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice): Menggunakan data ilmiah dan bukti terkini dalam setiap pengambilan keputusan klinis.
- f. Efektivitas dan Efisiensi: Optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil pelayanan maksimal dengan biaya yang efektif.
- g. Etika dan Legalitas: Menjalankan praktik pelayanan sesuai dengan kode etik profesi dan aturan hukum yang berlaku, serta menghormati hak-hak pasien dan keluarganya.

B. Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa di Klinik

1. Proses Pengkajian dan Diagnosis Keperawatan Psikiatri

Pengkajian dalam keperawatan jiwa merupakan langkah awal esensial untuk memahami secara mendalam kondisi pasien. Proses pengkajian ini mencakup wawancara klinis mendalam, observasi perilaku pasien secara sistematis, serta penggunaan instrumen standar seperti Mental Status Examination (MSE), skala penilaian depresi (PHQ-9), ansietas (GAD-7), dan instrumen spesifik lainnya sesuai kebutuhan pasien. Data yang dikumpulkan meliputi aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, spiritual, dan latar belakang lingkungan pasien. Diagnosis keperawatan jiwa ditetapkan melalui analisis komprehensif terhadap data yang terkumpul, dengan merujuk pada klasifikasi diagnosis keperawatan standar seperti North American Nursing Diagnosis Association-International (NANDA-I).

2. Perencanaan dan Implementasi Intervensi Keperawatan Jiwa Berbasis Bukti

Setelah diagnosis keperawatan jiwa ditentukan, perawat merancang rencana intervensi yang terstruktur, spesifik, dan berorientasi pada hasil terapeutik. Rencana intervensi ini disusun berdasarkan prinsip evidence-based practice (EBP), yaitu penggunaan hasil penelitian terbaru dan terbukti efektif

dalam praktik klinis. Jenis intervensi yang umum digunakan dalam keperawatan jiwa meliputi:

- a. Terapi Komunikasi Terapeutik: Berfokus pada interaksi efektif antara perawat dan pasien untuk membangun hubungan terapeutik yang mendukung proses pemulihan.
- b. Terapi Perilaku Kognitif (CBT): Berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku maladaptif melalui teknik restrukturisasi kognitif dan modifikasi perilaku.
- c. Terapi Kelompok dan Dukungan Sosial: Menggunakan kelompok sebagai media untuk berbagi pengalaman, dukungan emosional, serta pengembangan keterampilan interpersonal dan sosial.
- d. Intervensi Krisis: Bertujuan memberikan dukungan segera dalam situasi krisis untuk mencegah eskalasi kondisi pasien.

Implementasi intervensi dilakukan secara konsisten dengan dokumentasi teliti guna memastikan efektivitas dan kontinuitas perawatan.

3. Evaluasi dan Dokumentasi Hasil Intervensi

Evaluasi dalam keperawatan jiwa dilakukan untuk menilai progres pasien terhadap tujuan perawatan yang telah ditentukan. Evaluasi mencakup pemantauan perubahan gejala, perilaku, kondisi psikososial, dan kualitas hidup pasien secara berkala. Hasil evaluasi kemudian dibandingkan dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumentasi hasil intervensi sangat penting sebagai catatan perkembangan pasien, dasar pengambilan keputusan klinis, serta memenuhi kebutuhan komunikasi antar anggota tim multidisiplin maupun kepatuhan terhadap aspek hukum dan administratif.

4. Model Pelayanan Klinis (Case Management dan Collaborative Care)

Dalam keperawatan jiwa, terdapat beberapa model pelayanan klinis efektif yang sering diterapkan, di antaranya:

- a. Case Management: Menempatkan perawat sebagai manajer kasus yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, implementasi, dan evaluasi layanan kesehatan jiwa secara menyeluruh. Model ini memastikan bahwa setiap kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal melalui koordinasi antar disiplin, pemberdayaan pasien dan keluarga, serta advokasi hak-hak pasien.
- b. Collaborative Care: Mengintegrasikan pelayanan kesehatan jiwa dengan keterlibatan berbagai profesional seperti perawat jiwa, psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan dokter umum. Collaborative care menekankan pentingnya komunikasi terbuka, kolaborasi tim yang efektif, serta pendekatan terpadu untuk menangani kompleksitas kebutuhan pasien. Model ini terbukti

meningkatkan kepuasan pasien, mempercepat pemulihan, dan mengurangi risiko kekambuhan.

Kedua model ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan jiwa, serta kerja sama antarprofesi dalam mencapai hasil perawatan yang optimal.

C. Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa di Komunitas

1. Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier Gangguan Jiwa di Komunitas

Manajemen pelayanan keperawatan jiwa di komunitas mengadopsi pendekatan pencegahan yang terdiri dari tiga tingkatan utama, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilaksanakan sebelum munculnya gangguan jiwa, bertujuan mengurangi faktor risiko melalui program promosi kesehatan mental, edukasi gaya hidup sehat, serta peningkatan resiliensi individu dan komunitas. Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini gangguan jiwa dengan mengadakan skrining rutin di komunitas, serta pemberian intervensi dini berupa konseling atau terapi singkat guna mencegah progresivitas gangguan jiwa. Pencegahan tersier ditujukan pada individu yang telah mengalami gangguan jiwa, bertujuan mencegah kekambuhan, memperbaiki fungsi sosial pasien, dan meningkatkan kualitas hidup melalui rehabilitasi sosial, terapi lanjutan, dan dukungan komunitas yang kontinu.

2. Edukasi Kesehatan Mental Komunitas

Edukasi kesehatan mental komunitas adalah bagian integral dalam pelayanan keperawatan jiwa, bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta sikap positif masyarakat terhadap isu-isu kesehatan mental. Perawat jiwa bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan materi edukasi yang mencakup pengenalan berbagai jenis gangguan jiwa, identifikasi gejala awal, serta informasi akses layanan kesehatan mental. Pelaksanaan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti lokakarya, seminar, diskusi kelompok, kampanye melalui media sosial, dan penyebaran brosur serta pamflet. Efektivitas edukasi sangat bergantung pada pendekatan yang inklusif, interaktif, dan sensitif terhadap budaya lokal serta karakteristik komunitas setempat.

3. Deteksi Dini dan Intervensi Awal Gangguan Jiwa

Deteksi dini merupakan strategi esensial dalam manajemen pelayanan keperawatan jiwa di komunitas, karena semakin dini gangguan jiwa terdeteksi, semakin tinggi potensi pemulihan optimal. Proses deteksi dini dilakukan melalui penggunaan instrumen skrining terstandar, seperti Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), dan Patient Health Questionnaire (PHQ-9), serta instrumen lain sesuai dengan kondisi spesifik yang

ingin diidentifikasi. Setelah terdeteksi, intervensi awal yang mencakup konseling individu, psikoedukasi, terapi singkat, serta rujukan spesialis jika diperlukan, segera diberikan. Tujuan utama intervensi dini adalah untuk mengurangi tingkat keparahan gejala, mencegah komplikasi, serta memfasilitasi pemulihan pasien secara dini dan efektif.

4. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Pasien Jiwa

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan tahap penting dalam manajemen keperawatan jiwa di komunitas, bertujuan memulihkan kemampuan fungsional pasien dan mendukung pemulihan yang berkelanjutan. Rehabilitasi mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan keterampilan sosial, mengelola gejala, serta keterampilan hidup sehari-hari melalui terapi okupasi, terapi kelompok, pelatihan vokasional, dan dukungan psikososial secara konsisten.

Reintegrasi sosial bertujuan membantu pasien jiwa kembali aktif dan produktif dalam masyarakat. Langkah ini melibatkan keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, mengurangi stigma sosial, serta meningkatkan partisipasi pasien dalam aktivitas komunitas. Program reintegrasi yang efektif antara lain kelompok dukungan komunitas, program kewirausahaan untuk pasien, dan kampanye antistigma yang aktif dan melibatkan berbagai pihak komunitas.

D. Keterampilan Manajerial dalam Keperawatan Jiwa

1. Komunikasi Terapeutik dan Interpersonal

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan mendasar yang harus dimiliki oleh perawat jiwa dalam menjalin hubungan yang efektif dengan pasien. Komunikasi ini berfokus pada interaksi yang dirancang khusus untuk mendukung proses penyembuhan dan pemulihan pasien. Keterampilan ini melibatkan kemampuan mendengarkan aktif, memberikan respons empatik, menjaga sikap terbuka dan menghormati privasi serta martabat pasien. Komunikasi terapeutik juga mencakup penggunaan teknik seperti klarifikasi, refleksi, restating, serta umpan balik positif. Selain itu, keterampilan interpersonal yang kuat memungkinkan perawat untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dengan tim multidisiplin, keluarga pasien, dan komunitas.

2. Kepemimpinan dan Koordinasi Tim Multidisiplin

Kepemimpinan dalam keperawatan jiwa melibatkan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, serta memotivasi tim multidisiplin dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dalam konteks ini harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling mendukung, dengan memastikan

komunikasi yang jelas, koordinasi tugas yang efisien, serta pengembangan kompetensi tim secara berkelanjutan. Koordinasi tim multidisiplin meliputi integrasi peran dari berbagai profesional seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, terapis okupasi, dan petugas kesehatan lainnya untuk memastikan pelayanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan bagi pasien jiwa.

3. Manajemen Konflik dan Pengambilan Keputusan

Konflik merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam praktik keperawatan jiwa, baik di antara anggota tim, pasien, maupun keluarga pasien. Keterampilan dalam manajemen konflik sangat penting untuk mempertahankan suasana kerja yang kondusif dan memastikan pelayanan optimal bagi pasien. Manajemen konflik melibatkan kemampuan dalam mengidentifikasi sumber konflik, mendengarkan semua pihak yang terlibat, menggunakan teknik mediasi, negosiasi, serta mencari solusi yang memuaskan semua pihak.

Pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan jiwa membutuhkan pertimbangan yang cermat, berbasis bukti, dan berorientasi pada kepentingan terbaik pasien. Keputusan harus didasarkan pada analisis data, standar klinis, prinsip etika, serta pengalaman klinis perawat. Proses ini juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis, analisis risiko dan manfaat, serta keterampilan kolaborasi dengan tim multidisiplin untuk memastikan keputusan yang tepat dan efektif.

4. Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial dalam keperawatan jiwa mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk menjalankan fungsi manajemen secara efisien dan efektif. Kompetensi ini meliputi perencanaan strategis pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia dan finansial, pengaturan logistik dan sumber daya material, serta evaluasi kinerja layanan secara berkala. Perawat jiwa yang memiliki kompetensi manajerial mampu menyusun rencana kerja yang realistis, mengimplementasikan kebijakan yang mendukung efektivitas pelayanan, mengelola perubahan secara efektif, serta melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara kontinu. Selain itu, kompetensi ini juga mencakup keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi, pengelolaan data, serta kemampuan dalam merancang program peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan jiwa lainnya.

E. Evaluasi Efektivitas Pelayanan Keperawatan Jiwa

1. Indikator Evaluasi (Kepuasan Pasien, Hasil Intervensi)

Evaluasi efektivitas pelayanan keperawatan jiwa bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan berhasil mencapai tujuan terapeutik yang

telah ditetapkan. Indikator utama dalam evaluasi ini adalah kepuasan pasien dan hasil intervensi. Kepuasan pasien mencerminkan persepsi pasien terhadap kualitas layanan yang diterima, meliputi aspek interpersonal, akses pelayanan, kualitas komunikasi, kenyamanan fisik, serta rasa aman selama menerima pelayanan. Hasil intervensi mencakup peningkatan kondisi klinis pasien, seperti pengurangan gejala gangguan jiwa, peningkatan kemampuan fungsional, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Evaluasi menggunakan indikator ini memungkinkan perawat jiwa untuk mengidentifikasi kekuatan serta area yang membutuhkan perbaikan dalam pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

2. Metode Evaluasi (Audit Klinis, Survei Kepuasan)

Dalam melaksanakan evaluasi efektivitas pelayanan keperawatan jiwa, terdapat beberapa metode yang umum digunakan, antara lain audit klinis dan survei kepuasan pasien. Audit klinis adalah metode evaluasi yang sistematis dan kritis terhadap kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar klinis yang ditetapkan. Proses audit melibatkan pemeriksaan dokumentasi rekam medis, pengamatan langsung terhadap pelayanan yang diberikan, serta wawancara dengan tim pelayanan kesehatan. Audit klinis bertujuan mengidentifikasi kesesuaian pelayanan dengan pedoman klinis, menemukan kesenjangan praktik yang terjadi, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan layanan.

Survei kepuasan pasien merupakan metode evaluasi lain yang secara khusus menilai persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan. Survei ini biasanya dilakukan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan terkait aspek pelayanan seperti kemudahan akses, kualitas komunikasi, waktu tunggu, fasilitas, dan responsivitas staf terhadap kebutuhan pasien. Hasil survei ini memberikan wawasan langsung mengenai tingkat kepuasan pasien, serta menjadi masukan penting dalam peningkatan kualitas layanan.

3. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang diperoleh melalui audit klinis dan survei kepuasan pasien harus dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan jiwa. Pemanfaatan hasil evaluasi mencakup beberapa langkah penting, yaitu analisis data secara menyeluruh untuk memahami akar permasalahan, mengidentifikasi prioritas area yang memerlukan perbaikan segera, serta merancang intervensi atau program perbaikan yang berbasis data.

Selain itu, hasil evaluasi ini juga digunakan untuk pengembangan kebijakan pelayanan, pelatihan staf kesehatan jiwa, serta perencanaan strategis yang lebih luas dalam pelayanan kesehatan mental. Komunikasi hasil evaluasi kepada

seluruh anggota tim pelayanan, pimpinan institusi, serta stakeholder eksternal juga penting agar seluruh pihak terlibat aktif dalam proses peningkatan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, pemanfaatan hasil evaluasi secara optimal akan meningkatkan kepuasan pasien, hasil klinis yang lebih baik, serta efisiensi sumber daya dalam pelayanan keperawatan jiwa.

F. Kolaborasi Interprofesional dan Komunitas

1. Pentingnya Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional dalam pelayanan keperawatan jiwa merupakan komponen penting yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan. Gangguan jiwa adalah kondisi kompleks yang sering memerlukan penanganan multidimensi yang tidak dapat dipenuhi oleh satu profesi saja. Oleh karena itu, kolaborasi antar profesional kesehatan seperti perawat, dokter, psikolog, pekerja sosial, farmasis, ahli gizi, dan terapis okupasi menjadi esensial. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan berkelanjutan dalam penanganan pasien.

Kolaborasi interprofesional juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antar anggota tim, mengurangi potensi kesalahan klinis, serta meningkatkan kepuasan pasien melalui layanan yang terkoordinasi secara baik. Selain itu, kolaborasi ini dapat mengurangi beban kerja individu dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung, yang secara keseluruhan akan meningkatkan kualitas layanan keperawatan jiwa.

2. Strategi Membangun Kolaborasi

Membangun kolaborasi interprofesional yang efektif memerlukan strategi yang direncanakan dengan matang dan implementasi yang konsisten. Strategi ini meliputi:

- a. **Pelatihan Bersama:** Mengadakan pelatihan reguler yang diikuti oleh semua anggota tim profesional, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap peran masing-masing, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta memperluas wawasan mengenai pendekatan kolaboratif.
- b. **Pengembangan Komunikasi yang Efektif:** Menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antar anggota tim melalui rapat multidisiplin, diskusi kasus bersama, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi kesehatan terpadu.
- c. **Penyusunan Protokol Kolaborasi:** Merancang dan menerapkan protokol kolaborasi yang jelas dan spesifik yang mengatur tugas, tanggung jawab, serta alur koordinasi antar profesi dalam menangani pasien.

- d. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi terhadap proses kolaborasi secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi praktis yang memungkinkan peningkatan secara berkelanjutan.
- e. Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap upaya kolaborasi yang berhasil untuk mendorong budaya kerja kolaboratif.

3. Peran Komunitas dalam Pelayanan

Komunitas memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan keperawatan jiwa, terutama dalam konteks dukungan sosial, pemulihan, dan reintegrasi pasien. Komunitas tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya eksternal tetapi juga sebagai lingkungan terapeutik yang mendukung proses pemulihan. Komunitas dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan edukasi kesehatan mental kepada anggotanya, membantu identifikasi dini gejala gangguan jiwa, serta mendukung pelaksanaan intervensi awal.

Selain itu, komunitas dapat membentuk jejaring dukungan berupa kelompok support, pusat rehabilitasi berbasis komunitas, dan program reintegrasi sosial yang membantu pasien kembali menjalani kehidupan normal. Komunitas juga berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa melalui kegiatan promosi kesehatan mental dan advokasi sosial.

4. Model Kolaborasi

Dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan jiwa, terdapat beberapa model kolaborasi yang terbukti efektif, antara lain:

- a. Model Tim Interdisipliner: Model ini melibatkan tim profesional yang bekerja bersama secara intensif dalam setiap tahapan pelayanan. Anggota tim berbagi informasi secara rutin, merencanakan dan mengevaluasi intervensi secara bersama-sama untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.
- b. Model Konsultasi dan Liaison: Dalam model ini, perawat jiwa bertindak sebagai konsultan yang memberikan layanan konsultasi dan dukungan spesifik kepada tim kesehatan lain, khususnya dalam pengelolaan pasien dengan gangguan jiwa yang memiliki kondisi medis lainnya.
- c. Model Collaborative Care: Model ini berfokus pada integrasi layanan kesehatan mental ke dalam layanan kesehatan primer. Tim collaborative care biasanya terdiri dari perawat jiwa, dokter umum, psikolog, dan pekerja sosial yang bekerja secara sinergis untuk memberikan layanan terpadu dan berkelanjutan kepada pasien.

Implementasi model kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan akan sangat membantu dalam mencapai tujuan terapeutik secara optimal, meningkatkan kepuasan pasien, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

G. Tantangan dan Solusi dalam Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa

1. Tantangan Manajemen di Klinik dan Komunitas

Manajemen pelayanan keperawatan jiwa di klinik dan komunitas menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan utama yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan mental, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa. Di lingkungan klinik, tantangan yang sering dihadapi adalah beban kerja tinggi akibat jumlah pasien yang banyak, keterbatasan tenaga kesehatan profesional yang khusus menangani masalah kesehatan jiwa, dan kurangnya dukungan administratif serta finansial untuk layanan keperawatan jiwa.

Di komunitas, tantangan yang muncul antara lain stigma negatif terhadap pasien dengan gangguan jiwa, hambatan geografis dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pasien.

2. Strategi dan Solusi Menghadapi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi dan solusi inovatif yang efektif. Strategi ini mencakup:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan reguler, pendidikan berkelanjutan, dan workshop untuk meningkatkan kompetensi profesional tenaga kesehatan jiwa, serta mengembangkan program mentoring dan supervisi untuk mendukung staf baru.
- b. Penguatan Infrastruktur Pelayanan: Menambah dan memperbaiki fasilitas klinik serta menyediakan alat bantu diagnostik dan terapi yang memadai. Di komunitas, mengembangkan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang lebih terjangkau dan mudah diakses, seperti layanan kesehatan jiwa bergerak (*mobile mental health service*).
- c. Program Edukasi dan Advokasi: Melaksanakan program edukasi kesehatan mental secara luas untuk mengurangi stigma negatif dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap gangguan jiwa, serta advokasi kebijakan kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan proaktif.

- d. Kolaborasi dengan Berbagai Sektor: Menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk memperluas cakupan layanan dan dukungan kepada pasien jiwa.
- e. Optimalisasi Manajemen Keuangan dan Administrasi: Mengelola sumber daya secara efektif melalui perencanaan anggaran yang matang, penggalangan dana, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi layanan.

3. Studi Kasus Penerapan Solusi

Sebagai gambaran konkret penerapan solusi di atas, berikut adalah studi kasus di suatu wilayah pedesaan yang menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan keperawatan jiwa. Wilayah ini memiliki tingkat stigma yang tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan mental terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan jiwa.

Dalam merespons tantangan tersebut, perawat jiwa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemerintah lokal, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengimplementasikan program terpadu. Program ini meliputi pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal tentang keterampilan manajerial dan klinis, pengadaan unit pelayanan kesehatan jiwa keliling (*mobile mental health unit*), serta pelaksanaan kampanye edukasi kesehatan mental yang melibatkan berbagai media lokal dan pertemuan komunitas.

Setelah program berjalan selama dua tahun, evaluasi menunjukkan hasil positif berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa, penurunan stigma sosial, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi pasien jiwa. Program ini juga berhasil menarik perhatian pemerintah daerah untuk memberikan dukungan lebih lanjut dalam bentuk alokasi anggaran tambahan serta kebijakan yang mendukung pengembangan layanan kesehatan jiwa di komunitas.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis komunitas mampu secara signifikan mengatasi berbagai tantangan dalam manajemen pelayanan keperawatan jiwa, baik di klinik maupun di komunitas, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi pasien dan keluarganya.

H. Tugas

1. Buatlah sebuah esai yang membahas secara mendalam mengenai konsep dasar manajemen pelayanan keperawatan jiwa, dengan cakupan sebagai berikut:
 - Definisi manajemen pelayanan keperawatan jiwa secara komprehensif.

- Ruang lingkup manajemen pelayanan keperawatan jiwa di berbagai tatanan pelayanan (klinik dan komunitas).
 - Jelaskan secara rinci prinsip-prinsip utama manajemen keperawatan jiwa, sertakan contoh aplikatifnya dalam praktik klinis.
2. Buatlah analisis kasus yang mengilustrasikan peran dan tanggung jawab perawat jiwa profesional dalam praktik klinis. Kasus harus menggambarkan minimal 3 dari 6 peran berikut:
- Caregiver
 - Koordinator tim
 - Edukator
 - Advokat
 - Konsultan
 - Peneliti
- Analisis harus menyertakan identifikasi peran, implementasi nyata dalam kasus, dan dampak peran tersebut terhadap hasil pelayanan kesehatan jiwa pasien.
3. Susunlah laporan implementasi intervensi keperawatan jiwa berbasis bukti pada kasus pasien dengan gangguan depresi. Dalam laporan tersebut, Anda harus mencakup:
- Pengkajian pasien menggunakan instrumen standar (MSE, PHQ-9)
 - Diagnosis keperawatan menggunakan klasifikasi NANDA-I
 - Rencana intervensi berbasis Evidence-Based Practice (EBP)
 - Dokumentasi implementasi dan evaluasi hasil intervensi secara detail dan sistematis
4. Rancanglah sebuah program pencegahan gangguan jiwa di komunitas dengan pendekatan primer, sekunder, dan tersier. Desain program harus mencakup:
- Deskripsi komunitas sasaran
 - Strategi kegiatan pencegahan primer, sekunder, dan tersier secara rinci
 - Metode evaluasi efektivitas program
5. Susunlah protokol kolaborasi interprofesional dalam pelayanan keperawatan jiwa yang dapat diimplementasikan secara praktis. Protokol tersebut harus mencakup:
- Identifikasi anggota tim multidisiplin
 - Peran dan tanggung jawab masing-masing profesi secara spesifik
 - Strategi komunikasi efektif antar tim
 - Peran komunitas dalam mendukung pelaksanaan kolaborasi ini
 - Evaluasi implementasi protokol kolaborasi

I. Latihan Soal

1. Seorang pasien perempuan, 27 tahun, datang ke klinik keperawatan jiwa dengan keluhan merasa cemas berlebihan sejak satu bulan terakhir. Pasien mengatakan sulit tidur, sering mengalami palpitasi, dan menarik diri dari interaksi sosial. Sebagai perawat jiwa profesional, tindakan awal apa yang paling tepat untuk dilakukan?
 - A. Melakukan edukasi tentang gangguan kecemasan
 - B. Merujuk pasien ke psikiater segera
 - C. Melakukan pengkajian secara mendalam menggunakan instrumen baku (MSE dan GAD-7)
 - D. Memulai terapi kelompok untuk dukungan sosial
 - E. Memberikan intervensi krisis

Jawaban: C

Pembahasan:

Langkah awal dalam pelayanan keperawatan jiwa adalah melakukan pengkajian yang komprehensif menggunakan instrumen standar seperti MSE (Mental Status Examination) dan GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) untuk mendapatkan gambaran klinis yang lengkap sebelum menentukan diagnosis dan intervensi yang tepat.

2. Anda seorang perawat jiwa yang ditugaskan sebagai koordinator tim multidisiplin di sebuah klinik kesehatan jiwa. Selama rapat rutin, terjadi ketegangan antara psikolog dan pekerja sosial karena perbedaan pandangan tentang metode intervensi. Tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan dalam menghadapi situasi ini?
 - A. Mendukung pandangan psikolog karena lebih berbasis bukti
 - B. Mengabaikan konflik karena dianggap biasa dalam tim multidisiplin
 - C. Meminta kedua pihak berhenti berdiskusi
 - D. Melakukan mediasi untuk menemukan solusi terbaik
 - E. Melaporkan situasi kepada atasan agar diberikan sanksi

Jawaban: D

Pembahasan:

Sebagai koordinator tim, perawat jiwa harus memiliki keterampilan manajemen konflik yang baik. Tindakan mediasi diperlukan untuk mendengar pandangan dari kedua belah pihak, menemukan titik tengah, dan merumuskan solusi yang dapat diterima semua anggota tim untuk mendukung kolaborasi yang efektif.

3. Seorang pasien laki-laki berusia 35 tahun telah selesai menjalani rehabilitasi di klinik keperawatan jiwa dan siap kembali ke komunitas. Keluarga pasien khawatir pasien akan mengalami stigma negatif di masyarakat. Langkah apa yang paling efektif yang harus dilakukan perawat jiwa dalam situasi ini?
- A. Menyusun program reintegrasi sosial berbasis komunitas
 - B. Merujuk pasien untuk tinggal permanen di pusat rehabilitasi
 - C. Menyarankan keluarga untuk membatasi interaksi pasien dengan masyarakat
 - D. Memberikan edukasi terbatas hanya kepada keluarga inti
 - E. Menghindari kontak dengan masyarakat luas

Jawaban: A

Pembahasan:

Program reintegrasi sosial berbasis komunitas merupakan pendekatan terbaik untuk membantu pasien kembali aktif dan produktif dalam masyarakat. Program ini dapat mengurangi stigma negatif melalui edukasi kesehatan mental di komunitas, kelompok dukungan, dan partisipasi aktif keluarga serta lingkungan sosial pasien.

4. Dalam sebuah evaluasi audit klinis di klinik kesehatan jiwa, ditemukan bahwa dokumentasi keperawatan belum memenuhi standar praktik keperawatan psikiatri. Sebagai seorang manajer pelayanan keperawatan jiwa, tindakan manajerial apa yang paling tepat Anda lakukan?
- A. Menghukum secara administratif perawat yang melakukan kesalahan
 - B. Membuat pelatihan dokumentasi keperawatan secara berkala
 - C. Mengabaikan temuan karena dianggap tidak signifikan
 - D. Menyusun ulang struktur organisasi tim keperawatan
 - E. Mengurangi jumlah staf karena dianggap tidak kompeten

Jawaban: B

Pembahasan:

Tindakan yang tepat adalah menyusun program pelatihan berkala tentang dokumentasi keperawatan, yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kepatuhan terhadap standar praktik keperawatan psikiatri. Hal ini merupakan wujud implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara kontinu.

5. Seorang pasien perempuan, 40 tahun, mengalami depresi berat dan telah menjalani intervensi keperawatan selama 3 bulan. Saat dilakukan survei kepuasan pasien, ditemukan bahwa pasien merasa kurang puas dengan interaksi dan komunikasi selama perawatan. Langkah evaluasi apa yang paling tepat dilakukan perawat jiwa terhadap hasil survei ini?

- A. A. Menyalahkan pasien karena memiliki ekspektasi tinggi
- B. B. Melakukan evaluasi ulang proses komunikasi terapeutik yang digunakan
- C. C. Menghentikan survei karena dianggap tidak akurat
- D. D. Mengurangi waktu interaksi perawat dengan pasien
- E. E. Mengabaikan hasil survei karena pasien sudah menunjukkan perbaikan klinis

Jawaban: B

Pembahasan:

Hasil survei kepuasan pasien perlu dianalisis secara kritis untuk memperbaiki kualitas layanan. Evaluasi terhadap metode komunikasi terapeutik perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab ketidakpuasan pasien, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam interaksi terapeutik, sesuai prinsip patient-centered care dan continuous quality improvement.

J. Rangkuman materi

Manajemen pelayanan keperawatan jiwa adalah proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai hasil terapi yang efektif. Ruang lingkupnya mencakup promosi kesehatan mental, pencegahan gangguan jiwa, diagnosis dini, intervensi terapeutik, serta rehabilitasi hingga reintegrasi sosial. Pelayanan ini dilakukan di berbagai tatanan seperti rumah sakit, pusat rehabilitasi, dan komunitas dengan penggunaan sumber daya secara efisien serta integrasi peran profesional dari berbagai disiplin ilmu.

Perawat jiwa memiliki peran penting dalam memberikan asuhan langsung, melakukan pengkajian mendalam, menentukan diagnosis, menyusun rencana intervensi, serta mengevaluasi hasil intervensi. Selain itu, perawat juga berperan sebagai koordinator tim multidisiplin yang memastikan komunikasi efektif antar profesional seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan terapis lainnya. Sebagai edukator, perawat bertugas memberikan informasi mengenai gangguan jiwa kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Perawat juga menjalankan peran advokasi untuk memastikan hak pasien terpenuhi serta menjadi konsultan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa. Di sisi lain, perawat aktif melakukan penelitian berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Prinsip utama dalam manajemen pelayanan keperawatan jiwa antara lain menempatkan pasien sebagai pusat perhatian (patient-centered care), menerapkan pendekatan multidisiplin, kolaborasi dan kemitraan dengan pasien, keluarga serta komunitas, menjaga kontinuitas perawatan dari pencegahan hingga rehabilitasi, menjalankan praktik berbasis bukti, mengutamakan efektivitas dan efisiensi, serta mematuhi aspek etika dan hukum dalam praktik keperawatan.

Di lingkungan klinik, proses pengkajian yang sistematis menjadi dasar untuk menentukan diagnosis keperawatan psikiatri dengan bantuan instrumen standar seperti Mental Status Examination (MSE), PHQ-9, dan GAD-7. Setelah diagnosis, perawat menyusun rencana intervensi berbasis bukti, seperti terapi komunikasi terapeutik, terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, dan intervensi krisis. Evaluasi rutin dilakukan untuk memantau perubahan kondisi pasien, dan hasil intervensi didokumentasikan secara teliti sebagai dasar pengambilan keputusan klinis dan komunikasi antar tim. Di klinik, terdapat dua model pelayanan efektif, yaitu case management yang menempatkan perawat sebagai manajer kasus utama dan collaborative care yang mengintegrasikan berbagai profesional kesehatan dalam memberikan layanan terpadu.

Di tingkat komunitas, manajemen keperawatan jiwa berfokus pada pencegahan primer melalui promosi kesehatan mental, pencegahan sekunder melalui deteksi dini dan intervensi awal seperti konseling singkat, serta pencegahan tersier dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pasien ke masyarakat. Edukasi kesehatan mental di komunitas bertujuan meningkatkan pemahaman dan mengubah sikap masyarakat terhadap isu gangguan jiwa. Deteksi dini dilakukan melalui skrining standar, dilanjutkan dengan intervensi awal untuk mencegah komplikasi. Rehabilitasi sosial mencakup pengembangan keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari, serta reintegrasi pasien melalui dukungan komunitas guna mengurangi stigma sosial.

Keterampilan manajerial penting bagi perawat jiwa meliputi komunikasi terapeutik untuk mendukung pemulihan pasien, kepemimpinan dalam memotivasi dan mengelola tim multidisiplin, serta manajemen konflik dengan pendekatan mediasi dan negosiasi. Pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan jiwa harus berdasarkan data klinis, prinsip etika, dan pengalaman klinis. Kompetensi manajerial lainnya meliputi kemampuan dalam perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, evaluasi kinerja layanan secara berkala, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data pelayanan kesehatan jiwa.

Evaluasi efektivitas pelayanan dilakukan melalui audit klinis dan survei kepuasan pasien yang menilai persepsi pasien terhadap layanan serta hasil klinis seperti penurunan gejala dan peningkatan kualitas hidup. Hasil evaluasi digunakan secara optimal untuk mengembangkan kebijakan, menyusun program perbaikan, dan meningkatkan kualitas layanan keperawatan jiwa.

Kolaborasi interprofesional dan peran komunitas menjadi bagian penting dalam manajemen pelayanan kesehatan jiwa, karena gangguan jiwa memerlukan penanganan multidimensi. Kolaborasi ini meningkatkan komunikasi efektif antar tim, mengurangi kesalahan klinis, dan meningkatkan kepuasan pasien. Strategi

membangun kolaborasi antara lain melalui pelatihan bersama, pengembangan komunikasi rutin, protokol kolaborasi yang jelas, evaluasi berkala, serta apresiasi terhadap tim. Komunitas juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan sosial, edukasi kesehatan mental, mendukung deteksi dini serta intervensi awal, hingga proses rehabilitasi pasien.

Tantangan utama dalam pelayanan kesehatan jiwa di klinik dan komunitas antara lain keterbatasan SDM, fasilitas yang tidak memadai, serta stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur pelayanan, program edukasi dan advokasi kesehatan mental, serta menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperluas cakupan layanan. Sebuah studi kasus di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi dan kolaboratif yang melibatkan komunitas mampu meningkatkan aksesibilitas layanan, mengurangi stigma, serta memperbaiki partisipasi masyarakat dalam mendukung pemulihan pasien, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif bagi pasien jiwa dan keluarganya.

K. Glosarium

Advokat: Peran perawat yang membela dan memastikan hak-hak pasien terpenuhi dalam pelayanan kesehatan jiwa.

Audit Klinis: Proses evaluasi sistematis terhadap pelayanan kesehatan dengan membandingkan praktik klinis yang ada dengan standar atau pedoman yang berlaku.

Case Management: Model pelayanan keperawatan yang menempatkan perawat sebagai pengelola kasus yang bertanggung jawab dalam koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan jiwa secara terpadu.

Collaborative Care: Model pelayanan yang melibatkan integrasi berbagai profesi kesehatan, seperti perawat jiwa, psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan dokter umum dalam memberikan pelayanan yang terpadu untuk pasien.

Deteksi Dini: Strategi identifikasi awal gangguan jiwa melalui penggunaan instrumen skrining yang terstandarisasi untuk memudahkan intervensi lebih cepat.

Diagnosis Keperawatan Psikiatri: Penetapan masalah kesehatan mental pasien berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pengkajian menggunakan pedoman diagnosis keperawatan seperti NANDA-I.

Edukasi Kesehatan Mental Komunitas: Upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa melalui metode penyuluhan, kampanye, dan berbagai media interaktif lainnya.

Evaluasi Pelayanan Keperawatan Jiwa: Proses penilaian sistematis terhadap efektivitas intervensi keperawatan jiwa dengan menggunakan indikator seperti kepuasan pasien dan hasil klinis.

Evidence-Based Practice (EBP): Praktik klinis yang menggunakan bukti ilmiah terbaru sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan intervensi keperawatan.

Intervensi Krisis: Tindakan segera yang dilakukan dalam situasi darurat untuk mencegah eskalasi gangguan mental pasien.

Intervensi Terapeutik: Tindakan yang dirancang khusus untuk memperbaiki kondisi mental pasien, seperti terapi komunikasi terapeutik, terapi perilaku kognitif, atau terapi kelompok.

Kepemimpinan dalam Keperawatan Jiwa: Kemampuan perawat dalam mengarahkan, mengelola, dan memotivasi tim multidisiplin untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan jiwa yang optimal.

Kolaborasi Interprofesional: Kerjasama antar berbagai disiplin ilmu dan profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang komprehensif dan holistik.

Komunikasi Terapeutik: Teknik komunikasi khusus antara perawat dan pasien yang bertujuan untuk mendukung proses pemulihan mental pasien melalui interaksi yang empatik dan mendukung.

Kompetensi Manajerial: Kumpulan keterampilan dan pengetahuan perawat dalam merencanakan, mengorganisasi, mengelola sumber daya, serta mengevaluasi kinerja layanan keperawatan jiwa secara efektif.

Kontinuitas Perawatan: Penjaminan kesinambungan pelayanan mulai dari tahap pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Manajemen Konflik: Proses identifikasi, mediasi, negosiasi, dan resolusi perselisihan atau ketidaksepakatan yang muncul dalam konteks pelayanan keperawatan jiwa.

Manajemen Pelayanan Keperawatan Jiwa: Proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa.

Mental Status Examination (MSE): Instrumen standar untuk mengevaluasi fungsi mental pasien secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, emosional, dan perilaku.

Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier: Tingkatan pencegahan gangguan jiwa yang meliputi tindakan pencegahan sebelum gangguan muncul (primer), deteksi dan intervensi awal (sekunder), serta rehabilitasi dan pencegahan kekambuhan (tersier).

Pengkajian dalam Keperawatan Jiwa: Proses pengumpulan data secara sistematis untuk memahami kondisi pasien melalui wawancara, observasi, dan instrumen penilaian terstandar.

Peneliti (Peran Perawat Jiwa): Peran perawat jiwa dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan bukti ilmiah.

Rehabilitasi Sosial: Upaya pemulihan fungsi sosial pasien gangguan jiwa melalui berbagai intervensi yang meliputi terapi okupasi, terapi kelompok, pelatihan keterampilan sosial, dan dukungan komunitas.

Reintegrasi Sosial: Proses yang membantu pasien kembali beraktivitas secara normal di masyarakat dengan dukungan keluarga dan komunitas serta upaya mengurangi stigma sosial.

Survei Kepuasan Pasien: Metode evaluasi pelayanan melalui pengumpulan data langsung dari pasien mengenai kualitas dan kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diterima.

Terapi Perilaku Kognitif (CBT): Metode terapi psikologis yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif pasien menjadi lebih adaptif melalui restrukturisasi kognitif dan modifikasi perilaku.

L. Daftar pustaka

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Publishing.
- Boyd, M. A., & Luebbert, R. A. (2019). *Psychiatric Nursing: Contemporary Practice* (6th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Fortinash, K. M., & Worret, P. A. H. (2021). *Psychiatric Mental Health Nursing* (6th ed.). Elsevier.
- Halcomb, E., Smyth, E., & McInnes, S. (2018). Job satisfaction and career intentions of registered nurses in primary health care: An integrative review. *BMC Family Practice*, 19(1), 136. <https://doi.org/10.1186/s12875-018-0819-1>
- Halter, M. J. (2021). *Vancouver's Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Happell, B., Platania-Phung, C., & Scott, D. (2019). Rural mental health workforce challenges: A systematic review. *Issues in Mental Health Nursing*, 40(9), 751–761. <https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1585493>
- NANDA International. (2021). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2021–2023* (12th ed.). Thieme Publishers.

- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Stuart, G. W. (2020). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2020). *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice* (10th ed.). F. A. Davis Company.
- Varcarolis, E. M. (2018). *Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: A Communication Approach to Evidence-Based Care* (3rd ed.). Elsevier.
- Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-Mental Health Nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer Health.
- World Health Organization. (2021). *Mental Health Gap Action Programme (mhGAP): Scaling up care for mental, neurological, and substance use disorders*. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*. WHO Press.
- Wright, N., Rowley, E., Chopra, A., Gregoriou, K., & Waring, J. (2021). From admission to discharge in mental health services: A qualitative study of continuity of care. *International Journal of Mental Health Systems*, 15(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s13033-021-00467-8>

PROFIL PENULIS



Ns. Muhammad Khoirul Amin, M.Kep, Sp.Kep.J., Lahir di Magelang, 29 Januari 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan profesi ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 (Magister Keperawatan Jiwa) pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2015. Kemudian mengambil program spesialis keperawatan jiwa di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Dari tahun 2010 hingga saat ini bekerja di Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis mengampu mata kuliah keperawatan jiwa, keperawatan psikiatri, dan komunikasi keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: khoirulamin@ummgl.ac.id
Motto: "be a good person"



Tsuwaibatul Islamiyah, S.Kep., Ns., M.S., Lahir di Nganjuk, 14 April 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada tahun 2011 di Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2019 di National Cheng Kung University Taiwan dan lulus pada tahun 2021 dengan konsentrasi topik terkait Kesehatan Jiwa pada Remaja. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan dari tahun 2024 – sekarang, di Departemen Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.



Ns. Safra Ria Kurniati, M.Kep., lahir di Bengkalis, 07 Mei 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di Stikes Hang Tuah Tanjungpinang mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Keperawatan Psikiatri.
Motto: "Progress Not Perfection"

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Mamnu'ah, M.Kep., Sp.Kep.J., Lahir di Indramayu, pada tahun 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Pada tahun 2002 penulis selesai menempuh Pendidikan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada. Penulis melanjutkan Pendidikan S2 Program Studi Keperawatan Jiwa pada Universitas Indonesia lulus tahun 2008 dan tahun 2010 lulus Spesialis Keperawatan Jiwa. Pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK), Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2019. Bekerja sejak tahun 1996 mulai dari AKPER sampai saat ini menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial, Keperawatan Psikiatri, Biostatistik, dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mamnuaah@unisayogya.ac.id
Motto: "Setelah kesulitan akan ada kemudahan."



Dr. Abdul Ghofur, SKp., M.Kes., Lahir di Kendal, 10 Januari 1971. Pendidikan tertinggi yang telah di tempuh yaitu PSIK-FKUI tahun 1995, Magister Kesehatan di FKKMK-UGM 2024, Doktor Keperawatan di FKKMK UGM 2020. Riwayat pekerjaan diawali menjadi Dosen Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dari tahun 2000. Saat ini penulis menjadi Dosen Keperawatan jiwa untuk Prodi DIII dan DIV keperawatan, Mengajar Metodologi penelitian dan Statistik Kesehatan, mengajar evidence base nursing (EBN) di Prodi DIV keperawatan, mengajar evidence base practice (EBP) di Prodi Diploma IV Anaestesi. Saat ini penulis aktif sebagai reviewer nasional untuk penelitian dan pengabmas untuk Poltekkes Kemenkes. Menjadi peneliti di bidang keilmuan keperawatan jiwa dan perawatan dasar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: abdghofur1071@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Susana Nurtanti, S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Wonogiri, 06 Desember 1982. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Jenjang D3 Keperawatan pada Akademi Keperawatan St. Elisabet Semarang Tahun 2003, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007. Kemudian melanjutkan di program Magister kedokteran keluarga di Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada Tahun 2003 sebagai perawat di RS. St. Elisabeth Semarang. Selanjutnya pada Tahun 2007 sampai dengan sekarang bekerja sebagai dosen di Akper Giri Satria Husada Wonogiri. Penulis mengampu mata kuliah keperawatan jiwa, komunikasi keperawatan dan psikologi. Saat ini penulis sedang studi lanjut di The Philippine Women University Manila Philipina (PWU) Program Doctoral of Nursing (PHDN). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.



Ns. Indana Lazulfa, S.Kep., M.Kep., Lahir di Brebes, 01 Oktober 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi Ners di tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan melanjutkan program magister keperawatan tahun 2021 di Universitas Diponegoro. Riwayat pekerjaan penulis diawali pada tahun 2019 sebagai asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan bergabung dalam departemen keperawatan jiwa. Penulis mengampu mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial, keperawatan psikiatri, dan komunikasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, pengabdian Masyarakat, pengajaran, dan al-Islam kemuhammadiyah, penulis juga aktif dalam publikasi ilmiah, penulisan buku, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email indanalazulfa@ump.ac.id.
Motto : "apa yang kamu pikirkan akan terjadi, maka berpikirlah yang baik dan positif"

Buku "Keperawatan Psikiatri" disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa keperawatan dan perawat profesional dalam memahami serta menerapkan asuhan keperawatan yang efektif bagi klien dengan gangguan jiwa. Buku ini secara sistematis membahas berbagai kondisi psikososial yang umum ditemui, mulai dari klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial, waham dan halusinasi, hingga mereka yang mengalami defisit perawatan diri.

Setiap topik disajikan secara rinci, dilengkapi langkah-langkah intervensi praktis, pendekatan komunikasi terapeutik, serta teknik-teknik spesifik untuk mendukung pemulihan klien. Selain itu, buku ini juga menguraikan konsep recovery secara mendalam, termasuk karakteristiknya, berbagai model pemulihan yang ada, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang suportif bagi klien.

Tidak hanya itu, buku ini turut mengulas terapi modalitas yang sering digunakan dalam pelayanan kesehatan jiwa, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), terapi kelompok, serta intervensi krisis, yang semuanya disajikan secara komprehensif dan berbasis bukti. Pada bagian akhir, buku ini menyajikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa secara profesional baik di setting klinik maupun komunitas, termasuk strategi kolaborasi interprofesional, pengelolaan sumber daya, serta tantangan yang umum dihadapi dan solusinya.

Dengan gaya bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga panduan praktis yang penting untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan psikiatri, baik di lingkungan klinis maupun komunitas.

Buku "Keperawatan Psikiatri" disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa keperawatan dan perawat profesional dalam memahami serta menerapkan asuhan keperawatan yang efektif bagi klien dengan gangguan jiwa. Buku ini secara sistematis membahas berbagai kondisi psikososial yang umum ditemui, mulai dari klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial, waham dan halusinasi, hingga mereka yang mengalami defisit perawatan diri.

Setiap topik disajikan secara rinci, dilengkapi langkah-langkah intervensi praktis, pendekatan komunikasi terapeutik, serta teknik-teknik spesifik untuk mendukung pemulihan klien. Selain itu, buku ini juga menguraikan konsep recovery secara mendalam, termasuk karakteristiknya, berbagai model pemulihan yang ada, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang suportif bagi klien.

Tidak hanya itu, buku ini turut mengulas terapi modalitas yang sering digunakan dalam pelayanan kesehatan jiwa, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), terapi kelompok, serta intervensi krisis, yang semuanya disajikan secara komprehensif dan berbasis bukti. Pada bagian akhir, buku ini menyajikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa secara profesional baik di setting klinik maupun komunitas, termasuk strategi kolaborasi interprofesional, pengelolaan sumber daya, serta tantangan yang umum dihadapi dan solusinya.

Dengan gaya bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga panduan praktis yang penting untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan psikiatri, baik di lingkungan klinis maupun komunitas.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89972-0-6



9

786238

997206